جمهورية العراق
وزارة الصحة

الصحة النفسـية

في الرعاية الصحية الأولية

(الرعاية النفسية الأولية)

تأليف
مجموعة من الخبراء

الإعداد العام
د. اياد نوري فتاح القلمجي

شعبة الصحة النفسية/ دائرة الصحة العامة
الطبعة الثالثة 2016

من هذا الكتاب

لابد لنا بدءاً أن نؤكد أمرين مهمين، الأول هو ان استعراض هذه الاضطرابات النفسية ودراستها يجب أن لا يكون للحكم على المصابين أو ادانتهم أو الانتقاص منهم، فهم مرضى مبتلون ويستحقون الرعاية الطبية.

نؤكد على أهمية وتأثير أسلوب التعامل السليم مع الطفل في مراحل نموه كلها وضرورة إدامة العلاقة الودية بينه وبين مقدمي الرعاية له (الأبوان أو غيرهما) والإعتدال في الإهتمام به وعدم الإفراط بالقلق عليه، والإستجابة الودية لإحتياجاته الأساسية ورغباته المشروعة، والإبتعاد عن العنف في تربيته، والتصرف كقدوة حسنة صادقة أمامه. كل ذلك سيؤدي به الى نمو نفسي سليم ويحصنه ضد الإضطراب النفسي مستقبلاً بإذن الله.

ان العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية يشكلون ثروة كبيرة بصفتهم العددية كقوة بشرية عاملة، وصفاتهم العلمية بدراساتهم الطبية والصحية وبخبراتهم التي اكتسبوها من عملهم في حقل الخدمات الصحية، ويمكنهم بعد تدريبهم بالشكل المناسب أن يقدموا خدمات الرعاية الصحية النفسية ويطورونها لأحسن صورة ممكنة.

جمهورية العراق
وزارة الصحة

الصحة النفسـية

في الرعاية الصحية الأولية

(الرعاية النفسية الأولية)

تأليف
مجموعة من الخبراء

الإعداد العام
د. اياد نوري فتاح القلمجي

شعبة الصحة النفسية/ دائرة الصحة العامة
الطبعة الثالثة 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي
وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ
إِنَّكَ أَنْتَ عَلّامُ الغُيُوب

قبل أن نبدأ

رئيس أطباء اختصاص
أياد نوري فتاح

1- لقد اغفل العالم طويلاً دور الجانب النفسي في تحقيق استقرار ونمو الأفراد والمجتمعات، و لم يعطه مايستحقه من الرعاية والاهتمام حتى العقد الاخير من القرن العشرين و بداية القرن الواحد والعشرين.

2- ويتزايد الاهتمام العالمي بشدة بموضوع الصحة النفسية للانسان واهميتها الكبيرة كعنصر اساس من عناصر الصحة بموجب تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة وبكونها العنصر الأهم الذي لا يمكن ان تتحقق الصحة للفرد او المجتمع بدونه، فلا صحة بدون الصحة النفسية.
(No Health Without Mental Health)

3- في العالم الغربي والمتقدم، قد تطورت القوانين والأنظمة الصحية والعلاقات والخدمات الاجتماعية والمفاهيم والممارسات التربوية، وانماط الحياة وضمان الحريات وغير ذلك مما يكفل توفير الكثير من مستلزمات النمو النفسي السليم للاطفال وبما يتيح للكبار التمتع بحلاوة الصحة النفسية والوقاية من الانحرافات النفسية. ولهذا نرى ان جل اهتمامهم ينصب حالياً على زيادة وتجويد الخدمات المقدمة لرعاية **المرضى النفسيين** بما يكفل اكبر قدر من حرياتهم ويحفظ كراماتهم وحقوقهم الانسانية وبدون تمييز عن اي مريض آخر.

4- اما في الدول النامية فالأمر مختلف إذ أن معظم مستلزمات النمو النفسي السليم للاطفال غير متوفرة او غير كافية، كما وتنتشر فيها عوامل الخطورة على النمو النفسي بشكل كبير؛ مما ينعكس سلبياً على مهاراتهم النفس اجتماعية وعلى ادائهم الاجتماعي في الكبر ويقلل بشدة من قدرات تلك المجتمعات و الدول على التطور والبناء ومجاراة العالم المتقدم.
ومن ناحية اخرى فأن الخدمات المقدمة لرعاية المرضى النفسيين لازالت بعيدة كثيرا عما يتوجب تقديمه لهم ومايستحقونه كأناس خلقهم الله مثل غيرهم ولكنهم ابتلوا بأمراض نفسية.

5- و باختصار شديد فأن الصحة النفسية شأنها شأن الصحة البدنية تحتاج الى:
   a. الوقاية الأولية وتتضمن:
      i. تطوير الصحة النفسية (ومنها الصحة النفس اجتماعية)
      ii. الوقاية من الاضطرابات النفسية
   b. الوقاية الثانوية وتتضمن:
      i. الاكتشاف المبكر للحالات المرضية ومعالجتها بسرعة.
      ii. منع الوفاة والوقاية من المضاعفات المرضية.
   c. الوقاية الثالثية وتتضمن تأهيل المرضى لتسهيل اعادة اندماجهم الأيجابي.

6- في الدول النامية لا تتوفر خدمات الوقاية الأولية عموماً الا على مديات قليلة ومحدودة، كما ان الوقاية الثانوية والثاثية لا زالت ضعيفة القدرات وبحاجة الى كثير من الجهد والمال لتتطور.

7- من اجل ذلك اقرت الامم المتحدة خطتها الستراتيجية لتطوير الصحة النفسية في دول العالم. ومن اهم ماتظمنته الخطة هو ادماج تقديم خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. وسندعو تلك الخدمات (خدمات الرعاية النفسية الأولية)

8- ولكن مالذي تتضمنه الرعاية النفسية الأولية وماهي عناصرها؟؟!! يعتقد الكثيرون ان الرعاية النفسية الأولية هي مجرد اكتشاف المرضى النفسيين ومعالجتهم ومتابعتهم بشكل مناسب، وهذا شيء اساس وجوهري و صحيح الى حد ما، لكنه لايكفي ابداً؛ إذ لابد من تحديد حزمة خدمات اساسية في الرعاية النفسية الأولية ليتسنى للمسؤولين في وزارات الصحة الاسترشاد بها وتطوير خدمات الصحة النفسية بموجبها، وبما يناسب خصوصيات كل دولة ومجتمع. ومن اجل ذلك فقد تم وضع هذا الكتاب ليغطي مواضيع الرعاية النفسية الأولية، و الذي نضعه بكل تواضع بين يديك آملين منه الإفادة مع الاعتذار لأي خطأ أو سهو فيه، وجل من لا يسهو.

المقدمة

عزيزي القارئ

بين يديك الآن الطبعة الثالثة لكتاب الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية، وهي طبعة منقحة و مزيدة عن سابقاتها إذ شملت رعاية الناجين من الكوارث والعنف والصدمات النفسية.

وكان الكتاب قد طبع لأول مرة عام 2000م وشارك في تأليفه مجموعة من أفضل الخبراء آنذاك. واعيد طبعه في عام 2013م، بعد ان قام بمراجعته وتحديثه مجموعة كبيرة من الأطباء الأختصاايين والعاملين الآخرين في مجال الصحة النفسية. وذلك لمواكبة الاهتمام العالمي والاقليمي والمحلي المتزايد بموضوع الصحة النفسية.

حافظ الكتاب على تصميمه الأساس بأن يكون مرجعاً مبسطاً للعاملين في الرعاية الصحية الأولية يمكنهم العودة إليه والاستفادة منه في تقديم خدمات الرعاية النفسية الأولية بشكل جيد. وقد روعي فيه أن يكون شاملاً وموجزاً بأقصى قدر ممكن، وأن يكون بلغة مباشرة وسهلة الفهم بحيث يمكن لذوي المهن الطبية والمهن الصحية والاجتماعية كلهم الاستفادة منه كل بقدر إختصاصه والمهام المطلوبة منه.

المعلومات الموجودة في الكتاب تساعد في تنفيذ أنشطة تطوير الصحة النفسية والوقاية من اضطراباتها بالتنسيق والتكامل مع فعاليات وبرامج الرعاية الصحية الأولية الأخرى. كما تفيد من ناحية ثانية في تحسين قدرات العاملين في مجال التشخيص المبكر والمعالجة المناسبة للاضطربات الشائعة وفي متابعة الحالات

المزمنة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في نشاطات التوعية المختلفة.

ونعيد و نؤكد هنا، ان الفائدة المتوخاة من هذا الكتاب تحصل بعد المشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بالصحة النفسية والتي يتبعها التدريب السريري في العيادة الأستشارية النفسية؛ ومن المؤكد ان الممارسة العملية ستزيد الخبرة بمرور الزمن وتحسن مهارات العاملين في تقديم خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية باذن الله.

والله ولي التوفيق

الرعاية الصحية النفسية الأولية

أقرت منظمة الصحة العالمية ومعظم دول العالم (ومنها العراق) ضرورة اتباع سياسة الرعاية الصحية الأولية لتحقيق الصحة للجميع.
وتتضمن هذه السياسة عناصر متعددة لبلوغ هدفها ومنها تدبير المشاكل الصحية الشائعة. ولو استعرضنا المشاكل الصحية النفسية لوجدناها من أكثر المشاكل شيوعاً وتأثيراً في حياة الأفراد والمجتمعات اذ تبين احصاءات منظمة الصحة العالمية ان أكثر من مليار ونصف المليار شخص يعانون من المشاكل العصبية والنفسية أو الادمان وانحرافات السلوك، بل ان ثلث هذا العدد يعاني من أكثر من مشكلة. وسنذكر هنا بعض الأرقام المقدرة لعدد المصابين ببعض الاضطرابات علماً بأن ثلاثة ارباع المصابين يعيشون في الدول النامية.

القلق	400 مليون انسان
اضطرابات المزاج	340 مليون انسان
اضطرابات الشخصية	250 مليون انسان
التخلف العقلي	60 مليون انسان
الفصام	45 مليون انسان (33 مليون منهم يعيشون في الدول النامية)
الصرع	50 مليون انسان ويزداد بمعدل 2 مليون سنوياً (80% منها في الدول النامية)
التعرض للإساءة الجنسية (للجنسين)	5% - 20%
الإساءة الجسدية للأطفال	25% - 50%
سوء استخدام المواد (التبغ، الكحول، العقاقير)	أكثر من مليار وربع المليار انسان

ولكن القليل جداً فقط من المضطربين نفسياً يُكتَشَفون وتتم معاملتهم كمرضى نفسيين فعلاً عند تقديم الخدمات الصحية لهم، ومثلهم بذلك كجبل الثلج الذي لايرى إلا أعلاه فقط ومعظم حجمه الفعلي مغمور تحت الماء غير منظور.

ان الرعاية النفسية الصحيحة لا تعني تشخيص ومعالجة المرضى فقط، بل تعني الاهتمام بالجانب النفسي لأفراد المجتمع كافة ومراعاته في كل الفعاليات (الوقائية،

العلاجية أو التأهيلية) التي تنفذها المؤسسات الصحية للارتقاء بصحة المجتمع نحو الكمال. ومما يذكر ان الدراسات تشير إلى أن حوالي (200,000,000) طفل من أطفال العالم لا يصلون إلى مستوى التطور النفسي والاجتماعي المناسب والمتوقع لإعمارهم؛ وهذا يبين الحاجة الماسة لأنشطة تعزيز الصحة النفسية والوقاية من اضطراباتها اضافة لرعاية المرضى النفسيين.

ونرجو أن لا يتبادر الى الذهن أن هذا سيكون عبئاً اضافياً لا داع له على المؤسسات الصحية فالعكس هو الصحيح لأنه سيزيد من فاعلية الخدمات الصحية المقدمة وجدواها الاقتصادية ويزيد ثقة الناس وقناعتهم بها وبالتالي يقلل العبء على هذه المؤسسات.

ولكن تقديم الرعاية الصحية النفسية الجيدة يجابه صعوبات كثيرة في الحياة العملية، أهمها:

- قلة عدد المختصين بالطب النفسي والصحة النفسية.
- ضعف قدرات الأطباء العموميين والملاكات الصحية الأخرى بأمور الصحة النفسية.
- لازال كثير من الناس لا يصدقون بوجود الأمراض النفسية وبوجوب معالجتها لدى الأطباء.
- كثير من الناس يعتبر المرض النفسي وصمة عار أو عيباً مما يجعلهم ينكرونه أو يخفونه.
- شحة المعلومات والخبرات لدى العوائل والتربويين والناس عامة بأساليب التعامل النفسي الصحيح مع الأطفال والطلبة بما يؤمن نمواً سليماً وصحة نفسية جيدة لهم.

لكل ماتقدم ولأسباب منطقية كثيرة فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية موضوع تقديم خدمات الصحة النفسية واحداً من العناصر المهمة للرعاية الصحية الأولية وقامت بفعاليات كثيرة لحث الدول ومساعدتها على دمج تقديم الخدمات النفسية الجيدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وذلك للاسباب التالية:

1. ان مراكز الرعاية الصحية اللأولية تستقبل عادة غالبية مراجعي المؤسسات الصحية، وفيها يكون التقييم الأول ومنها تكون الاحالة. وقد أظهرت الدراسات العالمية أن 14% - 35% (وفي بعض الدراسات 60%) من مراجعي العيادات الخارجية يعانون من اضطرابات نفسية أصلاً ولكن معظمهم يشكو

من أعراض بدنية فقط. وغالباً ماتجرى لهم الفحوصات المكلفة وتعطى لهم الأدوية المختلفة وبدون طائل لأنها لا تداوي العلة الحقيقية.

2. ان المراكز موزعة حسب الرقعة الجغرافية، وهذا بمرور الزمن يعطي العاملين في المركز الصحي فرصة أكبر ووقتاً أكثر للتعرف على سكان المنطقة عن كثب مما يتيح اكتشاف الاضطرابات النفسية لديهم مبكراً.
3. ان تشخيص وعلاج ومتابعة الكثير من الامراض النفسية يستدعي التعرف على عائلة المريض، وتزويدهم بالمعارف اللازمة عن المرض لضمان حسن تعاونهم ورعايتهم لمريضهم. وقد يتطلب الأمر احياناً القيام بزيارات منزلية، وعمل ذلك يكون أسهل نسبياً من قبل العاملين في المركز الصحي القريب من مسكن المريض. *(انظر ملحق رقم 1 رجاءاً)*

ماهي عناصر الرعاية الصحية النفسية الأولية؟

يساهم الفريق النفسي في المركز الصحي (الطبيب والملاك المساعد) بصورة فعالة في تقديم الرعاية الصحية النفسية المناسبة، والتي تتضمن تطوير الصحة النفسية، الوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية، الاكتشاف المبكر والعلاج السريع للمرضى، المتابعة والتأهيل. ويتم ذلك من خلال واجبات (عناصر) معينة نذكرها بايجاز فيما يلي: *(انظر ملحق رقم 2 رجاءاً)*

1. **خدمات صحية سريرية مباشرة:** وتشمل

- خدمات الوقاية، وذلك بالتأكد من تنفيذ المركز للخدمات الصحية الوقائية الأخرى والتي تقي أيضاً من الاضطرابات النفسية، مثل تلقيح البنات ضد الحصبة الألمانية، فحص المقبلين على الزواج، متابعة الحالة الصحية للحامل، تغذيتها، تلقيحاتها، تأمين ولادة مأمونة، إكمال تلقيحات الاطفال، اكتشاف ومعالجة أمراض الطفولة وخاصة تلك التي قد تسبب مضاعفات خطيرة بالدماغ (مثل اليرقان والفينل كيتون يوريا) .. والخ.
- الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية الشائعة اذ يؤدي ذلك الى تحسن أكثر ومآل (Prognosis) أحسن. (انظر المخططات العلاجية للأمراض الشائعة)

- معالجة الاضطرابات النفسية البسيطة، الشائعة والطارئة التي ترد للمركز والاحالة العلمية الرصينة للمصابين الى الاختصاصيين عند الحاجة. *(انظر ملحق رقم 7 رجاءاً)*
- متابعة علاج الحالات المرضية المزمنة التي سبق تشخيصها وتم تحديد طريقة علاجها من قبل اختصاصي الطب النفسي.

2. **تقديم خدمات الصحة النفسية المدرسية** بالتعاون مع التربويين وذوى الطلبة في مدارس المنطقة *(انظر ملحق رقم 5 رجاءاً)*

3. **التدريب:** بأقامة الدورات والندوات والمحاضرات المتخصصة للملاكات الصحية العاملة في المركز لزيادة معارفهم ومهاراتهم في هذا الحقل (*وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية)*. كما يشمل التدريب قطاعات المجتمع الأخرى كالمدرسين والقابلات الأهليات ومتطوعي المنظمات الجماهيرية وغيرهم. *(انظر الملاحق 1، 2، 3، 4 و 5 د رجاءاً)*

4. **مكافحة التدخين ومكافحة سوء استخدام المواد.**

5. **مكافحة العنف.** وبضمن ذلك تقديم الرعاية النفسية المناسبة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

6. **رعاية المعرضين للخطورة (المرأة، المراهقون، كبارالسن).**

7. **الرعاية النفسية الأولية للناجين من الكوارث.** ومنهم النازحون والمهجرون.

8. **تقديم خدمات المشاورة والإرشاد والدعم النفسي للمراجعين المحتاجين.** *(انظر ملحق رقم 6 رجاءاً)*

9. **التوعية:** بأمور الصحة النفسية وسبل تحقيقها، الوقاية من اضطراباتها وأسلوب التعامل الصحيح مع المصابين. ويُستَهدَفُ بالتوعية المراجعون، المعلمون، طلبة المدارس، المقبلون على الزواج، الحوامل والأمهات، العوائل عامة وعوائل المرضى بصورة خاصة. (*إن التغيرات الاجتماعية السريعة التي حصلت وتحصل في نمط حياة العائلة (وخاصة الشرقية) تتطلب توعية الأبوين بالأساليب الصحيحة الواجب اتباعها مع الأطفال لتأمين نموهم السليم بدنياً ونفسياً واجتماعياً ووقايتهم من الاضطرابات النفسية (انظرالملاحق 1، 2، 3، 4 و 5 د رجاءاً)*

10. **التوثيق والاخبار:** بتسجيل المعلومات المتعلقة بالفعاليات السابقة كلها وتحليلها وارسال التقارير الشهرية بذلك الى القطاع ليرسلها بدوره الى دائرة الصحة ثم الى وزارة الصحة. وهذا الواجب من اهم الواجبات وأشدها تأثيراً في نجاح تحقيق الصحة عموماً، فان الاهتمام الجدي بهذه التقارير هو الذي يوفر المعلومات الصحيحة الكافية التي نعلم منها واقع الحال، نوعية المشاكل والمعوقات وسبل تجاوزها، فاعلية الاجراءات المتخذة، اضافة الى اخبارنا عن كفاءة العاملين ومدى التزامهم بتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة منهم.

11. **أي مهام أخرى ذات طبيعة نفسية قد تستجد مستقبلاً.**

كيف يمكن أن تنجح فعاليات الصحة النفسية؟

ان تحقيق الصحة النفسية لأي مجتمع لا ينجح الا بمشاركة وتعاون قطاعات ذلك المجتمع كلها، لذا لابد **من إشراك المجتمع في تحقيق الصحة النفسية** من خلال التنسيق مع المجاميع والأشخاص المعروفين والمؤثرين في المنطقة ومجلس الرعاية الصحية الأولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف:

- معرفة القيم، الأفكار، المخاوف، الحاجات والمطالب المشتركة لساكني المنطقة، وماهي رؤاهم للصحة النفسية والمرض النفسي، وماهي المشاكل

النفسية الاجتماعية الشائعة Psycho–Social وماهي الحلول المقبولة لديهم لهذه المشاكل ومن الذين يمكن أن يساهموا في معالجتها.

- معرفة الاشخاص القابلين للاصابة Vulnerable، ومجاميع الاختطار Risk Group
- مساعدة المرضى للحصول على الدعم الاجتماعي المكمل للتدبير الصحي الذي يقدمه المركز الصحي.

ان العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية يشكلون ثروة كبيرة بصفتهم العددية كقوة بشرية عاملة، وصفاتهم العلمية بدراساتهم الطبية والصحية وبخبراتهم التي اكتسبوها من عملهم في حقل الخدمات الصحية، ويمكنهم بعد تدريبهم بالشكل المناسب أن يقدموا خدمات الرعاية الصحية النفسية ويطورونها لأحسن صورة ممكنة.

الصحة النفسية والأضطراب النفسي

الصحة: كما عرفتها منظمة الصحة العالمية، عام 1946 (هي حالة المعافاة التامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً وليست الخلو من المرض أو العوق فقط.)، ومؤخراً أضيفت المعافاة "الروحية" إيضاً للتعريف.
وهذا التعريف يبين بوضوح ان المعافاة النفسية (الصحة النفسية) هي مكون ودعامة رئيسة في الصحة؛ حيث لا تتحقق حالة الصحة التامة للفرد أو المجتمع إلا بتحقق الصحة النفسية.

ولكن ماهي الصحة النفسية ومن هو المصاب بالأضطراب النفسي؟!
من الملحوظ اننا حين نذكر مصطلح الصحة النفسية في أي مكان فأن أول ما يتبادر إلى أذهان السامعين هو المرض النفسي الشديد وفقدان البصيرة (مايسمى الجنون) وهذا شيئ غير صحيح ولابد من العمل الكثير لتوضيح فكرة ومعنى الصحة النفسية حتى نستطيع تحقيقها ولكي نتمكن من تمييز الشخص السليم والشخص المصاب بالأضطراب النفسي.
ولفهم معنى الصحة النفسية والأضطراب النفسي لابد أولاً من معرفة ثلاثة أبعاد تحدد شكل الحالة النفسية لأي فرد، وهذه الأبعاد هي: الأفكار، المشاعر، والسلوك.

1- **الأفكار**: وهي ما يدور في ذهن الفرد من أمور وآراء أو قرارات أو خطط وغير ذلك ولا يعرفها إلا الشخص نفسه ولا نستطيع معرفتها إلا إذا أخبرنا هو بها، وقد نخمنها أو نستدل عليها فقط من سلوكه.
2- **المشاعر**: ويقصد بها ما يحسه المرء بداخله من عواطف كالحب، الغيرة، الكره، الغضب أو غير ذلك مما يعتري المرء من إنفعال تجاه شخص ما أو موضوع ما أو موقف ما. ونحن عادة لا نعرف مشاعر الآخرين إلا مما يظهر عليهم من تعابير أو من كلامهم وتصرفاتهم الأخرى.
3- **السلوك**: وهي كل ما يقوم به الفرد من أعمال وحركات وأقوال ويمكن أن يحسها الآخرون عادة. *(انظر فصل الأعراض الشائعة رجاءاً)*

بالنسبة لنا كأفراد في المجتمع فنحن لا نحس من الآخرين إلا سلوكهم (تصرفاتهم) فقط، أما أفكارهم ومشاعرهم فنستدل عليها من تحليلنا و فهمنا لتصرفاتهم وتعابيرهم بالإستناد إلى خبراتنا الشخصية و المقاييس والمعايير المتعارف عليها في مجتمعنا.

في ممارستنا المهنية وحين نريد تقييم الحالة النفسية لأي شخص، سواء في حالة الصحة أو المرض، فلابد أن ندرس حالة هذه الأبعاد الثلاثة (الافكار، المشاعر، السلوك).

تعريف الصحة النفسية:

ليس من السهل وضع تعريف واحد للصحة النفسية يناسب المجتمعات الأنسانية كلها؛ لأن معايير الصحة النفسية ليست أقيام رقمية مطلقة (كما في قياس ضغط الدم مثلاً) بل معايير نسبية غالباً. ومنظمة الصحة العالمية عرفت الصحة النفسية مؤخراًعلى أنها: **(حالة من العافية يستطيع فيها الفرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حالات التوتّر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي).**

ونحن في الرعاية الأولية ولتسهيل الفهم والتطبيق العملي، فأن ما نعنيه بالصحة النفسية**: هي حالة من الإحساس الإيجابي بالرضا عن الذات المُتَصِفَة بالتوازن بين مشاعر وأفكار وتصرفات الفرد وانسجامها مع القيم والأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع.**

ومن علامات تمتع الفرد بالصحة النفسية:

1- معرفة القدرات والامكانات الحقيقية للذات وتقبلها والسعي للأستفادة منها وتطويرها، ومعرفة السلبيات الذاتية والاعتراف بها والعمل على تجاوزها.
2- القدرة على التعامل السليم مع ضغوط الحياة المعتادة وعلى مواجهة وحل المشاكل اليومية بشكل إيجابي، وباعتدال بعيداً عن الأفكار والانفعالات المبالغ فيها والتصرفات السلبية والتهور.
3- القدرة على إقامة علاقات اجتماعية سليمة مع الآخرين وإدامة تلك العلاقات.
4- القدرة على العمل والإنتاج المثمر وعلى العطاء لتطوير نفسه وعائلته ومجتمعه.
5- المرونة والثبات أمام الأزمات والقدرة على مداواة الذات وتجاوز الأزمات النفسية. *(ولندعوها لسهولة التذكر "السلوان").*

و يمكن القول بكل بساطة وشمولية أن الشخص المتمتع بالصحة النفسية **يكون راضياً عن نفسه بشكل ايجابي ويكون الآخرون *(أهله، معارفه والمتعاملون معه)* راضين عنه.**

و في مجتمعنا، لعل أحسن ما نصف به الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية هو انه كالوردة؛ ولذا فأننا قد اخترنا الوردة لتكون شعارنا للصحة النفسية.

نحن نأمل أن نشارك جميعاً في زيادة الوعي المجتمعي لتصبح الوردة هي أول ما يتذكره الناس حين يذكر موضوع الصحة النفسية بدلاً من تذكر الجنون.

من هو الفرد الذي نعتقد أنه مريض (مضطرب) نفسياً؟

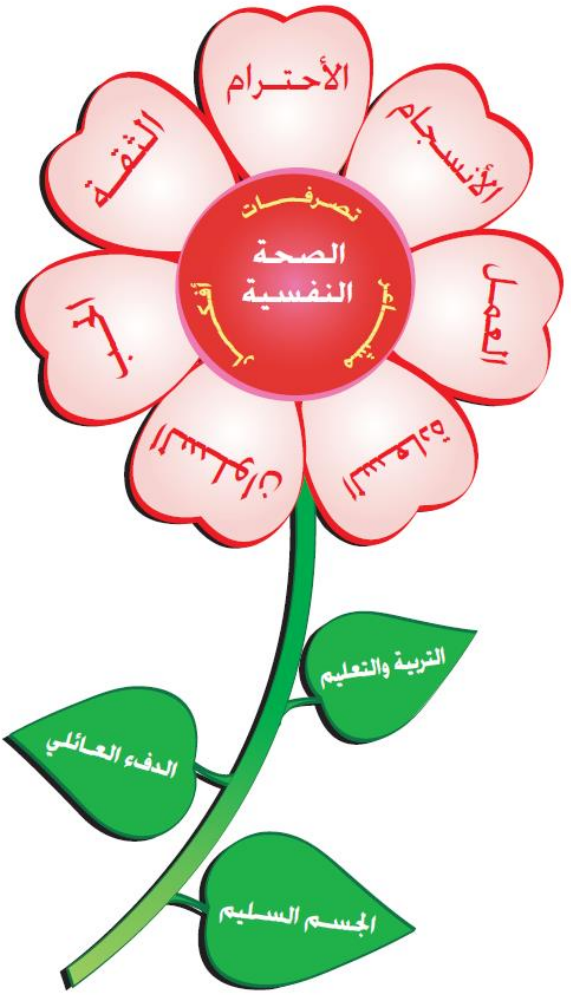
التصنيف العالمي العاشر للأمراض يستخدم كلمة الاضطراب ليعبر عن *جملة من الأعراض أو السلوكيات التي يمكن تمييزها سريرياً والتي تكون مصحوبة في معظم الحالات بضائقة وتشوش في الوظائف الشخصية. ولاينبغي ادراج الانحراف أو النزاع الاجتماعي الذي لايصاحبه خلل ادائي في الوظائف الشخصية ضمن الاضطرابات النفسية.*

وفي الرعاية الصحية الأولية يمكننا القول: **أن الشخص قد يكون مصاباً باضطراب نفسي إذا كانت لديه أفكار أو مشـاعر أو تصـرفات مزعجة له أو للآخرين وتسبب مصاعباً او تراجعاً في أدائه الحياتي.**

لتقييم الحالة النفسية للفرد تجب دراسة: أفكاره، مشاعره و تصرفاته

بعض خصوصيات الصحة النفسية:

1. في مفاهيم الصحة النفسية لا يوجد خطأ مطلق ولا صحيح مطلق، بل يعتمد ذلك على المجتمع والظروف التي يعيش فيه المرء فالقيام بعمل معين قد يكون مقبولاً ومعتاداً في مجتمع ما ولكن العمل نفسه قد يعتبر سلوكاً غريباً أو معيباً في مجتمع آخر.
2. ان كثيراً من أعراض الاضطرابات النفسية التي تظهر لدى المرضى، قد تظهر أحياناً لدى أي شخص سليم في المجتمع ولكن الفرق في شدة تلك الأعراض ومدتها. فمثلاً كل أنسان قد يتعرض لموقف خاص فيحزن لمدة ما وتقل نشاطاته لفترة محدودة وهذا شئ مقبول ومتوقع، ولكن إذا استمر حزنه لفترة طويلة وقلت نشاطاته بشكل كبير مما أثر سلباً على أداءه لوظائفه الاجتماعية، فالمتوقع أنه عبر خط الإنفعال الطبيعي الى الانفعال المرضي.
3. ان الآلام والأضرار المباشرة للمرض البدني يعانيها المريض نفسه فقط (وهذا لا يعني عدم انشغال وحزن ومعاناة ذويه لأجله) أما في الاضطرابات النفسية فقد يعاني الأهل والمحيطون بالمريض الأمرين "أحياناً" وهو لايدرك ذلك (عند فقدان البصيرة). ان الغالبية العظمى من المصابين بالأمراض النفسية يدركون مرضهم ويعانون منه وقد يسعون لمعالجته. ولكن البعض القليل من المرضى لا يدركون انهم مرضى، وبهذا يسببون المتاعب والاحراج للذين حولهم بدون علم أو قصد منهم، ولا يجوز أن نلومهم وننتقدهم فهم مرضى وهذه أعراض مرضهم.



من العناصر الاساسية اللازمة لتحقيق الصحة النفسية للانسان:

- الجسم السليم (بسلامة اعضائه كافة وخاصة الدماغ)
- الدفء العائلي الذي يوفر السكينة وأجواء المودة والرحمة
- التربية والتعليم المناسبين للعلم والحضارة ولقيم ومعتقدات المجتمع

ومن علامات الصحة النفسية للفرد:

- انسجام افكار ومشاعر المرء وسلوكه، وانسجامها مع قيم المجتمع السائدة
- احترام الانسان لنفسه وللآخرين والقدرة على كسب احترامهم
- الثقة بالنفس والثقة المناسبة بالآخرين والقدرة على أن يكون موضع ثقتهم
- حب الآخرين والحصول على حبهم والتعاون المشروع معهم
- القدرة على الاحساس بالسعادة والرغبة في إسعاد عائلته والآخرين
- القدرة على العمل والانتاج المثمر لتطوير نفسه ومحيطه
- السلوان، ونعني به هنا: القدرة على الثبات وتحمل ضغوط الحياة ومداواة الذات وتجاوز الأزمات النفسية

أفكار مغلوطة شائعة	حقائق علمية
1- الأضطرابات النفسية لا تصيب الأطفال!	1- الأطفال أيضاً قد يصابون بالأضطرابات النفسية وحتى في أعمار مبكرة.
2- ان الاضطرابات النفسية كلها لا تشفى!	2- الاضطرابات النفسية تشابه الأمراض البدنية، بعضها يُشفى تماماً وبعضها مُزمن ويستوجب معالجة مستمرة للسيطرة عليها. (تشبه بذلك مرض السكري مثلاً)
3- علاج الامراض النفسية ليس بأيدي الأطباء، لأن سببها هو التلبس بالجن أو الحسد أو السحر!	3- تجب معالجة المريض النفسي بأيدي الأطباء المختصين كما في معالجة أي مرض بدني؛ فهناك أسباب بيولوجية وكيمياوية واجتماعية للاضطرابات النفسية ولايجوز شرعياً أوقانونياً أوعلمياً حرمان المريض من العلاجات الطبية التي ثبتت فائدتها للسيطرة على هذه الأمراض. وهذا لايتعارض مع أهمية وضرورة الدعاء والتضرع لله لشفاء كل مريض.

الاضطراب النفسي ليس عيباً ولانقصيراً من المريض، ولايجوز علمياً ولا اخلاقياً ولاشرعياً ولاقانونياً أن نعتبر مرضه وصمة، فنقلل من شأنه ونعامله على هذا الأساس. ونذكر ونكرر ان أياً منا أو من عوائلنا قد يصاب به لاسمح الله، فيجب معاملة الآخرين كما نحب أن يعاملوننا به

تصنيف الأضطرابات النفسية

بـالنظر للاخـتلاف النسـبي الموجـود فـي العـالم فيمـا يخـص تشـخيص الاضـطرابات النفسية فقد اختلفت صيغ التصنيف ولكن بالشكل فقط لا بالجوهر. وأحدث التصـنيفات المعتمدة من قبل منظـمة الصـــحة العالميـة هو التصـنيف العـالمي العاشـر للأمـراض International classification of Diseases (ICD-10)

إن اخـتلاف التصـانيف قد يهم إختصاصـيي الطـب النفسـي ولكـن لـيس العـاملين فـي الرعاية الأولية. وسنذكر أدناه أصناف الاضطرابات النفسية بشكل مبسط وبتصـرف يناسب العمل في الرعاية الصحية الأولية:

1- **عسر التعلم Learning Disability:**
وهو عوق القدرات المعرفية والذكاء ويظهر في بداية العمر وقد يكون منذ الولادة.
كما يدعوه البعض صعوبة التعلم، عوق التعلم أو عجز التعلم. (وكان سابقاً يسمى التخلف العقلي Mental Retardation)

2- **اضطراب الشخصية Personality Disorder**
وهو النزعـة أو الميل للتصـرف غير الأعتيـادي (الشـاذ) نسـبة الـى طبـائع المجتمـع الذي يعيش فيه المرء0

3- الاضطرابات النفسية Mental Disorder *(وسيأتي تفصيلها أكثر)*
وتشـمل أي اضـطراب فـي السـلوك او الوظـائف النفسـية والخبـرات الـذي لـه بدايـة واضحة ويحدث بعد فترة من الحالة النفسية الطبيعية. وفيها:
- الاضطرابات الذهانية.
- الاضطرابات الوجدانية (المزاجية).
- الاضطرابات العاطفية (الانفعالية).

4- **الاضطرابات النفسية العضوية:**
- الخرف
- الهذيان

5- **سوء استخدام المواد والادمان.**

6- **الاضطرابات النفسية الخاصة بالأطفال والمراهقين** **Disorders of Childhood** وهي اضطرابات تحدث لأول مرة في هذه المراحل العمرية ولن نجدها في الكبار إلا في حالة استمرارها. كداء التوحد Autism، ألتبول اللاارادي Nocturnal Enuresis، فرط الحركة وقلة التركيز ADHD، اضطرابات السلوك Conduct Disorders

7- **اضطرابات أخرى:**
وهي التي لا يمكن تصنيفها مع أي من الأنواع المذكورة أعلاه كانحرافات الرغبة الجنسية sexual deviation

فيما يلي، سنذكر تفاصيل أنواع الاضطرابات النفسية (المذكورة في الفقرة 3 أعلاه) مصنفة بما يحقق السهولة والإيجاز المطلوب في هذا الكراس:

1. الاضطرابات الذهانية:

أ . الفصام

ب. اضطراب الوهم الأحادي

2. الاضطرابات الوجدانية Mood disorder :

أ . نوبة اكتئابية (الكآبة الشديدة والبسيطة)

ب. نوبة هوسية (الهوس والهوس الخفيف)

ج. اضطراب وجداني ثنائي القطب.

3.الاضطرابات الانفعالية (العاطفية) Emotional & stress disorder

أ. اضطرابات القلق Anxiety disorder

أولاً: أضطراب القلق العام Generalized Anxiety disorder

ثانيا: أضطراب الذعر (الرعب) panic disorder

ثالثا: الرهاب phobic disorder

ب. اضطراب وسواسي قسري Obsessive compulsive disorder

ت. اضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة Reaction to severe stress & adjustment Dis.

ث. اضطرابات انفصالية (تحويلية) Dissociative (conversion) disorder

ج. اضطرابات جسدية الصور Somatoform disorder

أسباب الاضطرابات النفسية

لايمكن ان يعزى الاضطراب النفسي الى سبب او عامل واحد فقط ولا تفسره نظرية واحدة فقط. ويُعتَقَد حالياً أنه حصيلة اجتماع عدة عوامل. ويمكن عموماً تقسيمها الى:

1 . عوامل ممهدة (predisposing) لحدوث الاضطراب ومنها:

أ – الاستعداد الوراثي

ب – المرحلة الجنينية من حياة الطفل وما تعرضت له الام اثناء الحمل من امراض او شدة او اشعاع وما تناولته من عقاقير.

ج – التعرض للشدة اثناء الوضع (الولادة).

د – سمات شخصية الفرد والعوامل النفسية والاجتماعية التي تعرض لها في بداية حياته. (كاليتم، التشرد، الأعتداء الجنسي،..)

2 . عوامل مرسبة (precipitating)

أي التي تحدث قبل ظهور الاضطراب النفسي مباشرة وتؤدي الى ظهور الأعراض او النوبة المرضية عند الذين لديهم اصلاً الاستعداد لحدوث المرض بسبب العوامل الممهدة اعلاه. ومنها:

أ . الامراض العضوية والعقاقير

ب. الشدة النفسية (الكروب)

ج. المتغيرات الاجتماعية

د. الأزمات الاقتصادية.

3 . عوامل تديم الاضطراب النفسي (perpetuating)

وهي التي تؤدي الى استمرار الاضطراب بعد ان يبدأ وتشمل:

أ. الاضطراب النفسي بذاته: فمثلاً في حالة الرهاب يتجنب المريض الشيء الذي يرهبه كالطائرة مثلا وهذا التجنب المستمر بذاته يديم الاضطراب ويزيد من شدته.

ب. العوامل الاجتماعية كموقف الاهل والاقارب من المريض او موقف رئيس الدائرة او المعلم او الاخرين منه.

ت. المرض المزمن او العاهة.

ولتطبيق ماورد اعلاه سريرياً لندرس مثلاً حالة مريض مصاب بالفصام، فان العامل الممهد قد يكون وراثياً، أما العامل المرسب فقد يكون تعرضه الى صدمة او شدة نفسية كفقدان احد ابويه، واما العامل المديم فهو في الداء ذاته وذلك في انعزال المريض وابتعاده عن المجتمع اضافة الى عدم فهم وتقدير ذويه والمحيطين به لحالته المرضية وانفعالاتهم السلبية تجاه سلوكه وميوله، او نقده بمرارة والتقليل من شأنه بأستمرار او اهتمامهم الفائق عن الحاجة به احياناً.

الأعراض النفسية الشائعة

لأغراض التشخيص السريري في الطب النفسي يتعين التعرف على المصطلحات و معاني الأعراض النفسية الشائعة، كما يتوجب التفريق بين **شكل** العرض **ومحتواه** لأن التشخيص يعتمد على الشكل أكثر من المحتوى.
والأعراض نوعان: **أولية** Primary و **ثانوية** Secondary. ويكون التركيز على الأولية في التشخيص.

ولنأخذ مثالاً تطبيقياً فنفترض أن شاباً يعتقد أن زوجة أخيه مثلاً تعمل له السحر لترغيبه في الزواج من أختها دون أن يكون لذلك صلة بالحقيقة. الشكل: هنا هو الوهم Delusion وهو إعتقاد خاطئ، اما المحتوى فهو اضطهادي (زوري) paranoid
ولنفترض شخصاً آخر يعتقد فجأة وبدون سابق إنذار بأنه رسول من الله إلى البشرية ثم يبدأ بسماع كلام يؤكد له ذلك (مع عدم وجود من يكلمه في الحقيقة) فالشكل هنا هو الوهم ومحتواه هو العظمة Grandiose Delusion وهو عرض أولي إذ لم يسبقه عرض أخر، أما الكلام الذي سمعه فهو هلوسة سمعية Auditory Hallucinations وهي ثانوية لأنها جاءت في التوقيت بعد وهم العظمة.

وسنذكر أدناه تعريفاً لبعض المصطلحات التي يكثر استعمالها في الطب النفسي والتي بحتاجها القارئ ليسهل عليه فهم الاضطرابات النفسية.

المعرفة Cognition: قدرة ذهنية يمكن من خلالها الاستعراف على المدركات والافكار، وتشمل عمليات التعلم كلها كالادراك، التذكر، الاستنتاج، والاجتهاد.
الإدراك Perception: هو عملية عقلية يمكن بواسطتها تمييز الاشياء والحوادث والتعرف على كل مايدور حولنا من امور تثير أياً من اعضائنا الحسية الخمسة. ومن اضطرابات الادراك، الخداع والهلوسة0
المزاج Mood: ويقصد به العاطفة وانفعالاتها من حزن وفرح. ويضطرب المزاج عند الاصابة بالاكتئآب او الهوس وكذلك استجابة للمثيرات المختلفة سواء كانت خارجية (بيئية) أو داخلية (بيولوجية)0
الوجدان Affect: وهو حالة المزاج لفترة قصيرة محدودة وتعرف اضطراباته بالاضطرابات الوجدانية أو العاطفية (كالكآبة والهوس).
المشاعر Feelings: الخبرات أو الانفعالات الوجدانية (العاطفية) من حزن وفرح وحب

وكراهية والتي ترافق حالة الفرد النفسية0
السلوك Behavior: هو مجموعة تصرفات الفرد استجابة للمثيرات الخارجية أو الداخلية، كالمثيرات الاجتماعية والحاجات البيولوجية. وفي علم النفس يقصد به الاستجابات المختلفة التي يمكن ملاحظتها من الآخرين وتخضع للقياس0
البصيرة Insight: قدرة الفرد على تفهم ذاته ومشاكله والتمييز بين الصحة والمرض والتفريق بين الاضطراب النفسي والعضوي. ويفقد المريض بصيرته عندما يصاب باضطراب ذهاني.
الأعراض الانسحابية Withdrawal symptoms: الأعراض التي تظهر جراء التوقف المفاجيء عن تناول المخدرات والكحول عند وجود حالة الاعتماد أو التعود أو الادمان. وهي اما نفسية في طبيعتها أو عضوية وقد تكون شديدة وخطيرة تهدد حياة المدمن.
الهياج Agitation: حالة من كثرة الحركة وعدم الاستقرار كالذهاب والمجيء في الغرفة بدون هدف.
الاكتئاب Depression : الشعور بالحزن والقنوط، وينعكس على تعابير الوجه بشكل طيات عمودية في جزء الجبهة أعلى الأنف بين المحجرين وتهدل زوايا الفم للأسفل مع انحناء الرأس وثني الكتفين للأمام والنظر للأسفل.
الإبتهاج (التيه) Elation : حالة حيوية المزاج المفرحة وحرارة التعابير على الوجه .
القلق Anxiety : خوف عام (غير نوعي) غير مبرر مقرون بتوتر وارتعاش وعدم استقرار، يرافق ذلك طيات أفقية في الجبهة مع شحوب وتعرق اليدين والقدمين.
الغضب Anger: مزاج منفعل وتوتر عام يرافقه توجه الحاجبين إلى أسفل، توسع في الحدقتين و التكشير عن الأسنان.
ألرهاب Phobia: الخوف من شئ محدد (كالظلام أوالحيوانات الأليفة) وغير مخيف في العادة لمعظم الناس؛ ويؤدي بالمريض إلى تجنبه والابتعاد عن مصدره آو حتى التفكير به.
الخداع Illusion: سوء تفسير المدركات الحسية للمؤثرات الخارجية الحقيقية بسبب خلل في الإدراك وكما يحصل في حالة السراب (أي يوجد مؤثر خارجي فعلاً ولكن تفسيره من قبل المريض مخطوء)
الهلوسة Hallucination: أدراك أشياء بصرية، سمعية، تذوقية، شمية أو لمسية مع عدم وجود مصدر خارجي حقيقي لها. مثال ذلك سماع أصوات أو رؤية أشخاص أو الإحساس بحشرات تمشي على الجلد.
الوهم Delusion: اعتقاد خاطئ لا يتزحزح عنه المريض ولايقبل النقاش فيه، مع أنه

بدون أساس كاف ولايتفق مع رأي الناس من نفس المستوى الثقافي والعرقي والديني والاجتماعي. وقد يكون محتوى الوهم أضطهادياً (زورياُ) Persecutory أو يتصف بالعظمة Grandiose أو سحرياً Magic او الغيرة Jealousy ... الخ

الوساوس أو الأفكار التسلطية Obsession : أفكار أو نزوات (اندفاع) أو صور ذهنية تدخل ذهن الفرد قسراً ولا يستطيع تفاديها أو التخلص منها رغم جهوده ومعرفته بعدم جدواها. والمصاب يستطيع أن يميزها بأنها منه وليست مفروضة عليه من الخارج.

الأفعال القسرية Compulsion : وهي كسابقتها الوساوس في كل الصفات ولكنها أفعال وليست أفكار ويقوم بها المصاب وهو مكره رغم مقاومته غير المجدية. وهي ذاتية أيضاً أي أنه لا يشعر بأنها موجهة إليه من الخارج.

الهذيان Delirium : حالة من حالات اضطراب الوعي تتصف باضطراب مستوى الشعور واضطراب التفكير والذاكرة وعدم ترابط الكلام مع قلق وخوف وهلوسة معظمها بصرية وتعكس اضطرابا نفسياً عضوي المنشأ.

الخرف Dementia : اضطراب تدريجي وتدهور مستمر في الذاكرة والشخصية والقدرات المعرفية والسلوك.

الذهول Stupor : حالة من سبات المشاعر أو شبه الغيبوبة والأنشداه والخدر العام في المشاعر وقد يكون نفسياً أو عضوي المنشأ.

الانتباه Attention : هو القدرة على التركيز على الشيء الآني.

التركيز Concentration: هو القابلية على توجيه اقصى مايمكن من الطاقة الذهنية إلى عمل أو فعالية ذهنية محددة. وعكسه عدم التركيز أي فقدان القدرة على الاستمرار في الانتباه أثناء القراءة والإصغاء أو العمل .

التذكر والنسيان Remembering & Forgetting: الذاكرة Memory هي مخزن للمعلومات في مكان معين في الدماغ؛ حيث يحتفظ الشخص بكل ما إكتسبه من معلومات أومهارات خلال حياته ويمكنه استرجاعها عند الحاجة. وقد تضطرب الذاكرة جراء اضطرابات نفسية أو عضوية المنشأ، وقد تضطرب للحوادث القريبة (Recent) أو البعيدة في الماضي (Remote) وقد يلجأ المريض للاختلاق "الفبركة " للتمويه على إصابته باضطراب الذاكرة.

الكرب Stress : ويقصد به الضغط النفسي وما يؤدي إليه من تغيرات فسيولوجية ونفسية لدى الفرد.

والضغط النفسي هو مجموعة التجارب العصيبة التي يتعرض لها الشخص ويمكن أن تؤثر ايجابياً أو سلبياً على أدائه وحياته.

تشخيص الاضطرابات النفسية

لتشخيص الاضطراب النفسي بشكل دقيق ينبغي اتباع ما يلي:

1- يقدم الطبيب نفسه للمريض للتعرف به ويحييه ويظهر له رغبته في مساعدته ويتحدث معه بأمور عامة قبل سؤاله عن مرضه.

2- يأخذ التاريخ المرضي بصورة تفصيلية، وقد يحتاج إلى الاستعانة بذوي المريض أو غيرهم للحصول على المزيد من المعلومات المفيدة.

3- أثناء المقابلة يحرص الطبيب على ملاحظة:
- مظهر المريض.
- سلوك المريض وطريقته في التكلم ومحتوى الكلام.
- مزاج المريض.
- تفكير المريض شكلاً ومحتوى، و يتحرى جيداً عن وجود الأوهام أوالوساوس أوأعراض اضطراب الإدراك كالخداع والهلوسة.

4- بعد ذلك يقوم الطبيب بفحص وتقييم درجة الانتباه والتركيز والذاكرة والتوجه والمعلومات العامة والبصيرة.

5- ثم يجري الفحص السريري الجسدي ويركز بصورة خاصة على الجهاز العصبي.

6- قد يحتاج إلى إجراء اختبارات نفسية و/ أو فحوص مختبرية وشعاعية أو مخطط كهربائي للدماغ.

نؤكد أن على الطبيب أن:
○ يميز بين شكل أعراض المصاب ومحتواها فالشكل هو الأهم. ○ أن يميز بين العرض الأولي والثانوي استناداً ألى تسلسل حدوثها لأن الأعراض الأولية أهم للتشخيص من الثانوية. ○ معرفة شدة الأعراض ومدى تأثيرها على الحالة العامة للمريض وعلى عمله وحياته الاجتماعية وفيما إذا كانت معوقة له أو فيها خطورة عليه أوعلى الآخرين.

طرق العلاج في الطب النفسي

هناك أساليب متعددة لمعالجة المصاب باضطراب نفسي تتباين الحاجة لها من مريض لآخر؛ لذلك يتوجب وضع خطة علاجية متكاملة لكل مريض نفسي بحيث تناسب حالته المرضية والاجتماعية وبالاستفادة من كل الإمكانات العلاجية المتيسرة.

وفيما يلي استعراض موجز لطرق علاج الاضطرابات النفسية:

1- العلاج بالعقاقير

بالرغم من تعدد العقاقير النفسية المتعارف عليها أو الحديثة في علاج الأمراض النفسية, فان هناك بعض العقاقير الأساسية الواجب معرفتها على مستوى الرعاية الصحية الأولية وتشمل:

أ- مجموعة مضادات القلق Anti-anxiety ومنها:

Diazepam (valium): 2-5mg (up to 30mg /day orally) or 10 mg/ IV slowly.
Chlordiazepoxide (librium): 5-10mg up to 40 mg /day

توصف هذه العقاقير عند الحاجة لفترة لا تتجاوز الأسبوعين تجنباً من الإدمان عليها وسوء استخدامها، وتعطى للمصابين باضطرابات القلق بأنواعه، الأفكار التسلطية، الكرب ما بعد الشدة، الاكتئاب البسيط والاضطرابات التحويلية أحياناً.

ب- مجموعة مضادات الاكتئاب Antidepressants ومنها:

Amitriptylline (Tryptizol): 10-25 mg up to 3 times/ day
Imipramine (Tofranil): 10-25 mg up to 3 times/ day
Clomimpramine (Anafranil): 10-25mg up to 3 times/ day
Maproptylline (Ludiomil):10-25mg up to 3 times/ day
Fluoxetine (Prozac): 20 mg twice/ day

توصف عادة لفترات طويلة نسبياً لأن مفعولها يظهر بعد مرور ثلاثة أسابيع على الأقل ولا يخشى من الإدمان عليها. وتوصف عادة للمصابين بالاكتئاب واضطراب القلق بأنواعه والاضطرابات النفسجسمية. لا تخلو هذه الأدوية من تأثيرات جانبية

يمكن تحملها؛ ولكن يجب الحذر من وصفها للأطفال وكبار السن والتأكد من عدم وجود مرض في القلب أو تضخم البروستات أو داء الزرقاء.

ج. مجموعة مضادات الذهان Antipsychotics ومنها:

Chlorpromazine (largactil)**:** 50-100 tid (tab or injection)
Trifluperazine (stelazine): 5 mg tid.
Fluphenazine Deconoate (Modecate): 25 mg. i.m./ Month.

توصف هذه الأدوية للمصابين بالاضطرابات الذهانية بأنواعها. وينبغي الإنتباه عند وصف هذه العقاقير إلى آثارها الجانبية كهبوط الضغط الوضعي (Postural hypotension) وأعراض مرض باركنسون, والتقلصات الحادة في عضلات الفم والوجه والرقبة والحركات اللاإرادية.

د-العقاقير المضادة لتصلب العضلات الارتجافي Antiparkinsonian:

تستعمل العقاقير المضادة لتصلب العضلات الإرتجافي كالبنزهيكسول (آرتين, باركيزول) وغيرها في علاج المرض الباركنسوني Parkinsonism والتأثيرات الجانبية للعقاقير المضادة للذهان. ومن أهم تأثيراتها الجانبية جفاف الفم وتشوش النظر. وفي حالة إستعمالها بجرع عالية فأنها تسبب الشعور بالفرح والتهيج والهلوسة مما يهدد بخطر الإدمان عليها عند إساءة إستعمالها؛ لذلك لاتستعمل حالياً ويستعمل بدلها حب بروسكايكلدين (كيمادرين).

2- العلاج بالصدمة الكهربائية ECT:

وهي طريقة فعالة ومهمة ضرورية لبعض المرضى على أن لا يصفها ولا يعطيها إلا اختصاصي الطب النفسي حصراً. وتستخدم فقط للحالات المقاومة لطرق العلاج الأخرى أوعندما يشكل المريض خطراً على نفسه أو على الغير كما في بعض الاضطرابات ألذهانية وحالات الانتحار والاكتئاب الشديد.

3- العلاج النفسي Psychotherapy: ويشمل

أ- المشاورة والإرشاد Counselling
ب- العلاج النفسي الأسنادي Supportive Psychotherapy
ج- العلاج المعرفي Cognitive therapy
د- العلاج السلوكي Behavior therapy

يفيد الإرشاد والعلاج النفسي الإسنادي في الإضطرابات النفسية كافة ويتعين أن نجيد إستخدامها, وفي بعض الإضطرابات يكتفى بها كما في حالات القلق والكآبة البسيطة. ويستخدم العلاج المعرفي في إضطراب الكآبة وبعض إضطرابات القلق. أما العلاج السلوكي فيفيد في الرهاب والوساوس واضطراب السلوك وبصورة خاصة في الأطفال .

يعتمد نجاح هذه العلاجات على تعاون المريض وعلى قدرة الطبيب على الإستماع والإصغاء للمريض, ويتوجب إرشاد المريض ومساعدته على التفكير الإيجابي وتطمينه وتدريبه على تمارين الإسترخاء.

وهناك بعض الحالات التي تتطلب التداخل الطبي السريع ونسميها علاج الأزمة Crisis intervention كمحاولة الإنتحار وإيذاء النفس وحالات الذعر والهياج، وهنا ينبغي إحتواء الحالة بمخاطبة المتأزم بلطف وحزم مهذب وإرشاده وتطمينه وعرض الرغبة بالمساعدة إضافة إلى إستخدام بعض العقاقير سالفة الذكر.

4- العلاج الإجتماعي Social therapy:

وذلك بدراسة الحالة الإجتماعية للمريض من قبل الباحث الإجتماعي ومناقشتها مع الطبيب لوضع الحلول المناسبة لظروف المريض في الأسرة والسكن والعمل والدراسة وغير ذلك.

5- التأهيل Rehabilitation:

أ- التأهيل في المستشفى: وذلك بوجود مشغل في المستشفى يعمل فيه المرضى الراقدون لملئ فراغهم وتدريبهم وتوفير الفرص المناسبة لهم لممارسة هواياتهم وتنميتها وإشراكهم في نشاطات ثقافية وإجتماعية كالزيارات خارج المستشفى والسفرات الترفيهية والرياضية.

ب- التأهيل خارج المستشفى: تأهيلهم للعمل في المصانع ومرافق العمل المناسبة الأخرى وبإشراف معالجين مختصين بهذا الجانب خاصة في حالة الفصام المزمن.

العقاقير النفسية التي يجوز وصفها في مراكز الرعاية الصحية الأولية

- يوصى الطبيب العام *(الذي سبق تدريبه نظرياً وسريرياً لتقديم خدمات الصحة النفسية)* بوصف هذه الأدوية لمدة أسبوعين فقط ويجب إحالة المريض لاختصاصي النفسية قبل إعادة وصفها. *(انتباه رجاءاً: جدول الأدوية هذا قد يتغير تبعاً للمستجدات العلمية وللموارد المتاحة)*
- يجب إعادة الاستشارة دورياً *(خلال ثلاثة اشهر كحد أعلى)* .
- في حال حصول اعراض جانبية من مجموعة الادوية المضادة للذهان ومنها التشنجات العضلية يتوجب اضافة مادة البروسايكلدين (كيمادرين) الى العلاج.

الاضطرابات	العقاقير	قوة الدواء	الجرعة
الانفعالية كالقلق، الوسواس وغيرها	حبوب: - دايزيبام (فاليوم) - كلوردايزيبوكسايد(لبريوم) - ترايفلوبيرازين (ستيلازين) - كلوربرومازين(لارجكتيل) - كلوميبرامين (انافرانيل)	 - (2) و (5) ملغم - (5) و (10) ملغم - (1) ملغم - (10) و(25) ملغم - (10) و(25) ملغم	 - 3×1 - 3×1 - 2×1 او 3×1 - 2×1 او 3×1 - 2×1 او 3×1
الكآبة	- حب امبرامين (توفرانيل) - حب امتربتلين (تربتزول) - كبسول فلو كستين (بروزاك)	- (1) و(25) ملغم - (10)و(25) ملغم - (20) ملغم	- مرة واحدة ليلاً وتزاد الجرعة تدريجياً - مرة واحدة ليلاً - 1×1 أو2×1
الذهانية	- حب أولانزابين (زايبركسا) - حب هالوبيريدول (سرنيز)	- (5) ملغم - (1,5) و (5) ملغم	- 2×1 - 2×1 أو3×1
الأعراض الجانبية للعلاج	- حب بروسكايكلدين (كيمادرين) - ابر بروسايكلدين	- (5) ملغم - (10) مغم	- 2×1 أو3×1 - Im& iv (slowly) (حسب الأبر المتوفرة)
الصرع	- كاربامازبين (تكريتول) - فينوباريتون (لومينال) - صوديوم فالبروات (ديباكين)	- (200) ملغم - (15 - 30) ملغم - (200) ملغم	تحدد الجرعة حسب وصف الطبيب الاختصاصي.
الطوارئ النفسية	أبر (امبول): - دايزيبام (فاليوم) - كلوربرومازين (لارجكتيل) - هالوبريدول (سرنيز) - ابر بروسايكلدين	 - (10) ملغم - (50) ملغم - (5) ملغم - (10) مغم	 - im& iv (slowly) - im - im& iv (slowly) - im& iv (slowly) (حسب الأبر المتوفرة)

النمو النفسي
Psychological development

يهتم العلماء بدراسة النمو النفسي للطفل بمراحله المختلفة وبالعوامل المؤثرة فيه من بدنية وبيئية لمعرفة أحسن الوسائل الممكنة للحفاظ على الصحة النفسية للفرد والوقاية من الإنحرافات والإضطرابات النفسية وفي الإكتشاف المبكر لأي منها بهدف التعامل الصحيح معها والوصول الى أفضل المستويات الممكنة من الحياة السوية الصحية.

وقد درس العلماء موضوع النمو من جوانب متعددة (التطور الحركي،التطور المعرفي، النمو الإجتماعي، العاطفي و.....الخ) لكونها تتفاعل مع بعضها لتؤثر في الشكل الكامل والنهائي للبناء النفسي للفرد الذي يعتمد على الصفات الخلقية للطفل (**البنية**) وظروف تنشئته (**المحيط**) والتفاعل بين هذين المحددين.

سنتحدث هنا بايجاز عن بعض هذه الجوانب وذلك لنتعرف على:
- العوامل الوقائية والنصائح التي يجب تقديمها للأبوين لتأمين أفضل مايمكن للنمو النفسي للطفل.
- السمات العامة للنمو بمختلف المراحل العمرية وبما يساعدنا في الأكتشاف المبكر لأي انحراف عن المعتاد.

مرحلة الإخصاب

تبدأ رحلة الحياة بالتقاء حيمن الرجل مع بويضة المرأة حيث يتم الإخصاب في قناة فالوب لتتكون البيضة المخصبة التي تنقسم عدة مرات حتى تصبح كرة صغيرة تنزل الى الرحم لتكوين المشيمة والجنين. ولنتوقف عند هذا الحد، فإن وجود أي خلل في حيمن الرجل أو بويضة المرأة قد يسبب اضطراباً نفسياً أو جسدياً لدى الطفل وهنا تبدو أهمية الفحص والمشاورة الطبية قبل الزواج والحمل Premarital and Preconceptional Counselling فالطبيب:

- ينصح بتجنب زواج الأقارب عند وجود مرض وراثي.
- كما ينصح بالإجراءات اللازمة عند عدم تطابق دم الزوجين (عامل Rh) وبأنه ليس مانعا للزواج،
- كما يبين أن زيادة عمر الأبوين ترافقها زيادة ملحوظة في احتمال ولادة طفل منغولي.
- كما يسعى لاكتشاف بعض الأمور قبل الزواج والحمل، مثل الاصابة بفيروس

التهاب الكبد الفيروسي أو فيروس نقص المناعة المكتسب أو الأخماج المنقولة جنسياً والى غير ذلك لغرض اتخاذ اللازم بشأنها من أمور التوعية والوقاية والمعالجة.

ولعل من المناسب ان نذكر في هذه المرحلة ان من الضروري جداً ان يكون الأبوان راغبين فعلاً بالحمل وبالطفل المنتظر؛ إذ تشير الدراسات ان الحمل المرفوض (الطفل الغلطة) يؤثر سلبياً في حياة الطفل مستقبلاً بشكل أو بآخر رغم حب الأم له بعد ولادته ورعايتها له.

مرحلة الحمل (المرحلة الجنينية)

ولنعد الآن للجنين الذي يبقى في رحم أمه أشهراً طويلة لينمو وتتطور انسجته وأجهزته المختلفة حتى يكتمل ويحين وقت الولادة.

ولنتوقف هنا من جديد إذ تتجلى أهمية الفحص الدوري للحامل لمتابعة الحالة الصحية والتغذوية لها وللجنين والإكتشاف المبكر لعوامل الخطورة والتصرف أزاءها. اضافة لتقديم النصح والإرشاد للحامل، فهناك عوامل عديدة قد تتعرض لها الحامل وتؤثر في مستقبل الطفل المنتظر ومنها مثلاً:

- تناول الأدوية.
- التعرض للإشعاعات الضارة.
- الإصابة بالأمراض المختلفة (كالحصبة الألمانية، السفلس، الأيدز...الخ).
- مشاكل عدم تطابق الدم بين الأم والجنين.
- مشاكل سوء التغذية وخاصة نقص اليود، الفولك أسيد... الخ.

مرحلة الولادة

وعند الولادة فإن تعرض الطفل لقلة الأوكسجين، تأخر الولادة وتعسرها، أية شدة على الرأس قد تسبب ضرراً في الدماغ، وكل هذه عوامل قد تسبب أضراراً نفسية وعصبية مستديمة ان لم تسبب الوفاة. لذا لابد ان تكون الولادة بمساعدة أيد أمينة ماهرة متدربة على التعامل مع كل الإحتمالات أثناء الولادة؛ مما يستوجب التخطيط المسبق والتهيئة لمكان الولادة ومن سيساعد في عملية الولادة.

مرحلة ما بعد الولادة والطفولة

بعد الولادة يأتي كائن انساني جديد منفصل جسدياً عن أمه ومزود بوسائل كثيرة تساعده أن يشق طريقه في الحياة. فهو قادر على التنفس، المص، البلع، التغوط، التبول، البكاء، التحسس بالظروف المحيطة به...الخ.

حين يولد الطفل يكون حجم دماغه حوالي ثلثي حجم الدماغ الناضج (مع وجود المكونات الأساسية كلها فيه) وينمو ويكبر بسرعة خلال السنتين الأوليتين من العمر. إن توفر الغذاء المناسب ضروري جداً لهذا النمو مما يستوجب الإلتزام **بالرضاعة الطبيعية** التي توفر الغذاء الأنسب وتعطي الإحساس بالأمان والطمأنينة والثقة للطفل، كما يستوجب توعية الأمهات بانواع **الأغذية التكميلية** التي يجب اعطاؤها للطفل والعمر الذي تعطى فيه للطفل.

ان النمو النفسي الطبيعي يحتاج الى الصحة البدنية، التغذية الجيدة، الوقاية من الأمراض المعدية (لذا يجب الإلتزام بإكمال التلقيحات) والإكتشاف المبكر والمعالجة السريعة لأي مرض قد يؤثر في نمو الطفل مثل الفينايل كيتون يوريا، قصور الغدة الدرقية...الخ. وهذا يبين أهمية إجراء فحوص الغربلة للأمراض الأيضية.

كما يتطلب ايضاً وجود المؤثرات الخارجية المحفزة لقدرات الطفل كالتحدث معه وملاعبته وابعاده عن مصادر الأذى والإزعاج، التواصل معه، ضمه إلى الصدر، إلخ. ومن المهم أن نذكر هنا ان الطفل ليس كائناً سلبياً متلقياً فقط بل هو كائن ايجابي يتفاعل بطريقته الخاصة مع البيئة المحيطة به أثناء نموه حتى يكبر ويكون له الشكل النفسي الخاص به.

وثمة حقيقة مهمة لابد من معرفتها وتعليمها لكل الأباء والأمهات وهي ان الأطفال الأصحاء نفسياً يأتون عادة من العوائل الودودة المتحابة التي يسودها الدفء والإحترام المتبادل بين افرادها مهما كان النمط التربوي الذي تتبعه العائلة.

السمات العامة للمراحل العمرية:

يمر كل الأطفال عادة أثناء نموهم بأدوار متعاقبة من النمو النفسي والإجتماعي والمعرفي بموازاة النمو البدني والحركي وتظهر عليهم خلالها سمات وخصائص متشابهة عموماً، ولكن لايوجد عمر معين ثابت لظهور لكل سمة بل هو مدى عمري عام، ويختلف الطفل الواحد عن الآخر في العمر الذي تظهر فيه السمة المعينة. وإذا ظهرت سمة معينة بعمر مبكر (كالتسنين أو الكلام المبكر) فهذا لايعني ان الطفل سيكون عبقرياً بالضرورة كما ان تأخر ذلك لايعني انه متخلف بالضرورة؛ لذا لابد من دراسة مجموعة السمات الموجودة للطفل ومقارنتها بالمتوقعة لمرحلته العمرية قبل إعطاء التقييم النهائي عنه.

وفي كل دور تظهر بعض الأعراض والمشاكل النفسية التي تعتبر مقبولة طبياً لتلك المرحلة العمرية. ان معرفتنا لسمات مراحل النمو هذه تساعدنا في التمييز بين ماهو طبيعي وغير طبيعي للمرحلة العمرية فسلس البول اللا إرادي مثلاً يعتبر طبيعياً في عمر الثلاث سنوات ولكنه غير طبيعي بعمر الثمان سنوات.

وندرج فيما يلي بإيجاز السمات العامة للمراحل العمرية :

السنة الاولى من العمر:

العمر	نوع النمو
شهرين	يبدأ الطفل بالإبتسام مما يفرح والديه كثيراً.
3 – 4 أشهر	يميز والديه ويبتسم لهما، ولايستغرب من الأخرين.
سبعة أشهر	يبدأ بالإستجابة عند مناداته بإسمه.
ثمانية أشهر	الخوف والتوجس والبكاء من الغرباء.
تسعة أشهر	يبدأ بتقليد التصرفات الجديدة.
عشرة أشهر	القلق والبكاء عند ابتعاد الأم أو عند تركه مع الأخرين.
اثني عشر شهراً	علاقة وطيدة مع الأم والآخرين في الأسرة، انتظام أوقات النوم والأكل، يتعلم تمييز الأشياء في بيئته تدريجياً ويكون علاقات سببية بين الأشياء والظواهر حوله، ويتمكن من نطق بعض الكلمات مثل بابا، ماما، دادا ويستمتع بذلك.

السنة الثانية من العمر:

- يبدو وكأنه يرغب بإرضاء والديه ويقلق اذا أحس بزعلهم.
- يتعلم السيطرة على سلوكه تدريجياً وحسب ماتقتضيه المواقف المختلفة.
- تتوطد علاقته اكثر مع الأبوين والأسرة من حوله والذين يهتمون به وبرعايته.
- نوبات انفعال عصبية وبكاء عند تقييد رغباته أو حركته أو فضوله في استطلاع الأشياء حوله.
- يقل الخوف من الغرباء ويبدأ الخوف من بعض الحيوانات كالكلاب.

في نهاية السنة يستطيع تشكيل جملة من كلمتين أو ثلاثة.

السنوات الثالثة – الخامسة من العمر (سنوات الروضة والتمهيدي)

- نمو كبير وسريع في الذكاء والقدرات العقلية والمعرفية وخاصة القدرة على الكلام من فهم وتعبير.
- نمو إجتماعي واضح، تقليد الآخرين في سلوكهم وتقمص طبائع وتقاليد وقيم الأبوين *(بداية مرحلة تكوين الضمير وإكتساب القيم وهنا تبدو أهمية تصرف الأبوين كقدوة حسنة أمام أطفالهم)*.
- تكوين علاقات ودية مع الأخوة والأخوات في الأسرة ومع الأخرين.
- تستمر نوبات الإنفعال والعصبية والتوتر ولكنها تقل وتختفي نهاية العام الخامس.
- تبرز كثيراً ظاهرة الفضول وحب الإستطلاع وكثرة الأسئلة.
- ينمو لديه الخيال الذي يشبع رغباته التي لا يستطيع إشباعها في الواقع ويستمتع ببعض اللعب والأشياء.
- يبدأ بتمييز هويته الجنسية كذكر أو أنثى وتمييز جنس الآخرين. كما يهتم بأعضائه الجنسية ويداعبها.
- يزداد الخوف من الحيوانات في البداية ولكن مع الوقت يتغير نحو الخوف من الأخطار الخيالية كالإشباح والوحوش.
- تشمل مشاكل هذه الفترة صعوبات وإضطرابات الأكل والنوم والتعلق بالأبوين والقلق عند إبتعادهم والإنفعال الشديد عند الإحباط في الحصول على ما يريد وقد تصل حد العدوانية.

عمر السادسة – أحد عشر عاماً (عمر المدرسة)

- يستطيع تمييز هويته الجنسية ومكانه في الأسرة.
- التأقلم مع محيط المدرسة وتعلم القراءة والكتابة والحساب.
- التعامل مع المعلم والمعلمة كشخصية مهمة في حياته.
- يدرك ما يستطيع فعله وما لا يستطيع فعله .
- يفضل اللعب الجماعي والإختلاط مع أطفال من جنسه (الولد مع الأولاد والبنت مع البنات).
- الخوف من الأخطار الخيالية موجود ولكن الطفل يبدأ بالخوف من الموت والتفكير في معناه، وبعض الأطفال تسيطر عليهم فكرةالخوف من فقدان الأبوين مبكراً.
- من أهم المشاكل في هذه المرحلة: الخوف، القلق، كوابيس النوم، بعض العلاقات المضطربة مع أقرانه، عدم الطاعة في بعض الأحيان والمشاجرات مع الآخرين.

فترة المراهقة

هي مرحلة النمو التي تتوسط بين الطفولة والنضج وتبدأ عادة بالبلوغ الجسدي الذي يبدأ بعمر 11-13 سنة للأناث و 13-17 سنة للذكور. ويحصل في هذه الفترة نمو جسماني كبير وسريع وخاصة بالأعضاء التناسلية كما تتجلى المظاهر الجنسية الأخرى مثل غزارة الشعر وتوزيعه، تغير الصوت، زيادة الافرازات الدهنية وظهور حب الشباب، الخ.

ويرافق ذلك تغيرات نفسية ملحوظة منها:

- إدراك الفرد المتزايد لشخصيته وللفروقات الفردية التي تميزه عن الآخرين بحيث يعرف من هو أو من هي والى ماذا يصبو.
- نمو العلاقات القوية بشلة الأقران التي تنمي لديه روح إستقلال الذات والإعتماد على النفس.
- الإهتمام بالجنس الآخر والتودد اليه ونمو الرغبة الجنسية تجاهه.
- من أهم مشاكل هذه الفترة: الحساسية المفرطة والمزاجية، القلق، النفور من المدرسة عند البعض، صعوبة إقامة وإدامة العلاقات مع شلة الأقران أحياناً، عدم الطاعة، التمرد، وفي بعض الأحيان الجنوح السلوكي (كالسرقة، العدوانية، المشاجرة، الهروب من البيت أو المدرسة، سوء إستخدام العقاقير والمواد الأخرى، الخ).

نؤكد على أهمية وتأثير أسلوب التعامل السليم مع الطفل في مراحل نموه كلها وضرورة إدامة العلاقة الودية بينه وبين مقدمي الرعاية له (الأبوان أو غيرهما) والإعتدال في الإهتمام به وعدم الإفراط بالقلق عليه، والإستجابة الودية لإحتياجاته الأساسية ورغباته المشروعة، والإبتعاد عن العنف في تربيته، والتصرف كقدوة حسنة صادقة أمامه. كل ذلك سيؤدي به الى نمو نفسي سليم ويحصنه ضد الإضطراب النفسي مستقبلاً بإذن الله.

عوامل الخطورة على نمو الطفل

1. سوء التغذية، فقر الدم
2. نقص اليود
3. الاختناق ما حول الولادة
4. قلة وزن الوليد
5. الأخماج، وأمراض الطفولة المتكررة
6. الفقر
7. جهل المربي بشكل عام وبأساليب تنشئة الطفل بشكل خاص
8. ضعف الدعم العائلي والاجتماعي
9. الاضطراب النفسي لمربي الطفل
10. تلوث البيئة
11. اليتم
12. سوء الظروف المدرسية
13. الهجرة من الريف للمدن الكبيرة

الطوارئ الطبية النفسية
PSYCHIATRIC EMERGENCIES

لابد من الإلمام بصيغ تشخيص ومعالجة الطوارئ النفسية تفادياً للخطر الذي قد يقع على المضطرب نفسياً أو على الآخرين أو كليهما.
وتعرف **الطارئة النفسية** بأنها إضطراب شديد في أفكار ومشاعر وسلوك المصاب مما يجعله في حاجة إلى علاج فوري. وتعتبر الحالة طارئة سواء كان ذلك من وجهة نظر المضطرب ذاته أو المعنيين به أو المرجع الذي أحاله للطبيب. وأهم هذه الطوارئ مايلي:

1- محاولات الإنتحار وإيذاء النفس.
2- محاولات القتل.
3- الإضطرابات النفسية الحادة والشديدة:
- إضطراب القلق كالذعر
- الإضطراب التحويلي (سابقاً تسمى الهستيريا).
- إضطراب الشخصية والسلوك العدواني

4- الهذيان Dilirium
5- الإضطراب الذهاني او الوجداني الحاد:
- بعض حالات الفصام
- بعض حالات الهوس

6- المضاعفات الجانبية لبعض الأدوية.
7- الأعراض الانسحابية او التسممية لسوء استخدام المواد والمخدرات.
8- نوبات الصرع المتعاقبة المستمرة.

فيما يلي سنقدم شرحاً موجزاً لبعض حالات الطوارئ الهامة والتي لم تذكر في مكان آخر في هذا الكتاب

الإنتحار

غالباً، تكون هناك مؤشرات تدل على إحتمال إقدام الفرد على الإنتحار ومنها:

1-مؤشرات لفظية: بأن يتحدث الفرد عن الرغبة في إنهاء حياته أوينطق بأفكار إنتحارية غير مباشرة. (مثلاً: الحياة لاتستحق أن نعيشها، أو أن الراحة الوحيدة هي في الموت).

2- مؤشرات سلوكية: كتناول جرعة بسيطة من مادة مميتة أو توزيع ممتلكاته على الآخرين أو وضع خطة لذلك.

3- مؤشرات وضعية: وذلك بتعرض الفرد إلى كروب أو ضغوط نفسية أو صدمات كالإصابة بمرض خطير أو فقدان شخص عزيز أو الفصل من العمل.

4-مؤشرات إضطراب نفسي: الكآبة من الأمراض التي تعرض المصاب إلى الإنتحار وكذلك الهذيان والإضطراب الذهاني الإضطهادي تحت تأثير الأوهام وكذلك في حالات الرغبة في التحدي.

وتزداد أهمية وخطورة هذه المؤشرات لدى كبار السن, الأرامل, المطلقين, الأزواج المنفصلين بدون طلاق, المنعزلين والذين في وحشة الوحدة.

التدبير (المعالجة) Managment

1- أخذ التاريخ المرضي والإجتماعي والعائلي بدقة وملاحظة وجود أي مؤشر سابق للانتحار.

2- فحص الحالة النفسية والتحري عن بعض الأعراض المرضية المهمة كالشعور بأنه منبوذ وغير نافع أو عالة على الأخرين.

3- التحري عن الإصابة بأمراض مزمنة ومعوقة ومؤلمة أو خطرة ومميتة وبالأخص التي يرافقها إضطراب النوم المزمن وعن اللجوء إلى سوء إستخدام الكحول والمواد الكيمياوية للتخفيف عن معاناته.

4- يجب أدخال المريض المستشفى إذا كانت رغبته في الأنتحار شديدة أو إذا لم يوجد من يحمي المريض ويرعى حالته النفسية والصحية أو أنه بدون مأوى امن او انه من الذين يتسمون بالإندفاع والتحدي أو المخاطرة, وعند وضعه في المستشفى ينبغي إبعاد كل ما يمكن أن يستخدمه لتنفيذ المحاولة الإنتحارية كالعقاقير والالات الحادة والمكان العالي أو المصادر الكهربائية ويتعين أن يكون تحت مراقبة دقيقة مستمرة.

5- معالجة الإضطراب النفسي الأساسي كالكآبة أوالفصام وإستخدام العلاج النفسي الإسنادي والتوجيه والعلاج المعرفي ومساعدته في إيجاد الحلول لمعضلاته الإجتماعية والإقتصادية والعائلية. وعند وصف العقاقير ينبغي عدم وصف تلك التي عند أخذها بجرعات عالية تشكل خطورة على حياة المريض، كما ويجب إعطاؤه كميات صغيرة منها ويفضل أن يكون تناول الدواء بإشراف أحد ذويه. ويمكن إستخدام الصدمات الكهربائية في المعالجة إذا استدعى الوضع ذلك.

القتل

ويقصد به هنا القتل تحت تأثير الإضطراب النفسي، أما القتل المتعمد مع سبق الأصرار والترصد فليس للطبيب شأن فيها وإنما هو شأن الجهات المعنية الأخرى كالشرطة والمحاكم. ومما يذكر أن معظم حالات القتل تحدث في الليل وأيام العطل وفي المساكن ويكون الضحية عادة من ذوي المريض.

يرتكب القتل من قبل الذكور خمس مرات أكثر من الإناث وخاصة المصابين بأضطرابات نفسية أضطهادية ومن الذين يمتازون بالعنف وبأضطراب الشخصية اللااجتماعية (تسمى السايكوباثية سابقا) والمصابين بالغيرة المرضية والإكتئاب إذ يرى المكتئب بالقتل إنقاذاً للضحية من المعاناة والألم(كالأم المكتئبة التي تقدم على قتل أبنائها وزوجها ثم قتل نفسها بعد ذلك).

ينبغي دراسة الحالة النفسية للذي يقدم على مثل هذه المحاولة ومعالجة الإضطراب النفسي الذي يعاني منه ومتابعة الحالة تفادياً من الأنتكاسة.

المريض المتهيج أو العنيف

Excited or Violent patient

1- يجب التعامل مع المريض المتهيج أو العنيف بصيغة تتميز بضبط النفس والمنهجية وتحمل وقبول سلوكه كأحد أعراض إضطرابه النفسي والا يعمد إلى رفض معالجته، مع تجنب إستخدام التهديد والمعارضة الصريحة أو الوعد بشيء لايمكن تحقيقه أو السخرية بالمريض وخدش مشاعره والتقليل من قيمته.

2- على الطبيب مواجهة الحالة بسرعة وبثقة وهدوء وحزم ولطف وعليه تقديم نفسه للمريض والترحيب به ويظهر له أستعداده لسماع مايريد أن يقول ويحاول إقناعه بهدوء للتعرف على التاريخ المرضي بأيجاز وفحصه أيضاً بسرعة إن أمكن مع الأستعانة بمرافقيه للاستفادة مما لديهم من معلومات تسهم بتكوين فكرة أولية عن حالة المريض.

3- لابد للطبيب من أن يقر مع نفسه بالخوف من السلوك العدواني ولكن لا يصاب بالذعر ويهتم بالحذر ويؤمن لنفسه ما يحميه من عنف المريض، ويحدثه عن بعد معقول. وقد تستوجب الحالة تقييد يدي المريض (عند الضرورة) مع إخلاء الغرفة من كل ما يمكن أن يستخدمه المريض للإيذاء، وعلى المساعدين في العيادة أن يكونوا مهيأين للتدخل عند الحاجة، ويجب أن يكون الوصول إلى باب الغرفة سريعاً وممكناً للطبيب, وفي حالة هروب المريض يستعان بالشرطة للإمساك به.

4- على الطبيب عدم إهمال التهديدات التي توجه له بالهاتف أو بالرسائل وما شابه لان مثل هذا الإهمال قد يدفع المريض إلى الفعل الحقيقي.

5- يمكن إستخدام العقاقير التالية كمرحلة أولية وتعاد حسب الضرورة للسيطرة على السلوك العدواني:

Chlorpromazine (largactil): 100 mg i.m

Haloperidol (serenace): 10 mg i.m

6- نقل المريض إلى أقرب مركز متخصص لإكمال علاجه عند شعور الطبيب بضرورة ذلك .

7- معالجة الإضطراب النفسي الأساس للمريض والذي أدى إلى حالة الهياج والعدوانية لديه وحسب نوع الإضطراب.

الاضطرابات النفسية العضوية

وتعرف بأنها الإضطرابات الذهانية المصاحبة لأي إختلال عضوي أو وظيفي في الدماغ نتيجة التهاب أو تنكس Degeneration أو شدة خارجية على الدماغ، أو أي مرض بدني يستدل عليه بواسطة الفحوصات الطبية المتنوعة. وتشمل ما يلي:

1- الاضطرابات العضوية الحادة مثل الهذيان

الصفات السريرية:

إضطراب حاد في الوعي والإدراك مع قلة التركيز وضعف الذاكرة يصاحبها أحياناً هلاوس وأوهام, تشتد هذه الأعراض أحياناً وتتهاود في أحيان أخرى ولكنها تكون شديدة وسيئة أثناء الليل عادة.

الأسباب:

أولاً: الإلتهابات الجرثومية بصورة عامة وخاصة التهاب المجاري البولية أو الصدر.

ثانياً: إختلاطات ما بعد العمليات الجراحية.

ثالثاً: العقاقير الطبية (مثل المهدئات, المنبهات, مشتقات الأتروبين, الستيرويدات والديجوكسين)

رابعاً: الأعراض الأنسحابية للكحول والأدوية المخدرة.

خامساً: أحتشاء العضلة القلبية.

سادسا: الجلطة الدماغية والشدة على الرأس والصرع.

التدبير: Managment

يكون في المستشفى عادة حيث يتوجب إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة السبب ومعالجته ولابد من تقديم الرعاية الطبية في جو هادئ ذي إنارة مناسبة مع الحفاظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم, ويمكن إستعمال العقاقير المهدئة مثل : اللارجكتيل أو السرنيز في الحالات الشديدة.

2- الأضطرابات العضوية المزمنة ومثالها الخرف

الصفات السريرية:

تدهور تدريجي في القابليات الذهنية والفكرية مع إضطراب الذاكرة وعدم القدرة على إستيعاب المعلومات والمهارات الحديثة مع إضطراب الإدراك للزمان والمكان

والأشخاص يصاحبها تغير في الشخصية وظهور بعض الهلاوس والأوهام ويتعرض المريض بين وقت وأخر إلى حالة هذيان شديدة أو خفيفة قد تطول أو تقصر. هذا و تتراوح أعراض الخرف من النسيان البسيط والقيام ببعض التصرفات الشاذة كوضع الملابس القذرة في الثلاجة إلى خروج المريض للشارع تائهاً لايعرف مكانه وزمانه.
يحصل خرف الشيخوخة بنسبة حوالي5% لدى المسنين بعد 65 - 70 سنة ولما كان من المتوقع زيادة متوسط العمر في المجتمعات عامة فأن العدد المتوقع للمصابين بالخرف سيزداد تبعاً لذلك.

الأسباب:
أولاً : تنكسية Degenerative مثل داء الزهايمر وبيكس.
ثانياً : وعائية كالنزف تحت السحايا أو أحتشاءات في الدماغ.
ثالثاً : التهابات الجهاز العصبي المركزي ومنها السفلس والإيدز ومرض جنون البقر.
رابعاً : التصلب المنتشر Multiple sclerosis
خامساً: إضطرابات الغدد الصماء مثل قلة إفراز الغدة الدرقية.
سادساً : أمراض أخرى مثل داء الرقص Huntington chorea والشلل الأهتزازي Parkinsonisim

التدبير:
معظم حالات الخرف مزمنة ولايوجد دواء نوعي شاف لها, ولكن لابد من الفحص والتأكد من وجود بعض الأسباب المرضية التي تسبب تدهور القدرات الذهنية المشابه للخرف والتي يمكن علاجها إذا شخصت مبكراً مثل أستسقاء الدماغ ذي الضغط العالي الذي يعالج جراحياً, أو حالات قلة إفراز الغدة الدرقية أو نقص فيتامين B12 والنياسين أو السفلس.

اما على مستوى الرعاية الصحية الأولية فمن المهم جداً توعية ذوي المريض وإرشادهم في كيفية التعامل معه وتقديم العناية التمريضية والإجتماعية المناسبة ومراجعة الطبيب عند حصول طوارئ كالهذيان.

الإضطرابات الذهانية
PSYCHOTIC DISORDERS

وهي الإضطرابات التي تتصف بوجود إختلال في التفكير والعاطفة والكلام والسلوك مصحوبة بعدم القدرة على التمييز بين الحقيقي وغير الحقيقي أو بين الصح والخطأ؛ فتكثر الهلاوس والأوهام وتتناقص صلة المريض بالعالم الواقعي الخارجي, وقد تصل احياناً في الحالات الشديدة إلى أن يعيش منعزلاً في دنيا خاصة به فقط . ويضاف إلى ذلك كله تدهور عام تدريجي في الشخصية.
سببها غير واضح تماما في الوقت الحاضر و تشير دراسات الكيمياء الحياتية إلى إحتمال وجود إختلال في الإمينات العضوية Biogenic amines ومستقبلاتها Receptors في الخلايا العصبية. وتشمل هذه الإضطرابات ما يلي:

أ- الفصام **Schizophrenic disorders**

ب- إضطرابات الوهم **Delusional disorders**

أ- اضطراب الفصام

يطلق لفظ الفصام (فصام العقل) على نوع من أنواع الإضطراب الذهاني الذي يصيب الأشخاص في مرحلة المراهقة والشباب عادة، وتظهر أعراضه بدرجات متفاوتة وهم يشكلون النسبة الأكبر من الراقدين في المستشفيات النفسية ومن أهم أسبابه العوامل الوراثية والبيوكيمياوية وهناك من يعزوه إلى عوامل نفسية وإجتماعية عديدة.
الأعراض: تشمل إختلالاً في أغلب النواحي العقلية

1- **التفكير:** ويتصف بصعوبة في التفكير وبطء مجراه وأحياناً عدم تناسق محتويات الفكر ويظهر ذلك في عدم ترابط الكلام.

2- **الكلام:** قد يكون طبيعياً أو ربما أستعمل المريض الألفاظ العادية في غير معانيها المتعارف عليها أو كثرت في كلامه الرموز والكلمات المستحدثة. وقد يلزم المصاب الصمت المطبق أو يكتفي بالإيماءات والإشارات.

3- **التمييز:** يفقد المريض قدرته على التمييز بين ما هو حقيقي وغير حقيقي . فتظهر لديه الهلاوس والأوهام فقد يعتقد إن الناس من حوله يقرأون أفكاره أو يؤثرون عليه بوسائل سحرية أو ألكترونية ويدفعونه لأفعال معينة وغير ذلك.

4- **الوجـدان:** يتبلـد أو يخمـل الوجـدان أو العواطـف فتـنقص أو تنعـدم الإسـتجابة العاطفية لمختلف المواقف فيقطع المريض صلته بالعالم الخارجي رويداً رويداً ويصبح عديم المبالاة أو غريب الاستجابة لما يدور حوله من أحداث فقد يضحك في المواقف المحزنة وقد يبكي في المواقف المفرحة مثلاً.

5- **السلوك:** قد يفقد المريض أرادته وقدرته على الحركة أو يقوم بأعمال إندفاعية عنيفة وخطرة وأحياناً منافية للعرف واللياقة والقانون وقد تصدر منه ألفاظ وتصرفات غير محتشمة خلافاً لما كان يتصف به من براءة وإحتشام, وفوق ذلك كله فقد يفقد المريض بصيرته فهو لايعتبر نفسه مريضاً وبالتالي يرفض مراجعة الأطباء ويرفض مساعدتهم وعلاجهم له.

العلاج:

1- **إسـتعمال العقـاقير الطبيـة المضـادة للـذهان** مثـل اولانـزابين، اللارجكتيـل, الهالوبيريدول، بجرع علاجية قد تبدوعالية، مع الأخذ بنظر الإعتبار ظهور الأعراض الجانبية للدواء ومن أهمها رعشة في اليدين وأعراض مشابهة للشلل الأهتزازي (الرعاشي) والتململ والتشنجات العضلية التي قد تصيب عضلات الوجه واللسان والرقبة والجذع مما تستوجب المعالجة الفورية بعقار البروسيكادين (الكيمادرين) بالوريد او العضلة حسب الحقن المتوفرة.

2- **العلاج الكهربائي:** ويعطى من قبل الطبيب الإختصاصي فقط. وذلك بأعطاء الصدمات الكهربائية محسوبة العدد والفترات والتي تؤدي إلى تحسن بعض حالات الفصام ومن أهمها الفصام الجمودي والإضطهادي وهو علاج آمين عادة ومضاعفاته نادرة ولكنه لايستعمل إلا عند الضرورة الفعلية.

3- **العلاج النفسي السلوكي:** ويبدأ دوره بعد تحسن حالة المريض وعودة إتصاله بالواقع ويكون بتفهم حالته النفسية وإرشاده.

4- **التأهيل المهني والإجتماعي:** بتأهيله لأنسب الأعمال التي يستطيع القيام بها كالخط, الرسم, الخياطة, التطريز, النجارة، أو الحدادة, وغيرها مما يساعد على رجوع المريض إلى مهنته الأصلية أو تعلم مهنة جديدة والقضاء على العزلة الإجتماعية والإشتراك بالفعاليات الإجتماعية داخل الردهة وخارجها.
وتقوم الممرضة والباحثة الإجتماعية بتعليم المريض النظافة وأصول المائدة

وآداب الكلام وملء أوقات الفراغ وتوعية العائلة وتدريبهم للاستمرار في ذلك.

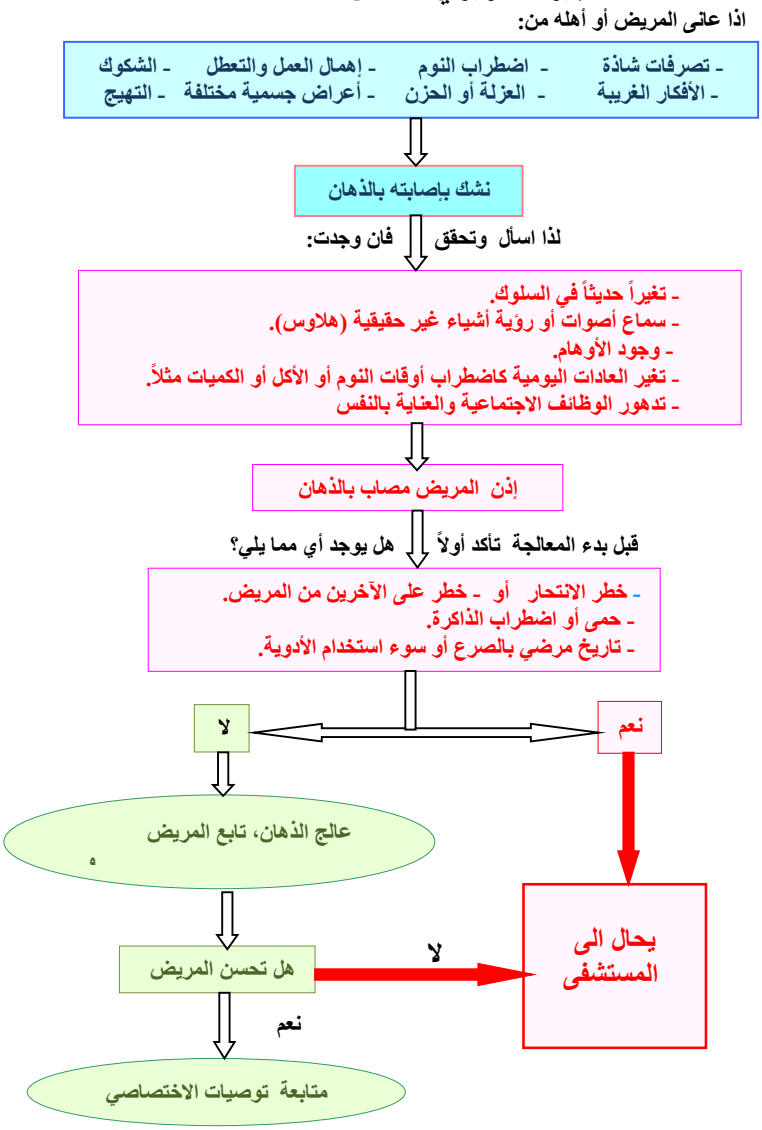
وأهم واجب لطبيب الرعاية الصحية الأولية هو توعية العائلة ومساعدتهم على تقبل حالة المريض ومداراته حيث يتطلب علاج هذه الحالات الكثير من الصبر والأناة. كما يمكن للمركز الصحي متابعة حالة المريض وعلاجه بعد تحسن الحالة وتحديد العلاج من قبل الطبيب الإختصاصي.

ب- أضطراب الوهم

ويتصف بظهور فكرة خاطئة واحدة أو أكثر غير قابلة للتغيير رغم كل المبررات المنطقية (وهم) مع عدم وجود أي أعراض أخرى تؤدي إلى تشخيص مرض الفصام, وإذا ظهرت الهلاوس فأنها تكون ثانوية وذات علاقة بالفكرة الخاطئة.

تظهر الأعراض في العادة عند سن 30- 40 سنة من العمر أو بعد ذلك ولا تؤدي إلى تدهور في الشخصية, وغالباً يتعايش المريض مع حالته المرضية ولكنها أحياناً تؤثر بصورة شديدة في تصرفاته وعلاقته بمن حوله وتدفعه إلى إلحاق الأذى (وربما ارتكاب جريمة) بحق المقربين إليه نتيجة شعوره الإضطهادي تجاههم مما يستوجب المعالجة الفورية بالعقاقير المضادة للذهان ومن قبل الطبيب الإختصاصي, ومن الأفضل أن يكون ذلك في المستشفى.

مخطط التدبير السريري للذهان



الأدوية المضادة للذهان

- حب أولانزابين (زايبركسا) (5) ملغم/ بجرعة 1×2
- حب هالوبيريدول (سرنيز) (1,5) و (5) ملغم/ بجرعة 2- 3/ يوم
- حب كلوربرومازين (لارجاكتيل) (50- 100) ملغم/ بجرعة 2- 3/ يوم

الإضطرابات الوجدانية (المزاجيـة)

MOOD DISORDERS

الاضطراب الاساس في هذه الامراض هو الحزن او الفرح الشديدين لدرجة تؤثر على نمط حياة الفرد وعلى قابليته على العمل وعلاقاته مع الناس في المجتمع. ويمكن من الناحية العملية تقسيمها إلى:

1. الكآبة:

أ - الكآبة الشديدة Major Depression

ب- الكآبة البسيطة Minor Depression

2. الهوس Mania والهوس الخفيف Hypo Mania

3. الأمراض المزاجية الثانوية.

****

1- الكآبة

أ - الكآبة الشديدة :

تحدث في سن 18-44 سنة وتصيب النساء أكثر من الرجال، وهي أكثر انتشاراً بين المطلقين والعاطلين عن العمل.

الأعراض والتشخيص:

يتطلب تشخيص هذه الحالة وجود خمسة أو أكثر من الأعراض التالية خلال الأسبوعين السابقين وعلى أن يكون بضمنها الأول أو الثاني إضافة للأعراض الأخرى:

أولاً: الشعور بالحزن والاكتئاب، وتزداد شدة الشعور بالحزن في الصباح عنه في المساء.

ثانياً: فقدان الاهتمام والاستمتاع بفعاليات الحياة اليومية وعدم الشعور بلذة الحياة.

ثالثاً: فقدان الشهية للطعام وفقدان الوزن وهي المظاهر العامة في معظم حالات الكآبة إلا أن بعض المرضى تزداد شهيتهم للطعام ويزداد وزنهم.

رابعاً: الأرق والاستيقاظ المبكر وعند بعض المرضى تزداد ساعات النوم.

خامساً: الجمود الفكري والبدني أو التهيج.

سادساً: الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة.
سابعاً: الشعور بانعدام قيمة الفرد أو الشعور بالذنب.
ثامناً: صعوبة التركيز الذهني وانعدام القدرة على التفكير واتخاذ القرارات.
تاسعاً: أفكار متكررة عن الرغبة في الموت أو الانتحار أو وضع خطط للانتحار أو محاولته فعلاً.

وفي حالات الكآبة العقلية (الذهانية) Psychotic Depression والتي تعتبر من الحالات النادرة تظهر أعراض أخرى إضافة لما ذكر أعلاه وهي الأوهام وخاصة أوهام الشعور بالذنب والإثم وأوهام الفقر وأوهام المرض والأوهام العدمية والأوهام الأضطهادية، كما وتظهر الهلاوس خاصة السمعية ويكون المريض فاقداً للبصيرة (Loss of insight)

ب. الكآبة البسيطة:

وهي أكثر أنواع الكآبة انتشارا وقد ارتفعت نسبة وقوعها بشكل ملحوظ وتحدث عادة في سن العشرين والثلاثين.

الأعراض:

تتصف هذه الحالة بظهور أعراض مشابهة للكآبة الشديدة والفرق بينهما هو في شدة الأعراض ودرجة تأثيرها على نمط حياة المريض وعلاقاته الاجتماعية وقدرته على العمل؛ حيث يعاني المريض من الشعور بالحزن واليأس والأسى وعدم القدرة على الاستمتاع بمباهج الحياة وخمود الهمة ونقص الاهتمام بأمور الحياة اليومية وانعدام الثقة بالنفس وتقليل قيمة الذات.

وقد يكون الشعور بالحزن مستمراً أو يتناوب مع فترات من المزاج الطبيعي والذي يمتد لفترة زمنية لا تتجاوز عدة أسابيع.

تكون ردود فعل المريض لمشاكل الحياة اليومية مبالغ فيها ويتصف المريض بالشكوى الكثيرة ولوم الآخرين والأسى على النفس عند تعرضه للفشل أو الإحباط ويكون الفرد ملحاحاً وعادة تظهر في شخصيته سمات الوسواس والقلق.

وتتميز الكآبة البسيطة بالانفعال المزاجي الشديد والقلق والتوتر وعدم الأستقرار النفسي والبدني وعادة ما يكون الأرق في أول الليل، كما وأن الشعور بالحزن يكون على أشده في المساء وكنتيجة لأعراض هذه الحالة فأن الحياة الاجتماعية للفرد تكون محدودة كما وأن علاقاته مع الناس غير مستقرة وهم أكثر عرضة للتعود والإدمان على الكحول والعقاقير.

ان معظم حالات الكآبة البسيطة تستمر لفترة قصيرة وتظهر بعد تعرض الفرد لتجارب نفسية قاسية كالفشل العاطفي أو الخسارة المادية أو المعنوية أو موت شخص عزيز. على أن بعضا من هذه الحالات تستمر لشهور أو سنين ويعتمد هذا على شخصية المريض وخصوصية الحالة المرضية.

علاج الكآبة:

لا توجد طريقة علاجية واحدة أو عقار واحد يضمن الشفاء لجميع المرضى وقد تختلف استجابات المرضى للعلاج حتى في الحالات المتشابهة، وقد يحتاج الطبيب للجمع بين أكثر من طريقة في آن واحد ويعتمد هذا على خبرته الشخصية وحالة المريض واستجابته.

تعالج معظم الحالات في العيادة الخارجية ولكن يجب إدخال المريض للمستشفى لحمايته وحماية الآخرين وتقليل معاناته في الحالات التالية:

أولاً : التفكير بالانتحار أو محاولته فعلاً.

ثانياً : تدهور الصحة العامة للمريض أو امتناعه عن تناول الطعام.

ثالثا : إذا كانت ظروف المريض العائلية غير مناسبة.

هذا وتستعمل الأساليب التالية في العلاج:

أولاً: الصدمة الكهربائية ECT، وهي أكثر فائدة في حالات التفكير بالانتحار أو التوقف عن تناول الطعام.*(عندما يصبح المريض خطراً على نفسه أو الآخرين ولايستجيب للعلاجات الأخرى)*

ثانياً: العقاقير المضادة للكآبة، وهي كثيرة ومتنوعة ولابد للطبيب أن يلم جيداً بالعقاقير التي يصفها للمريض وإن يشرح للمريض وعائلته الآثار الجانبية لها وللفترة التي تستغرقها لتعطي مفعولها. ويجب أن تعطى العقاقير بجرعة بسيطة ثم تزاد تدريجياً وحسب استجابة المريض وعمره. ومن أكثر العقاقير استعمالاً

- التربتزول وله تأثير مهدئ ويفيد في حالات اضطراب النوم.
- التوفرانيل ويستخدم في حالات الكآبة المتميزة بالخمول النفسي والحركي.
- الفلوكستين.

ثالثاً: العلاج النفسي: ويهدف إلى تقديم الإسناد المعنوي عن طريق التعاطف والتقدير والاهتمام بمساعدة المريض على كسب تقدير نفسه واستعادة ثقته بها وزرع الأمل بالشفاء وبيان الجوانب الأيجابية في حياته والابتعاد عن الأفكار السلبية. وهذا العلاج مهم كثيراً لحالات الكآبة البسيطة.

رابعاً: العلاج الأجتماعي: ويتضمن البحث عن الأسباب الاجتماعية كالمشاكل العائلية والزوجية والعزلة الاجتماعية والبطالة والمشاكل المالية التي أدت إلى حدوث الكآبة ومساعدة المريض على تفهم ومعالجة هذه الأسباب، وفي حالة عدم القدرة على التغيير ومعالجة هذه الأسباب الاجتماعية فعلى المريض أن يتكيف ويتأقلم معها.

الوقاية من الكآبة:

عند معالجة حالات الكآبة الشديدة يتفق معظم الباحثين على ضرورة تناول العقاقير المضادة للكآبة لفترة ستة أشهر بعد الشفاء لمنع تكرار وقوعها ويجب تقليل الجرعة بصورة تدريجية على مدى 1-2 شهر منعاً لظهور الأعراض الأنسحابية للعلاج.

2- الهوس

ويحدث عادة بين سن 20 - 25 سنة وقد يكون خفيفاً Hypomania . أو شديداً Mania وفي بعض الحالات فانه يتوالى مع الكآبة ويسمى بداء الهوس الأكتئابي أو الأضطراب المزاجي ذو القطبين (Bipolar).

الأعراض:

يكون الشعور العاطفي الغالب هو الشعور بالفرح والنشوة ومن صفاته:

أ - نشاط زائد وتدخل في شؤون الآخرين وهياج وعدوانية.

ب- ارتفاع المزاج والسعادة الغامرة.

ج- أوهام العظمة أو الثقة العالية بالنفس والاعتزاز بها ووجود الهلاوس السمعية التي تتصف بالزهو والمديح وأحياناً يعتبرها كأصوات إلهية.

د- سرعة التفكير وتطاير الأفكار حيث ينتقل المريض بسرعة من موضوع إلى آخر دون وجود رابطة معقولة بين المواضيع الكثيرة التي يطرقها.

هـ- تشتت الانتباه وضعف التركيز.
و- أعراض بيولوجية ومنها قلة النوم وزيادة النشاط الاجتماعي والجنسي.
ز- القيام ببعض التصرفات المخجلة والإباحية وصرف النقود بتهور وشراء وبيع الأشياء الخاصة بثمن بخس وبدون مبررات.

أما بالنسبة للهوس الخفيف Hypomania فيختلف عن الهوس بكون الأعراض السريرية أقل شدة وأقل تأثيراً على الحياة الاجتماعية للفرد والمجتمع.

علاج الهوس:
أ- العلاج الدوائي: بواسطة العقاقير المضادة للذهان مثل السرنييز واللارجكتيل وأحياناً التكريتول.
ب- العلاج الكهربائي: يستعمل نادراً للسيطرة على النشاط الزائد للمريض ويسرع في شفائه.
ج- إستعمال عقار الليثيوم مع التكريتول أو الكلونازابين مع الديباكين في الحالات المقاومة للعلاج.

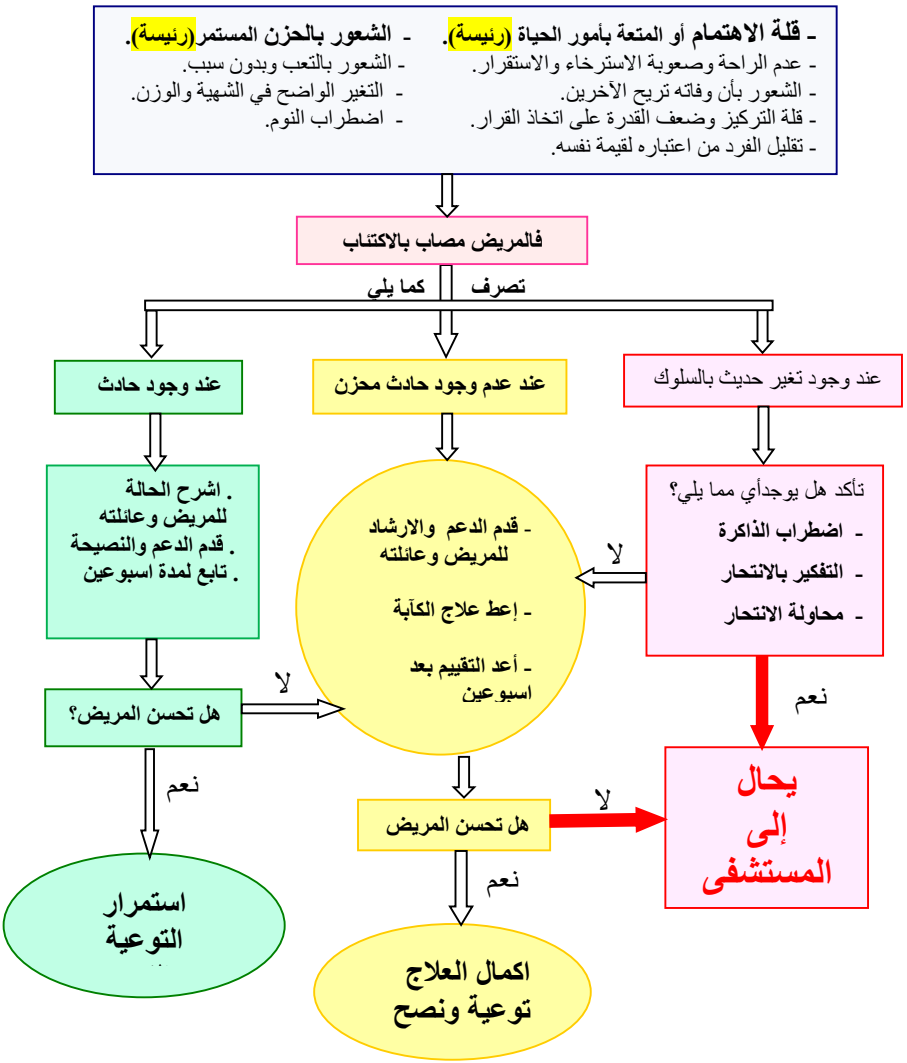
(ملاحظة: يرجى مراجعة فصل الطوارئ النفسية – المريض المتهيج أو العنيف)

3- الأمراض المزاجية الثانوية (الهوس أو الكآبة)

الأمراض المزاجية الثانوية الناتجة عن الإصابة بمرض بدني وخاصة إصابات الدماغ واضطراب الغدد الصماء أو أنها ناتجة عن الإصابة بالأمراض النفسية الأخرى أو استخدام المخدرات والعقاقير.

مخطط التدبير السريري للاكتئاب

إذا عانى المريض لمدة أسبوعين أو اكثر من خمسة أعراض مما يلي ومنها واحدة رئيسة على الأقل



الأدوية المضادة للكآبة:

- حب امبرامين (توفرانيل) (10) و(25) ملغم/ الجرعة: واحدة ليلاً وتزاد تدريجياً (الحد الأقصى 3مرات/ يوم)
- حب امتربتلين (تربتزول) (10) و(25) ملغم/ الجرعة: واحدة ليلاً (الحد الأقصى 3مرات/ يوم)
- كبسول فلو كستين (بروزاك) (20) ملغم/ الجرعة: 1- 2/ يومياً

الأضطرابات الانفعالية (العاطفية)

EMOTIONAL DISORDERS

هذه الاضطرابات مهمة جداً لأنها من أكثر الاضطرابات شيوعاً التي تواجه الطبيب في الممارسة اليومية. وهي مجموعة من الأضطرابات وظيفية المنشأ (لايوجد سبب عضوي معروف لها لحد الأن) وتتصف بأعراض نفسية تماثل الأنفعالات التي تحدث لمعظم الناس في حياتهم اليومية ولكنها تختلف عنها في الشدة. ولكن مهما كانت هذه الأعراض شديدة فهي لا تشمل ظهور اعراض الأمراض الذهانية (مثل الأوهام والهلاوس، أو فقدان البصيرة،).

والمصاب بالأضطراب الانفعالي (العصابي) يعاني من الأعراض التي تقلق راحته وتؤثر على وظائفه النفسية والاجتماعية والبدنية وعلى انجازه لواجباته اليومية مما يدفعه لزيارة الطبيب وطلب المشورة للتخلص من هذه الأعراض. هذه الاضطرابات متعددة وسنذكر فيما يلي شرحاً موجزاً لما يلي منها:

1- **اضطرابات القلق**:

أ- أضطراب القلق العام

ب- أضطراب الذعر (الرعب)

ج- الرهاب

2- **اضطراب وسواسي قسري**

3- **اضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة:**

أ- الانفعالات الحادة

ب- الكرب بعد الشدة

ج- اضطراب التأقلم

4- **اضطرابات انفصالية (تحويلية)**

5- **اضطرابات جسدية الصور:**

أ- الاضطراب التجسيدي

ب- المراق

1- اضطرابات القلق ANXIETY DISORDERS

وهي المجموعة الأولى من الأضطرابات الانفعالية، ويشمل اضطراب القلق العام، اضطراب الرهاب، واضطراب الذعر. وفيما يلي شرح موجز لها:

أ- اضطراب القلق العام

وهو شائع بين مراجعي العيادات الطبية ويصيب حوالي (65-25) بالالف من السكان سنوياً. ويعتقد ان كلاً من الوراثة والتربية في الطفولة تلعب دوراً في حدوثه. وهو يصيب الأفراد مهما كانت انماط شخصياتهم.

ومن العوامل المرسبة له:

- الظروف التي تسبب ضغطا نفسياً وتهدد طمأنينة الفرد.
- العلاقات الشخصية المضطربة.
- الخوف من الفشل، من الأمراض العضوية والخوف من فقدان ما يعتز به الفرد.

الأعراض: كثيرة ومتنوعة، **و** قد تكون نفسية، بدنية أو مختلطة وأهمها:

أهم الأعراض النفسية: الخوف من المجهول، توقع الخطر دون وجود مبرر كاف، سرعة الأستثارة، التحسس من الضوضاء، الشعور بالضيق وعدم الأستقرار، وضعف التركيز.

الأعراض البدنية: تشمل معظم اجهزة الجسم، و تنشأ من فرط نشاط الجهاز السمبثاوي (العاطفي) وزيادة التوتر العضلي. وأهمها جفاف الفم، صعوبة البلع، اضطراب المعدة، الغثيان، الغازات المعوية، الإسهال، ضيق التنفس والصدر، التنفس العميق او السريع، خفقان القلب، كثرة التبول، ضعف إنتصاب العضو الذكري، إضطرابات الطمث، الإرتعاش وأحاسيس غير طبيعية كالتنمل والوخز، طنين الأذن، الدوار، الصداع، الألام العضلية المختلفة.

وعلى الطبيب أن يميز إضطرابات القلق عن الأمراض الأخرى التي قد يكون القلق واحداً من أعراضها مثل فرط إفراز الغدة الدرقية، إضطرابات الغدة الكضرية (suprarenal gland)، هبوط السكر في الدم، داء الإكتئاب، الفصام، الخرف و سوء استخدام الكحول والعقاقير والمواد الأخرى.

العلاج:

وهو نفسي بالدرجة الأولى؛ بتطمين المريض وارشاده لحل مشاكله الخاصة بشكل مناسب، مع ممارسة تمارين الأسترخاء والسيطرة على التنفس. وقد نستعمل (لدورات قصيرة) العقاقير المضادة للقلق مثل الديازيبام Diazepam (الفاليوم) أو كلوردايزيبوكسايد chlordiazepoxide (الليبريوم) بجرعة 5 ملغم ثلاث مرات يومياً على ان لا تزيد الفترة عن اسبوعين واذا احتاج المريض لفترة أطول من العلاج فتجب إحالته إلى اختصاصي الطب النفسي.

ب- اضطراب الرهاب (الفزع)

في هذه الحالة يخاف المصاب من شيء معين معروف وغير مخيف عادة لمعظم الناس (مثل الحيونات الأليفة، المصاعد، الطائرات، .. الخ) فيلجأ المريض الى الابتعاد عن مصدر الخوف.

أما الأعراض فهي اعراض اضطراب القلق العام نفسها ولكنها تظهر فقط عند مواجهة الموقف المخيف أو عند توقع مواجهته بل وحتى عند التفكير به. أما في الأوقات الأخرى فالشخص يتمتع بحالة نفسية طبيعية وتختفي الأعراض منه.

ويشتمل الرهاب على الأنواع الرئيسة التالية:

- **الرهاب البسيط simple phobia:** وهو الخوف من أشياء محددة كالحشرات، الأماكن المرتفعة، والخ. و يحدث للأطفال عادة ولكنه قد يستمر مع تقدم العمر. وافضل علاج هو العلاج السلوكي.
- **الرهاب الأجتماعي social phobia:** حيث تظهر اعراض القلق عندما يكون الشخص تحت انظار أو مراقبة الأخرين له أو عند تعرضه لملاحظاتهم وأنتقاداتهم (عند القاء كلمة مثلا، او في الحفلات ..الخ) فيعاني من التعرق الشديد والخجل واعراض القلق العام الأخرى. ويحدث عادة للمراهقين وللكبار. ويستجيب معظم المصابين للعلاج المعرفي.
- **رهاب الساح (الخلاء أو الأماكن المفتوحة) agora phobia:** ويحدث عند ابتعاد المريض عن بيته أو عند تواجده في اماكن مزدحمة لا يمكن مغادرتها بسهولة كالقطارات ، دور المسنين ..الخ حيث يشعر المصاب بعدم إمكانية وصول الاسعافات الأولية إليه. يصيب البالغين عادة وهو اكثر حدوثاً بين الأناث. العلاج المفضل هو العلاج السلوكي.

ج- اضطراب الذعر (الرعب) Panic

وهو نوع من القلق الشديد الذي يظهر على شكل نوبات مرضية يعود الشخص بعدها الى وضعه الطبيعي. تحدث النوبة بشكل مفاجيء حيث تظهر اعراض القلق العام نفسها بصورة سريعة وشديدة، ويطغى على المريض الشعور بأنه سيموت أو سيفقد عقله او سيطرته على نفسه.

العلاج يكون بالتطمين وشرح الحالة والأسباب المرسبة لها. كما قد تستخدم مضادات القلق ومضادات الكآبة احياناً لتوقي تكرارها.

2- اضطراب وسواسي قسري Obssesive Compulsive Dis.

وهو المجموعة الثانية من الاضطرابات الانفعالية. يتسم هذا الأضطراب بوجود الوساوس أو الأفكار التسلطية بصورة رئيسة اضافة الى اعراض اخرى تعتبر ثانوية للأضطراب كالقلق والاكتئاب.

الوساوس هي كلمات، افكار، صور ذهنية images، شكوك doubts، دوافع impulses أو إجترارات rumminations لمناقشات في ذهن الفرد لانهاية لها، تدخل فكر المصاب بصورة قسرية رغم انه يحاول مقاومتها والتخلص منها ولكن دون جدوى. وهي ليست ذات معنى مفيد وقد تحوي معنى يخالف ويعاكس ما يؤمن به الفرد وقد تصل حد السباب والكلام البذئ وحتى الكفر. والمصاب يعرف ان هذه الأفكار تأتي من داخله وليست مفروضة عليه من الخارج (وهذا ما يميزها عن الوهم)، لكنه يجد نفسه ضعيفاً امامها.

وقد يكون محتوى الوسواس عدم اليقين (الشك) بأمور سبق وان انجزها كقفل الباب مثلاً أو اطفاء النور؛ مما يدفعه الى العودة وتكرار التحقق مما فعله. وقد يشكك بعدد الركعات التي صلاها أو بأتمامه الوضوء.

تأخذ الدوافع شكل رغبات لعمل أمر ما غير مقبول منه ولا يتناسب مع وضعه ويرفضه عادة مثل العنف تجاه الأطفال أو الكفر امام الأخرين. وكل ذلك يقترن بمقاومة شديدة من داخله لمنع ذلك، فيسبب هذا الصراع بين الدافع ومنعه ضغطاً نفسياً شديداً للمصاب.

وهناك ما يسمى بالأفعال القسرية compulsive rituals وهي ان يقوم المصاب وبقسر من داخله بأعمال لايجد ضرورة أو مبرراً لها ولكنه لا يهدأ قبل ان يفعلها ومنها مثلاً غسل اليدين عشرات المرات أو تكرار عد الأشياء. ويسبق هذه الأفعال عادة افكار تسلطية كالشك بالنظافة أو عدم اليقين من صحة عدد الأشياء.

ان هذه الأفكار التسلطية والأفعال القسرية تؤخر الشخص عن عمله وتؤثر على انجازه لواجباته كما تنتج عنها اعراض ثانوية كالقلق والكآبة.

معظم المصابين بهذا الأضطراب (حوالي الثلثين) هم من ذوي نمط الشخصية الوسواسية القسرية obsessive – compulsive personality (وهي الشخصية المثالية الدقيقة التي تتمسك بالتقاليد والقيم والمتصلبة وتميل الى التفاصيل وإعادة التحقق من كل شيء).

يعزى هذا الأضطراب الى عوامل الوراثة أو اضطرابات عضوية في الدماغ أو الى التربية وخبرات الطفولة عندما تكون الأم من النمط الوسواسي. وغالباً ما يظهر الأضطراب بعد التعرض الى الشدة النفسية.

علاج الحالة يكون بالعلاج النفسي الإسنادي supportive psychotherapy بتطمين المصاب الذي يخشى حدوث عواقب نفسية وخيمة وبتطمينه ايضاً بأنه لن يستجيب للدوافع المرفوضة كالعنف والإيذاء. ويجب توضيح الحالة ومناقشتها مع عائلة المصاب ليتعاونوا ويساهموا في منع اعادة الأفعال القسرية، وحسب توجيهات الطبيب المعالج.

ويستعمل العلاج السلوكي احياناً. كما أن للعقاقير دورها ايضاً فقد تستعمل مضادات القلق ومضادات الأكتئاب وخاصة عقار الكلومبرامين (الأنفرانيل).

3- إضطرابات التكيف والكرب بعد الشدة
Reaction to severe stress & Adjustment disorders

وهي الإنفعالات التي تحدث جراء التعرض للضغوط النفسية (الكروب) ويمكن تصنيفها الى:

أ- الإنفعالات الحادة Acute Stress reaction

وتظهر غالباً عقب التعرض للكرب الشديد مباشرة (خلال الشهرالاول) وتستمر لفترة لا تتجاوز البضعة أيام- أقل من شهر. ويعتمد هذا الإنفعال على نوع الكرب، فاذا كان الكرب ذا محتوى مخيف أو فيه تهديد أو خطورة فأن الإنفعال يأخذ شكل القلق النفسي. وإذا كان الكرب هو فقدان شخص أو شيء عزيز جداً وبصورة مفاجئة (كما في حوادث الطرق أو الحرائق مثلاً) فالإنفعال يأخذ شكل الإكتئاب. وهكذا فقد يأخذ شكل القلق والإكتئاب معاً أذا إجتمع في الكرب التهديد والفقدان.

يعاني المصاب من قلة النوم، ضعف التركيز، الشعور بالدوخة والخفقان والارتعاش إضافة الى اعراض القلق والكآبة الأخرى.

يتضمن العلاج تخفيف الانفعال العاطفي بتشجيع المصاب للتحدث عما أصابه وعما يشعر به، وتوجيه الأسئلة التي تساعده على استحضار ذكريات الحدث واستيعاب آثاره السلبية. ومن المفيد وصف مضادات القلق لعدة ايام.

ب-اضطراب الكرب عقب الرتح (الشدة) PTSD

وهو انفعال شديد يظهر خلال الاشهر الستة التي تعقب الحادث وقد يتأخر ظهوره احياناً اكثر من ذلك، ويستمر لفترة طويلة عادة، وفي احيان أخرى يظهر عقب الأنفعال الحاد مباشرة ويعتبر استمراراً له.

يمكن أن يصيب أي شخص شاهد أو تعرض لشدة (رتح) قوية غير اعتيادية (كالزلازل، الحرائق، القصف الحربي، الأغتصاب ..الخ) وفيها تهديد له في حياته او في جسده .وخاصة اذا كانت الحادثة غير متوقعة. واكثر الناس عرضة للأصابة به هم الأطفال والشيوخ والذين يعانون اصلاً من اضطرابات نفسية.

أهم اعراض الحالة:
القلق المستمر، سرعة الأنفعال، صعوبة النوم، قلة التركيز، نوبات من الذعر أو العدوانية، تجاهل وتجنب المصاب لكل ما يذكره بالحادث أو يدل عليه، نوبات استذكار للحادث مصحوبة بانفعالات شديدة مشابهة للتي حدثت اثناءه، الأنهماك في صور الحادث والأحلام المرعبة المتكررة مع فقدان الرغبة باي نشاط. كما تحصل تغيرات في شخصية المصاب.
علاج الحالة يشابه علاج حالة الأنفعال الحاد ولكن بتركيز وتفصيل اكثر، وتتلاشى الحالة عادة خلال اشهر عادة وفي حالات نادرة قد يستمرلسنوات.

ج- اضطراب التأقلم Adjucment Disorder

وهو الانفعالات النفسية التي تحدث للفرد جراء عدم التكيف للمتغيرات المهمة الحاصلة في حياته ومحيطه (مثل الطلاق، الفصل من الوظيفة، الأنتقال من الأعدادية للجامعة، أو فقدان شيء عزيز ..الخ)
الأعراض تشابه اعراض الأنفعال الحاد ولكن تظهر تدريجياً وتستمر لمدة اطول. يستوجب العلاج تخفيف القلق وذلك بحث المريض على التعبير عن مشاعره وتشجيعه على التخلص من افكار الحدث وعدم الأبتعاد عنه، ومساعدته باستعراض الحلول المختلفة ليختار الحل الأنسب له. هذا وقد تستخدم مضادات القلق لفترات قصيرة0

5- اضطرابات انفصالية (تحويلية)
Dissociative (conversion) disorder

في هذا الإضطراب(المسمى الهستيريا سابقاً) يتحول القلق ليظهر بشكل أعراض جسدية ليس لها أساس عضوي. و من المؤشرات الدالة على هذه الحالة:

أ- عدم تطابق الأعراض مع أعراض المرض العضوي الحقيقي.
ب- لامبالاة المريض بالأعراض الجسدية.
ت- وجود ما يدل على حصول المريض على كسب أولي primary gain وهو التخلص من القلق وكسب ثانوي secondary gain وهو جلب إنتباه الآخرين لمشكلته.

ومن **الأعراض الجسدية الشائعة**: أعراض حركية (شلل الأطراف، الإرتعاش والحركات اللاإرادية). وأعراض حسية (الصمم، العمى، الخرس، فقدان الإحساس أو زيادته).

أما **الأعراض النفسية الشائعة** الانفصالية فمنها فقدان الذاكرة، الذهول.
يعزى هذا الإضطراب الى وجود صراع داخل الفرد يسبب القلق الذي يتحول لاشعورياً (ولا إرادياً) الى أعراض عضوية ونفسية.
عند **التشخيص** يجب أن نفتش عن العوامل المثيرة وهي إجتماعية عادة، ونتأكد من عدم وجود سبب عضوي مع وجود مبرر نفسي لحدوث الإضطراب ووجود الكسب الأولي والثانوي.

العلاج نفسي ولابد من محادثة المريض على إنفراد وتشجيعه على التحدث عن صعوباته ومساعدته على إختيار الطريق الأمثل لتذليلها، مع التطمين بعدم وجود مرض عضوي. وقد نستعمل مضادات القلق لفترة قصيرة.

6- الأضطرابات جسدية الصور Somatoform Disorders

(تسمى ايضاً المحاكية للأضطرابات الجسدية، أو شبيهة الأمراض العضوية)
وتمتاز بأن المريض يشكو من أعراض بدنية متعددة أو متكررة (مع عدم وجود أي مؤشر أو دليل على وجود أساس عضوي لها) كما تمتاز بتكرار إجراء الفحوص السريرية والمختبرية برغم كون نتائجها طبيعية وتأكيد الأطباء بعدم وجود مرض عضوي. وتستمر هذه الحالة لسنوات متعددة وتؤثر على أداء المريض لوظائفه. وتشمل هذه الأضطرابات ما يلي:

أ- الأضطراب التجسيدي Somatization Dis

وأهم صفاته، شكوى المريض من أعراض جسدية متعددة ومتكررة وغالباً ما تتغير من فترة لأخرى وتستمر لسنوات عديدة. يراجع المريض اطباء عديدين ويجري الفحوصات الكثيرة ولا يظهر فيها خلل. وقد يعرض نفسه للعمليات الجراحية أيضاً. ويصر على وجود المرض رغم نفي الأطباء وتأكيدهم.
وأهم الشكاوى الجسدية:
- هظمية: كألم البطن، الغثيان، التقيؤ والتجشوء.
- جلدية: كالحكة، الحرقة، التنمل، الدغدغة، بقع وبثور.
- أعراض جنسية وحيضية.

تبدأ الشكاوي بعمر مبكر عادة ويرافقها القلق والحزن ويصاب النساء بها أكثر من الرجال عادة.

العلاج:
يجب عدم الإسراف بإجراء الفحوصات أو وصف الأدوية غير اللازمة التي لا تخلو من أضرار جانبية ويجب عدم الإستجابة لطلبات المريض في ذلك مع الإصرار على العلاج النفسي والتطمين.

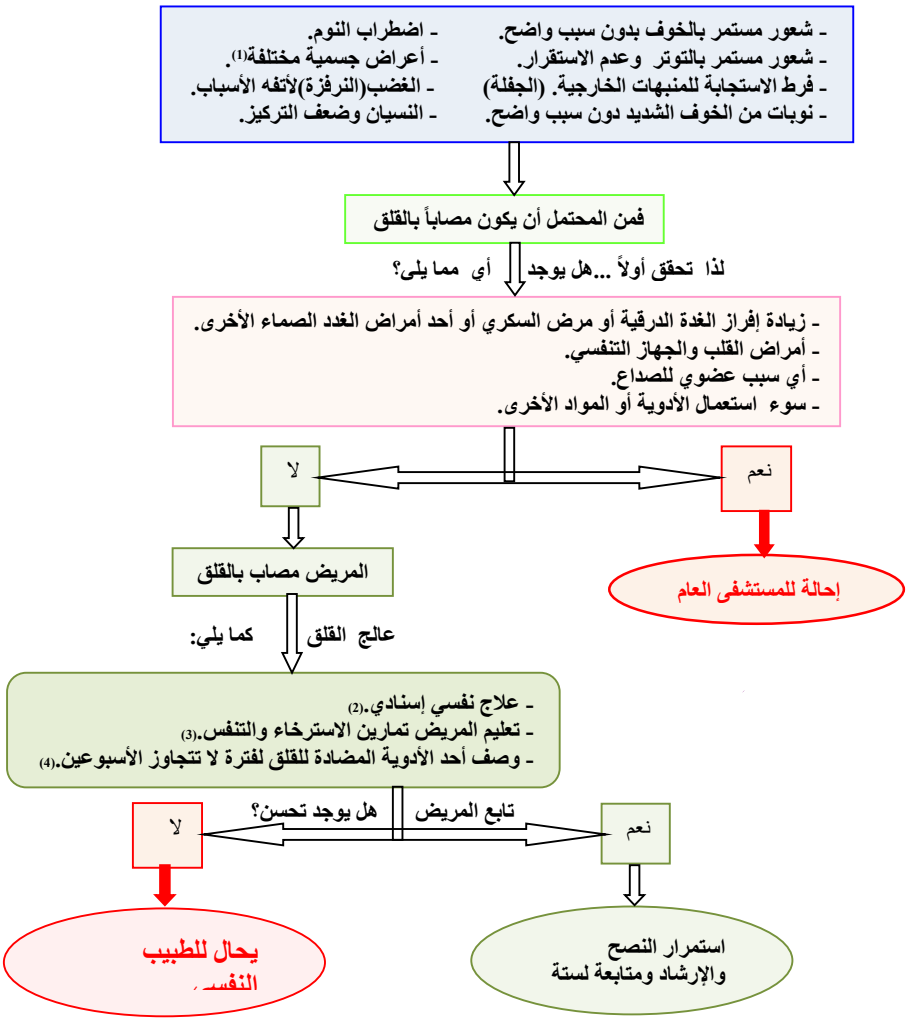
ب- المراق Hypochondriasis

في هذه الحالة يشكو المريض من إحتمال إصابته بمرض خطير ويصر على تفسير أي عارض على أنه علامة تدل على وجود المرض العضوي الخطير كالسرطان مثلاً، رغم نفي الأطباء لذلك. أعراض المراق تشابه الإضطراب السابق إلا أن المصاب يشكو من عرض واحد أو عدد محدود من الأعراض فقط .

ينبغي التأكيد على ضرورة عدم إعادة إجراء التحاليل والفحوصات بدون مبرر وعدم وصف العلاجات غير اللازمة فعلاً، ويجب الإستمرار في تطمين المريض ونفي وجود المرض. هذا ولابد أن نذكر بأن العلاج عادة لا ينجح معهم بالسرعة أو السهولة المطلوبة.

مخطط التدبير السريري للقلق

إذا شكى المريض من أحد الأعراض التالية عدة أيام في الشهر ولمعظم الأشهر:



---

(1) الأعراض البدنية: صداع، دوخة، شحوب، جفاف الفم، الشعور بصعوبة البلع، آلام البطن، إسهال، الشعور بالاختناق، خفقان، آلام عامة، آلام المفاصل، ارتجاف الأطراف، اضطراب الدورة الشهرية.....والخ0

(2) العلاج الإسنادي: الاستماع لشكوى المريض، الفحص الجيد، التطمين، المشورة0

(3) تمارين الاسترخاء: تنفس عميق، شد وإرخاء العضلات بالتناوب، والتأمل0

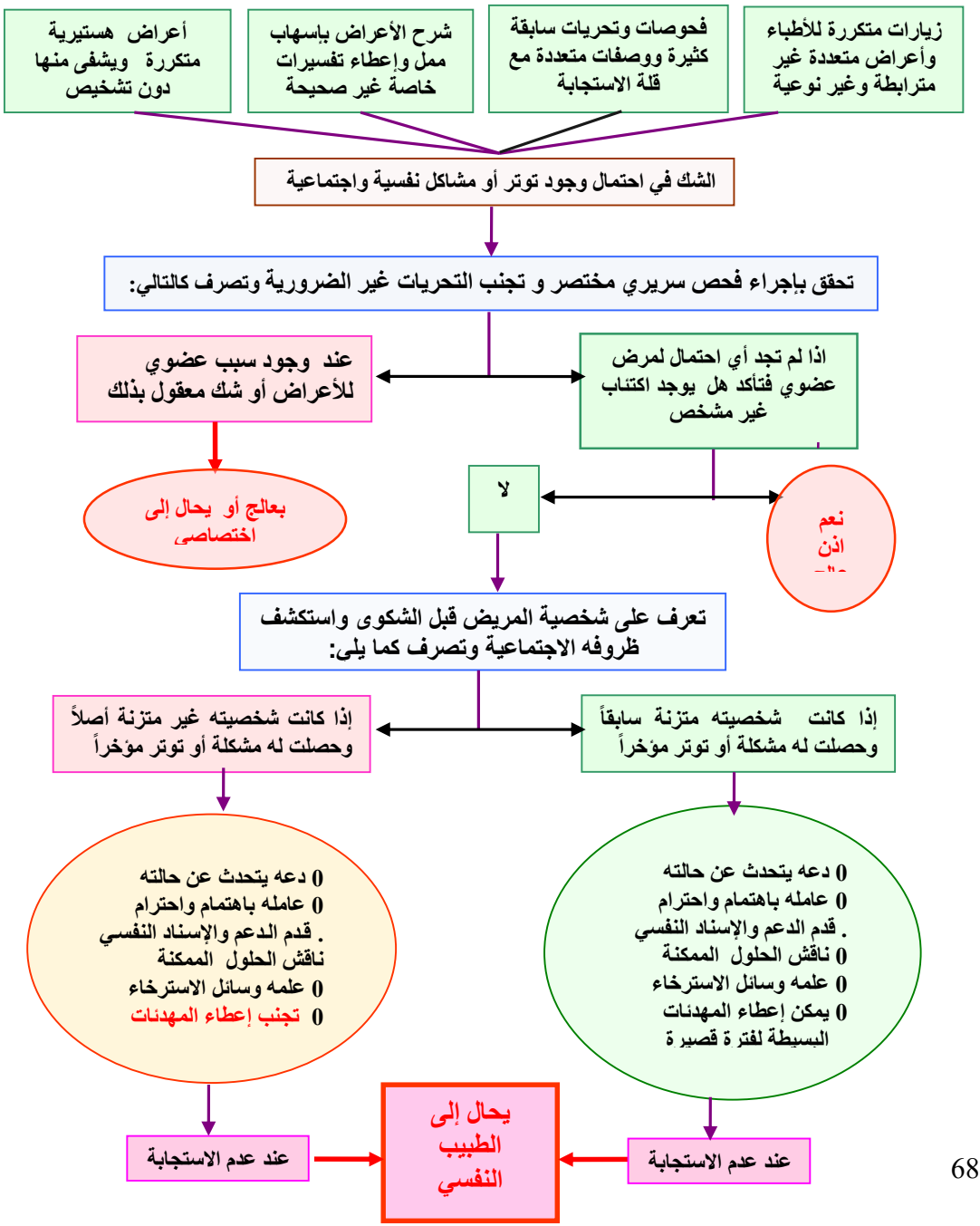
(4) الأدوية الشائعة المضادة للقلق:

أ - الدايازيبام (فاليوم) 2- 5 ملغم ثلاث مرات / يوم (الحد الأقصى 30 ملغم/ يوم).

ب- كلوردايزيبوكساييد (ليبريوم) 5- 10 ملغم ثلاث مرات / يوم (الحد الأقصى 40 ملغم/ يوم).

مخطط التدبير السريري للمراجعين المتكررين دائمي الشكوى

إذا راجعك مريض يتميز بما يلي:



الإضطرابات النفسية الخاصة بالمرأة
PSYCHIATRY OF WOMEN

تتميز المرأة بمواصفات فسلجية ونفسية خاصة تؤهلها لكي تكون زوجة وأماً تؤدي دورها في رعاية العائلة والأطفال وما تتخلل حياتها من فترات الحمل والولادة ثم حضانة الطفل ورعايته الى أن يكبر، وكل ذلك جعلها متميزة؛ فأذا حصل اضطراب نفسي أو ذهني يتعلق بوظيفتها هذه فسيؤدي الى اختلال في دورها الأنثوي وقد تصاحبه أو تعقبه سلبيات تؤثر على أفراد العائلة جميعهم. ويمكن ان نلخص أهم هذه الاضطرابات المتوقعة فيما يلي:

1- الإضطرابات النفسية الخاصة بالدورة الشهرية

أ- الحيض:

حين لاتكون الأنثى مهيأة نفسياً لبدء الدورة الشهرية فقد تصاحبها حالات من الخوف والقلق والتوتر. وقد يضطرب الحيض بالتقدم والتأخير أو التكرار أو التوقف أو الشدة أو القلة ، ويصاحبه عادة أو يسبقه بعض الأعراض المرضية في المجال النفسي والجسمي تتصف بالكآبة والتوتر والحصر وسرعة الانفعال كما تظهر بعض الأعراض الجسمية كالصداع والتشنجات العضلية والآلام العامة في المفاصل والأطراف وهذا هو ما يسمى بالتوتر السابق للحيض Premenstrual Tension . ومن الحالات كثيرة الوقوع بين النساء توقف الدورة كلياً Amenorrhea وهذه الحالة قد تحدث في مرض الكابة بشكل خاص ويكون رجوع الدورة أهم دليل على قرب زوال الكابة.

ب- **سن ما بعد الأنجاب (سن توقف الحيض والأنجاب)**:

ان توقف الحيض والانجاب Menopause قد تصاحبه أعراض اكتئابية، وان استعمال البعض لمصطلح (سن اليأس) هنا كثيراً ما يفهم خطأ فيعتبر يأساً في المجال النفسي والأجتماعي وهذا غير صحيح فهو علمياً يعني اليأس من الحيض إذ يتوقف في مرحلة من مراحل العمر تنتهي فيها القدرة على الأنجاب ولايعني توقف المزايا الأخرى للمرأة كأنثى.

2 – الاضطرابات النفسية الخاصة بالحمل والأنجاب

أ- العقم:

أن القدرة على الحمل في المرأة تعتمد في الأساس على عملية إنماء وإصدار البويضة من المبيض الى الرحم وهذه تعتمد بدورها على العمليات الهرمونية اللازمة الخاصة بذلك، وهنالك ما يثبت بأن هذه العمليات تتأثر بالعمليات العقلية في المراكز العصبية العليا في الدماغ وأن من الممكن للانفعالات العاطفية مثل القلق أو الخوف أن تؤثر في هذه المراكز العصبية وبالتالي في الأفرازات الهرمونية التي تؤثر في النهاية على عمل المبيض.

ب. منع الحمل:

ان أحتمال حصول حمل من عملية جنسية واحدة في أفضل فترات الأخصاب لاتتعدى 25% ولكن دلت الإحصائيات في دول الغرب بأن حوالي ثلث الولادات المسجلة ناتجة عن حمل غير مرغوب فيه؛ بسبب فشل طرق منع الحمل المتبعة. وهذا يكون له تأثير سلبي على الحالة النفسية للأم ثم على نفسية الطفل. ومن ناحية أخرى فان عدم أعتماد طريقة ناجحة لمنع الحمل وتخطيط الإنجاب قد يشير الى وجود أضطراب عام في نظام العائلة وعلاقاتها.

ج. الإجهاض:

يزداد أحتمال حصول الإضطرابات النفسية بعد الإجهاض في حالات:

أولاً: وجود تاريخ مرضي نفسي قبل الإجهاض.

ثانياً: إذا كان قرار الإجهاض غير مخطط له من قبل الزوجين ومصحوباً بتردد وحيرة.

ثالثاً: إذا كان أكتشاف الحمل مصحوباً بقلق شديد مع عدم تدخل الأب في الأمر وكأنه لا يعنيه.

رابعاً: في حالات الإجهاض المتكرر.

ان غالبية الإضطرابات التي تحصل بعد الأجهاض هي من الأضطرابات الانفعالية (كالأكتئاب، القلق والرهاب) أما الإضطرابات الذهانية post- abortion psychosis فنادرة الحصول.

3. اضطرابات ما بعد الولادة

ان ولادة طفل جديد تعتبر مناسبة مهمة تسر العائلة وتسعدها عادة وذلك بعد أن تكون الأم قد مرت بشهور الحمل الطويلة ثم بالولادة وما يصاحبها من معاناة وتوقعات. ولكن فترة ما بعد الولادة (النفاس) هي من الفترات التي تجعل الأم في وضع خاص قد يعرضها لإضطرابات نفسية وذهنية متعددة. وقد لوحظت زيادة في الإضطرابات النفسية في الأشهر الثلاثة الأولى التي تعقب الولادة أكثر من أية فترة أخرى خلال سنتين ما قبل الولادة وسنتين ما بعدها. وفيما يلي أهم هذه الأضطرابات:

أ. غم الولادة (غم الأمومة) Maternal Blues

نسبة حصول هذه الحالة هو حوالي 50% (أي نصف حالات الولادة) وتزداد في الولادات الأولى وخاصة أذا كانت الأم تشكو اصلاً من التوتر السابق للحيض.
وهو اضطراب مؤقت في مزاج الأم ويتميز بالشعور بالاكتئاب وعدم الإستقرار وشعور الأم بأنها بعيدة عن الطفل ويرافق ذلك أرق وصداع وضعف التركيز.
تبدأ الحالة في الأسبوع الأول من الولادة عادة وتستغرق يومين أو ثلاثة، وأسبابها مزيج من أسباب نفسية وأسباب كيميائية-حياتية . أما علاجها فهو تطمين الأم وإسنادها نفسياً ومراقبتها وإخبار العائلة بأنها حالة مؤقتة.

ب. اكتئاب مابعد الولادة Postnatal Depression

نسبة حصوله هي 10% (حالة واحدة لكل 10 ولادات). وهو أشبه بالكآبة الانفعالية التي تحدث في الظروف والأوقات الأخرى غير المرتبطة بالولادة.
تبدأ الحالة في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الولادة عادة وتستغرق 4-6 أسابيع، أسباب الحالة هي تفاعل الأسباب الحياتية مع الأسباب النفس/ اجتماعية psychosocial (كما في حالات حدوث الولادة مع عدم توفر السند الاجتماعي الكافي) ويزداد حصول الحالة لدى الأمهات ذوات الشخصية العصابية Neurotic personality، وقد لوحظت أيضاً زيادة حصول الحالة لدى الأمهات اللواتي كن يعانين من العلاقة الصعبة مع الوالدين أثناء مرحلة الطفولة.
تتميز أعراض الحالة بشعور بالأكتئاب مع فترات من الميل للبكاء وعدم الاستقرار إضافة إلى شعور بالتعب والإنهاك والإحساس بعدم الكفاءة لتلبية حاجات الطفل ويصاحبها ضعف في الشهية والتركيز والرغبة الجنسية.
وتعالج الحالة كما يلي:

أولاً: الطرق الإسنادية العامة كالتشجيع والشرح والتطمين.
ثانياً: العلاج بالأدوية المضادة للقلق والكآبة0

ثالثاً: العلاج النفسي الزواجي Marital therapy

المآل: Prognosis:
حوالي 90% منها تنتهي في أقل من شهروحوالي 4% تتحسن خلال سنة.

ج. ذهان النفاس Puerperal Psychosis:
ويحصل بنسبة حالة واحدة من كل 500 حالة ولادة (أي بنسبة 2 لكل ألف ولادة). وتظهر أعراضها عادة في الأسبوع الثاني أو الثالث بعد الولادة، وقد تحتاج الى 6-12 أسبوعاً لكي تختفي أعراضها.
يعزى المرض لعوامل وراثية وعوامل حياتية إضافة إلى العامل النفسي المصاحب للولادة، أما إحتمال حصول الحالة في الولادات اللاحقة فيرتفع ليصل الى 20% من الولادات اللاحقة (خمس الولادات).
أعراض المرض
تبدأ بالأرق وعدم الأستقرار وتتطور الى تشوش الوعي مع حيرة وقد يصاحبها أوهام Delusions وهلاوس Hallucination (يتعلقان بالطفل) مع غياب البصيرة Loss of insight إضافة الى ميول إنتحارية أو ميول لقتل الطفل.

العلاج:
تحتاج معظم الحالات الى إدخال الأم إلى الردهات أو المستشفيات النفسية، وتفضل ردهة خاصة بالأم والطفل Mother and child unit للإبقاء على تماس الأم بالطفل وتشجيع التماسك Bonding بينهما. وينصح بالرضاعة الطبيعية وتشجيع الأب ليكون حلقة الوصل بين الأم وبقية أفراد العائلة0 كما ان استعمال الأدوية المضادة للذهان له دوره المهم في المعالجة. وقد تحتاج بعض الحالات الشديدة إلى أستعمال الصدمة الكهربائية ECT والتي تعطي عادة أستجابة جيدة.

مآل المرض: يحصل تحسن كامل في حوالي 70% من الحالات مع احتمال معاودة الحالة في الولادات اللاحقة بنسبة 14-20%.

اضطرابات الأطفال النفسية

1- الاضطرابات السلوكية والعاطفية والعصابية التي تبدأ عادة في الطفولة أو المراهقة:

أ-اضطراب نقص التركيز وفرط الحركة

ب-اضطرابات السلوك (ا.س)

اولا- ا.س المحصورة في محيط العائلة

ثانيا- ا.س المنفردة

ثالثا- ا.س الجماعية

رابعا- ا.س العاطفية المشتركة

ج-الاضطرابات العاطفية والعصابية:

اولاً - الاضطرابات العاطفية المشابهة للكبار

ثانياً- الاضطرابات الخاصة بالطفولة

2- اضطرابات النمو النفسي .

أ- الاضطرابات النوعية

ب- الاضطرابات الشاملة:

اولا- داء التوحد

ثانيا- فصام الطفولة

ثالثا- اضطراب الشخصية الفصامي

- ✓ تشير الدراسات المختلفة إلى ان ما يقارب 7% من الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية وهذه النسبة مرشحة للزيادة إلى الضعف في المجتمعات الكبيرة والمزدحمة.

- ✓ الأطفال الذكور أكثر تعرضاً للاضطراب النفسي من الإناث لأسباب غير مفهومة وتتقارب النسبة بين الجنسين أثناء المراهقة ثم تميل الكفة بجهة الإناث عند البالغين.

وسنقدم فيما يلي شرحا موجزا للاضطرابات المذكورة اعلاه:

1- الاضطرابات السلوكية والعاطفية التي تبدأ عادة في الطفولة أوالمراهقة

أ- اضـطراب نقـص التركيـز وفـرط الحركـة

Attention Deficit & Hyperactivety Disorder ADHD

نسبة انتشار هذا الاضطراب قد تصل الى 9%، وتشير الدراسات الحديثة أنه يصيب الأطفال بمعدل 65 حالة لكل الف طفل، والمراهقين يمعدل 2% . والمرض يصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة 1/4، أسباب المرض غير معروفة وتشير الدراسات الى وجود اسباب وراثية وبيئية مختلفة وراءه.

يبدأ في الطفولة المبكرة وصفاته الرئيسة:

- بدء ظهور الأعراض قبل سن السبع سنوات.
- الحركة الزائدة وتكون حركة غير موجهة وليست لهدف معين.
- انعدام التركيز وتشتت الأنتباه.
- الاندفاع واللاأبالية.
- ان الأعراض ملحوظة في مكانين على الأقل (مثلاً في البيت والمدرسة او أي مكان آخر).
- تسبب الأعراض ارباكاً في أداء الوظائف الحياتية اليومية المناسبة المتوقعة لعمر الطفل.

العـلاج:

- **الأدويـة:** مهمة جداً للسيطرة على فرط الحركة ومن ثم زيادة الأنتباه والتركيز وتستعمل مشتقات الأمفيتامين (وهي من المنبهات) وتعتبرفعالة لهذا المرض. كذلك يمكن استخدام المهدئات الكبرى للعلاج مثل اللارجكتيل، كما يستعمل حالياً الستراتيرا . ولا يستعمل الفينوباريتون كونه يزيد من تهيج الطفل (وهذا عكس ما يحصل في الكبار).
- **التعليم:** يتم في صفوف خاصة، فيها أقل ما يمكن من المؤثرات لضمان زيادة أنتباه الطفل وتجنب تشتته.

مآل المرض: قد يقل فرط الحركة مع تقدم العمر وربما يختفي في المراهقة إلا أن الاندفاع واللاأبالية قد تستمر وربما تتطور إلى أحد الاضطرابات السلوكية أو الجنوح.

ب- اضطراب السلوك Conduct disorder

العدوانية والجنوح هي من الأعراض الشائعة في أواسط الطفولة وقد تصل نسبتها بين الاطفال إلى 4% وهي من العوامل التي تثير الآباء والمعلمين لاستعمال القسوة تجاه الطفل، وقد نجد أن الجنوح في المراهقة يكون مسبوقاً باضطراب السلوك في الطفولة وبعلاقات عائلية تتميز بالعدوانية والاضطراب وبفقدان أحد أو كلا الأبوين، وقد يكون أحد الأبوين ذا ميول لا إجتماعية أو مضطرباً نفسياً.

كما أن هذه الاضطرابات قد تنتج عن معاناة الطفل من الكآبة أو من أحد الأمراض العصابية الأخرى خصوصاً إذا ما حصلت في طفل لايتميز بالعدوانية والاضطراب سابقاً.

ويمكن تقسيم هذه الاضطرابات السلوكية إلى عدة فئات وكما يلي:

أولاً: الاضطرابات السلوكية المحصورة في محيط العائلة: هي عبارة عن أحتجاج الطفل تجاه شيء ما (مثلاً: تجاه زوجة الأب أو تجاه علاقة مختلة مع أحد الابوين). وهذه الاضطرابات لا تؤدي بالضرورة إلى الجنوح.

ثانياً: اضطرابات السلوك المنفردة: يمارسها الطفل لوحده وتنتج عادة عن الحرمان العاطفي للطفل في سنوات عمره المبكرة أو عن وجود صفات شخصية تمنع الطفل من إنشاء علاقات حميمة مع الآخرين.

ثالثاً: اضطرابات السلوك الجماعية: يمارسها عادة مجموعة من الأطفال خارج محيط الأسرة، مثل السرقة، الهروب من المدرسة، العبث ... الخ.

رابعاً: اضطرابات السلوك العاطفيةالمشتركة: وتصاحب عادة الكآبة أو القلق أو أحد الأضطرابات العاطفية الأخرى.

أعراض الاضطراب السلوكي:

- العدوانية: وتشمل إيقاع الأذى بالآخرين والممتلكات والحيوانات، العصيان، نوبات الغضب الشديد، النزوع إلى التدمير والعراك المستمر والزائد عن الحد.
- الهروب من المدرسة والتجوال خارج البيت (Truancy).
- السـرقة، الغش والكذب.
- تناول الكحول او المخدرات.

العــلاج:

علاج الاضطرابات السلوكية لا تحدده نوعية الأعراض المرضية فقط وإنما عوامل أخرى أهمها:

- شخصية الطفل،
- تجاربه وظروفه الحياتية،
- وبيئته العائلية والمدرسية.

فعندما تكون الأضطرابات ناتجة عن أزمة عائلية تهدد استقرار العائلة كالخلافات الزوجية، الطلاق، وفاة أحد الوالدين، الديون، البطالة، .... الخ، فإن العلاج يتوجه أساساً لمساعدة العائلة لتجاوز محنتها ثم مساعدة الطفل عن طريق العلاج السلوكي والعلاج العائلي.

أما في حالة مرض أحد الأبوين نفسياً فتجب معالجته وبالنسبة للطفل فنستمر بمساندته عن طريق العلاج النفسي، وفي حالة كون المرض شديداً يؤثر على قدرة العائلة في تربية الطفل فيفضل توفير عائلة بديلة للطفل مع ملاحظة أن الأطفال الصغار يجب أن لا يفصلوا عن عوائلهم إلآ في الحالات الشديدة والمستعصية، بينما يستفيد الأطفال الأكبر عمراً (اليافعون) من إبعادهم عن عوائلهم جزئياً كوضعهم في مدارس داخلية.

أما اضطراب السلوك الناتج عن أمراض عاطفية أو وجدانية فأنه يستجيب لعلاج الحالة المسببة.

ج- الأضطرابات العاطفـية والعصابية:

يمكن تقسيمها إلى نوعين:

اولاً- الإضطرابات العاطفية (العصابية) المشابهة للكبار:

لن نتحدث عنها لأنها شبيهة الى حد ما بأمراض الكبار ماعدا نوع واحد من المخاوف Phobias وهو الخوف من المدرسة (رهاب المدرسة School Refusal) الذي قد

يكون نوعاً من أنواع قلق الإنفصال حيث يرفض الطفل الذهاب للمدرسة بشدة في الصباح مع أنه ذو مستوى دراسي جيد وينصح بالعلاج السلوكي له بإعادة الطفل تدريجياً للمدرسة وقد يكون رفض الذهاب للمدرسة بسبب إضطراب نفسي شديد أو بسبب ظروف المدرسة أو لأن لديه إهتمامات أخرى في البيت.

والخوف من المدرسة **يختلف** عن الهروب من المدرسة Truancy الذي هو اضطراب سلوكي، وفيه يهرب الطفل من المدرسة أو لايذهب لها أساساً ولكنه لايعود الى البيت بل يبقى في الخارج و يكون مستوى الطالب الدراسي متدنياً عادةً وقد يؤدي مستقبلاً إلى الجنوح.

ثانياً- الاضطرابات الخاصة بالطفولة: وهي كثيرة وأهمها:

(1) - الحساسية الاجتماعية: (ويسمى ايضاً الخجل الاجتماعي) رغم أن الطفل يتجاوب ويتفاعل مع الآخرين ألا أنه لا يرتاح لوجود الغرباء.

(2) **أمراض عصابية خاصة بالأطفال:** قد يؤدي القلق الذي يعاني منه الطفل إلى أعاقة قيام علاقات وتفاعل عاطفي بينه وبين الآخرين حتى الأشخاص المألوفين له. وقد يبين تاريخ المرض وجود صعوبات حياتية أو ضغوط نفسية تفاعل الطفل معها بالكبت للنزعات العدوانية داخله فأصبح يعاني بدلاً عنها من الانطواء، البكاء وأحياناً الكآبة. وهذه الاضطرابات تصيب الذكور والإناث بالتساوي ولا علاقة لها بالانحدار الاجتماعي للطفل وقد ينتج عن صعوبات معينة في المدرسة أو تفكك العائلة. علماً أن معظم المصابين ذوو مستوى دراسي جيد.

(3) اضطرابات التكيف الاجتماعي: أهمها البكم الوقائي (الإنتقائي) حيث يرفض الحديث مع شخص معين في مكان معين بينما يتكلم بشكل طبيعي في مواقف أخرى. كذلك هناك اضطرابات ناتجة عن اضطراب العلاقة بين الطفل وبين المحيطين به خصوصاً عندما يتعرض الطفل إلى الإهمال الشديد من قبل الأبوين أو إلى سوء المعاملة حيث يعاني الطفل من مشاعر متباينة تجاه الناس ويعاني من الانزواء العاطفي وعدم التفاعل مع الآخرين وكذلك يعاني من خوف شديد يعبر عنه باليقظة المستمرة ومراقبة الآخرين وكأنه يتوقع حدوث شيء مؤذ له بشكل دائم. أو قد يتفاعل الطفل بشكل أكبر مما هو طبيعي بحيث لا يخشى ولايراعي القيود الاجتماعية بينه وبين الآخرين.

(4) **سلس البول الليلي:** من الأمراض الشائعة يتم تشخيصه بعد السنة الرابعة أو الخامسة من العمر. يصيب 10% من الأطفال، الذكور اكثر من الإناث، وقد تلعب الوراثة دوراً في حصول المرض. وهو أكثر انتشاراً في الطبقات الاجتماعية الدنيا، كما أنه قد يرافق بعض الاضطرابات العاطفية والسلوكية أو اضطرابات النمو النفسي مثل تأخر النطق، المشي والفشل المدرسي .. الخ . كما أن التهاب المسالك البولية قد تلعب دوراً ما خصوصاً في الإناث وهنا يلاحظ وجود ألم في أسفل البطن ويؤدي علاج الالتهاب إلى شفاء الطفل.
ويعالج سلس البول كما يلي:
- ينصح بعدم تناول السوائل في الليل قدر المستطاع وبإفراغ المثانة جيداً قبل النوم وإيقاظ الطفل للتبول مرة أو مرتين اثناء فترة النوم.
- العلاج الدوائي: تستعمل الأدوية الثلاثية الحلقات المضادة للكآبة وخصوصاً التوفرانيل.
- العلاج السلوكي:يستعمل جهاز خاص يسمى الجرس والبطانية لهذا الغرض.

(5) **التغوط في الملابس أو الأماكن غير المخصصة لذلك**: وهذا يشبه التبول الليلي في بعض الوجوه وقد يكون مصاحباً له، علما ان بعض الأطفال يعانون من فطر الشرج أوالإمساك وعلاجهما قد يعطي الشفاء.

(6) **التأتأة الكلامية:** حالة شائعة خصوصاً في العوائل الفقيرة ولاتعتبر مرضاً نفسياً، وتختفي عادة في المراهقة إلا أن إصرار الأهل وإلحاحهم على الطفل لتجاوزها يؤدي الى نتائج سلبية.

(7) **اضطرابات أخرى خاصة بالطفولة**: مخاوف خاصة بالأطفال، الغيرة من الأخ أو الأخت، قلق الانفصال عن الوالدين.

2- اضطرابات النمو النفسي

أ- **الاضطرابات النوعية:** وتشمل أحد أوجه النمو النفسي بينما تكون الأوجه الأخرى طبيعية مثل:

- اضطراب اللغة والكلام.
- اضطراب المهارات الحركية.
- اضطراب المهارات المدرسية.

ب- الاضطرابات الشاملة (وهي ما يمكن أن نسميه ذهان الطفولة) وتشمل:

أولاً- داء التوحد Autism:

تبلغ نسبة الإصابة به 2- 4 في كل عشرة آلاف طفل وهو اكثر بين الذكور. و يبدأ المرض عادة قبل الشهر الثلاثين من العمر. ويتميز بثلاث صفات:

(1) اضطراب التفاعل العاطفي مع الآخرين ومن علاماته تجنب النظر في عيون الآخرين، وعدم إظهار الفرح أو السعادة عند ملاطفته أو حمله ومداعبته.

(2) اضطراب اللغة والكلام: حيث أن الطفل قد لا يمتلك أية قدرة على الكلام أو أنه يتكلم بشكل غير طبيعي مثل تكرار ما يقال أمامه بشكل ببغائي أو استعمال الضمائر بشكل معكوس.

(3) الإصرار على طقوس معينة مثل الكيفية التي يقدم بها طعامه أو الإصرار على وجود أشياء معينة وعند تغيير أي من هذه الطقوس يغضب ويحتج بعنف.

(4) عدم إظهار التفاعل من خلال إشارة أو تقليد أو المشاركة باللعب والمرح مع الآخرين.

الأطفال المصابون يعانون *عادة* من صعوبة التعلم والخمول، وتكون حركاتهم خرقاء وغير هادفة ومكررة.

بعد ادخال مصطلح (طيف التوحد) الذي يتصف فيه المصابون بنفس الخصائص النوعيةلمرض التوحد النموذجي، فقد زادت نسبة انتشار الاضطراب الى حوالي طفل واحد لكل 26 طفل. ونسبة اصابة الذكور به الى الإناث هي 4/ 1
الدراسات الحديثة تذكر أن اسباب الأضطراب متعددة وهي وراثية جينية محيطية.

العلاج:
ويشمل استعمال الأدوية في حالات الاضطراب السلوكي الشديد كما تستعمل أدوية الصرع عند حدوثه خصوصاً أثناء المراهقة. ويجب الاهتمام بتعليم الطفل حيث يستفيد بشكل مهم ومؤثر في حياته من التعليم المتخصص الثنائي (معلم و طالب او عدد صغير محدود من الأطفال) وقد يحتاج ذلك إلى مدرسة داخلية (تعليم خاص وسيطرة على السلوك وتأهيل) . كذلك لابد من تقديم الدعم والمساندة للعائلة.

مآل المرض:
يعتمد على صحة التشخيص، الأسباب والمداخلات وعلى ندبير الحالة. وبصورة عامة فإن المآل سيئ حيث يحتاج نصف المصابين بطيف التوحد إلى عناية طبية خاصة وطويلة أو دائمية. ويعتبر امتلاك الطفل لغة مفيدة جيدة قبل سن الخامسة علامة جيدة على مآل المرض. وعموماً فأن الدراسات تشير إلى ان حوالي:

- 12% مآل جيد جداً
- 10% مآل جيد
- 20% مآل مقبول
- 46% مآل سيئ
- 12% مآل سيئ جداً

ثانياً- فصام الطفولة:
مشابه لفصام العقل عند الكبار حيث توجد الأوهام والهلاوس والتصرفات غير الطبيعية وعلاجه مشابه لعلاج المرض عند الكبار ولا يحدث قبل سن 8 سنوات ونادرً الحدوث قبل سن المراهقة .

ثالثاً- اضطراب الشخصية الفصامي:
يكون الطفل خجولاً، حساساً وميالاً إلى العزلة وعدم المشاركة مع الآخرين وتكون علاقاته الاجتماعية بزملائه محدودة أو معدومة. وعادة ما يلفت الانتباه خلال الدراسة حيث يلاحظ هبوط مستواه الذي لا يعود إلى انخفاض في ذكائه وإنما إلى عدم الرغبة في الدراسة والمشاركة. ان كل ما يحتاجه الطفل هنا هو تفهم حالته وقابليته من جانب الأهل ومن جانب المدرسة وعدم الإلحاح عليه للمشاركة الاجتماعية.

عسر (صعوبات) التعلم
LEARNING DISABILITIES
(كان يسمى سابقاً، التخـلف العقلـي)

هو حالة توقف أو عدم اكتمال النمو العقلي وتتواجد قبل سن البلوغ لأسباب ولادية أو مكتسبة.
وللتعبير عن مستوى النمو العقلي تستخدم عدة مقاييس لمعرفة القدرة على التعلم والكفاءة الاجتماعية. ومنها معامل الذكاء الذي يقاس باستعمال طرق معينة وحسب العمر. يعتبر الذكاء طبيعياً إذا كان 90 - 120 درجة اما معامل الذكاء للمصابين بالصعوبات فيكون ما دون 70 درجة. أما الفئة الواقعة بين 70 إلى 90 فهي فئة بطيئي التعلم.

الأسباب كثيرة وأهمها ما يلي:

1- **العيوب الكروموسومية والجينية.**

2- **الالتهابات المختلفة:** كالألتهابات التي تنتقل من الأم إلى الجنين أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية والزهري و التوكسوبلازموسز، الأنفلونزا وكذلك الألتهابات الشديدة التي تصيب الطفل في السنوات الأولى من العمر، خصوصاً التهابات السحايا والدماغ.

3- **التسمم بالمواد المختلفة**: ومنها التسمم بالرصاص. وكذلك الكحول، حيث يعاني أطفال النساء المدمنات على الكحول من عسر التعلم أكثر من أطفال النساء الأخريات.

4- **استسقاء الدماغ.**

5- **اليرقان الولادي.**

6- **تعسر الولادة.**

7- **سوء التغذية للأم والطفل ونقص اليود** خصوصاً في السنتين الأوليتين من عمر الطفل.

الأعراض:
قد تكون الأعراض واضحة على الطفل منذ البداية كما في متلازمة الطفل المنغولي، استسقاء الدماغ، صغر حجم الدماغ. واحياناً قد نتوقع حصول التخلف بسبب حصول أمراض شديدة في الطفولة المبكرة.
وفي أحيان أخرى يتم تشخيص الحالة لاحقاً حين يتأخر معدل النمو عند الطفل عن الحد الطبيعي المتوقع لعمره. وقد يتأخر تشخيص بعض الحالات لحين دخول الطفل إلى المدرسة.

العلاج:
كما هو معروف لم يتوصل الطب إلى علاج يساعد على تطور ذكاء الأنسان. ورغم ما يقال عن بعض الأدوية في هذا الخصوص فأن الدراسات الرصينة لم تثبت صحة ذلك؛ ولهذا يجب التركيز على محورين، محور الوقاية ومحور تأهيل المصابين.

1- **الوقاية من عسرالتعلم:** وهو من المواضيع المهمة خصوصاً على مستوى الرعاية الصحية الأولية وتتم على أربع مراحل:
أ- **مرحلة ما قبل الحمل:** من خلال التلقيح ضد الحصبة الألمانية، الاستشارة الوراثية، وتنظيم الأسرة.
ب- **أثناء الحمل:** من خلال العناية بالحامل ورعايتها وتغذيتها (وخاصة اليود والفولك أسيد)، تجنب االأدوية الضارة والكحول والنيكوتين، تجنب التلوث وخاصة الرصاص، التحري عن الأمراض المختلفة التي تصيب الحامل ومعالجتها، و التشخيص المبكر لحالات الأجنة المعرضة ودراسة امكانية إجهاضها.
ج- **أثناء الولادة:** العناية بالحامل أثناء الولادة وتجنب عسر الولادة واختناق الوليد أو تأخره في التنفس وسرعة إنعاشه. فحص الوليد وتشخيص الحالات مبكراً وتدبيرها مبكراً مثل هبوط الغدة الدرقية والفنيلكيتون يوريا، استسقاء الدماغ. واستعمال الـ Anti-D عند الحاجة.
د- **بعد الولادة:** تطبيق برامج الغربلة وتلقيحات الأطفال، الوقاية من أمراض الطفولة المختلفة خصوصاً الالتهابات ومعالجتها بشكل صحيح ومبكر عند حدوثها. السيطرة على الصرع، حماية الطفل من الحوادث وسوء المعاملة أو الإهمال والتلوث.

2- **تأهيل الأطفال المصابين:** بتدريبهم وبرعايتهم صحياً واجتماعياً، وحمايتهم من الحوادث وسوء المعاملة والاستغلال وتدريبهم للوصول إلى أحسن مستوى ممكن لقدراتهم العقلية.

إن التأهيل جانب مهم وفعال في تحديد المسار الحياتي والاجتماعي للمصاب وهو مهمة لابد أن تضطلع بها الجهات التربوية والاجتماعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الصحية.

بطء التعلم

SLOW LEARNENG

الاطفال بطيئوا التعلم هم الذين يظهرون بطءاً في تعلم المهارات الأكاديمية كالقراءة والحساب والكتابة والتهجئة، وضعفاً في العمليات العقلية العليا كالفهم والتمييز والتحليل والاستنتاج والتذكر وحل المشكلات، و الانتقال المنظم من فكرة الى أخرى. وتتراوح درجة ذكائهم بين 70-90 درجة في اختبارات معامل الذكاء. وهم لايصنفون عادة ضمن فئة المصابين بعسر التعلم الذين تكون درجتهم أقل من 70 درجة.

قد تكون الحالة ناتجة عن قصور وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، ولايمكن أن تعزى لسبب واحد بل لأسباب متعددة ومعقدة؛ لذا لابد من وجود برامج تربوية متخصصة فعالة للتعامل مع المصابين ورعايتهم.

وعموماً فأن أهم خصائص وسمات هؤلاء الاطفال اذا ماقورنوا مع الاطفال العاديين هو أنهم يعانون من صعوبات تعلمية قد تظهر في واحدة أو أكثر من الخصائص السلوكية التي تعيق القدرة على التعلم، وتشمل هذه الخصائص مايلي:

- **السلوك الصفي والمدرسي**:
التململ وكثرة الحركة، صعوبة في بدء او إنهاء المهمة، الانتباه مشتت وعدم التقيد بالتعليمات اللفظية، التعب، التغيب عن المدرسة، الهدوء والانسحاب، الاعتماد الزائد على الغير وصعوبات في التكيف الاجتماعي، اضافة الى مؤشرات دراسية غير مطمئنة.

- **في مجال القراءة**:
خلط بين الكلمات والأحرف المتشابهة (مثلاً ج ح خ)، استخدام الأصبع في تتبع سطور القراءة وعدم الرغبة في القراءة.

- **في مجال الحساب**:
صعوبة فهم العمليات الحسابية المجردة وادراك المفاهيم الأساسية، خلط بين الأعمدة والفراغات، و صعوبة في المطابقة بين الارقام والرموز.

- **في مجال التهجئة**:
استخدام الحروف في الكلمة بطريقة غير صحيحة، صعوبة في ربط الاصوات بالحروف المناسبة لها، عكس الحروف والكلمات أوقد يزيد او يحذف او يقلب الحروف في الكلمة.

- **<u>في مجال الكتابة والاملاء</u>**:
عدم القدرة على تتبع الكلمات في السطر الواحد, صعوبة في نسخ مامكتوب على السبورة.

- **<u>في مجال السلوك اللفظي:</u>**
التردد عند بدء الكلام, عدم الانسجام بين الفاظه وعمره.

الخصائص الجسمية:

قد يختلف معدل النمو الجسمي لهؤلاء الاطفال عن اقرانهم، وقد يعاني الطفل من متاعب وأمراض بسيطة اضافة الى الضعف العام ونقص حيوية الجسم وبعض العيوب الجسمية مثل (عيوب النطق والكلام، السمع، البصر، الاسنان ... والى غير ذلك).

التشخيص:

للتشخيص الصحيح والمبكر أهمية كبيرة في حياة الطفل ومستقبله، ولكن التشخيص يتأخر في كثير من الحالات بسبب عدم ملاحظة الأهل لعلاماته (لعدم معرفتهم بها). وعادة يكون التشخيص بعد دخول المدرسة حيث يلاحظ المعلم تأخر الطفل في التعلم نسبة لاقرانه. (*وهذا يبين أهمية معرفة المعلمين بهذا الأمر لغرض ملاحظته واكتشافه مبكراً*).

هذا ويعتمد التشخيص الصحيح على نتائج الاجراءات التالية:

1. **التقييم التربوي:** ويقوم به المعلم في المدرسة بملاحظة ووصف قدرة الطفل على التعلم، السلوك الاجتماعي والانفعالي له داخل الصف وخارجه ونسبة غيابه عن المدرسة.
2. **التقييم الاجتماعي:** ويقوم به الباحث الاجتماعي وذلك بدراسة نشأة الطفل ووضعه الاجتماعي والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها أسرته.
3. **الفحص الطبي:** ويقوم به اختصاصي الطب النفسي، لبيان سلامة الطفل من الاضطرابات النفسية والعصبية.
4. **الاختبارات النفسية:** ويقوم بها عادة الباحث النفسي المختص بالقياس النفسي؛ لتحديد درجة الذكاء ودراسة الشخصية والنضج والتكيف الاجتماعي.

في العادة تبدأ هذه السلسلة من المدرسة أولاً، وذلك بملاحظة المعلم لوجود علامات بطء التعلم على الطفل، ثم احالة الطفل الى المركز الصحي لفحصه طبياً ثم احالته الى اللجنة المختصة لاتخاذ اللازم واعطاء الرأي النهائي بحقه. فأذا ثبت بطء التعلم لدى الطفل فينقل الى صفوف التربية الخاصة في المدرسة او الى احدى المعاهد المناسبة المختصة بتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وحسب ماتقتضيه حالته.
هذا وتجب توعية العائلة بحالة الطفل وما تتطلبه منهم من الجهود المضاعفة لرعايته ومساعدته على التعلم.

اضطرابات الشخصية

PERSONALITY DISORDERS

لابد لنا بدءاً أن نؤكد أمرين مهمين، الأول هو ان استعراض هذه الاضطرابات ودراستها يجب أن لايكون للحكم على المصابين أو ادانتهم أو الانتقاص منهم، فهم مرضى مبتلون ويستحقون الرعاية الطبية.

والأمر الثاني هو اننا لا نطلب من طبيب الرعاية الصحية الأولية تشخيص اضطرابات الشخصية أو تدبيرها ولكن معرفة الطبيب بهذه الاضطرابات تساعده في اختيار السبيل الأمثل للتصرف مع كل مراجع بما يناسبه.

الشخصية:

هي الانماط الثابتة لتفكير الفرد ومشاعره وسلوكه والتي تجعله متوافقاً مع الآخرين ومتميزاً عنهم. ان شخصية الفرد هي الهوية التعريفية له (من الناحية النفسية) وعلى اساسها نتنبأ بانفعالاته وردود أفعاله وتصرفاته في المواقف المختلفة.

اضطراب الشخصية (P.D):

هو الاضطراب (في شخصية الفرد) الذي يؤثر على توافقه مع بيئته، على ان لا يكون الاضطراب بسبب مرض نفسي آخر. وغالباً ما يسبب اضطراب الشخصية معاناة كبيرة للمصاب نفسه ولعائلته التي قد تعاني من مشاكل ومتاعب اجتماعية كبيرة نتيجة لسلوكه وتصرفاته.

تظهر اعراض اضطراب الشخصية مبكراً عادة وتستمر بعد البلوغ ولكنها قد تصبح أقل شدة عند تقدم المريض بالسن. ولتشخيص حالة اضطراب الشخصية لابد من جمع المعلومات الموضوعية الكافية عن حالة المريض. ويستفاد كثيراً في ذلك من البحث الاجتماعي؛ لأن المصاب لايدرك غالباً حاجته للعلاج ولايشكو من الصعوبات والمشاكل الكثيرة التي يسببها لعائلته وللآخرين؛ لذا لابد من سماع رأي العائلة والمدرسة وغيرهم. وقد تستعمل أحياناً الفحوص النفسية للكشف عن الشخصية (Psychological tests) للمساعدة في الوصول للتشخيص.

قد تكون لدى المصاب سمات سلبية وأخرى ايجابية وواجبنا هو اكتشاف الاثنتين لديه ومساعدته على معرفتها، لتطوير الايجابية منها وتجاوز السلبية. علماً بأن سمات الشخصية المضطربة تظهر بدرجات متفاوته من واحد لآخر وقد يعاني الفرد من أكثر من نوع اضطرابات الشخصية في الوقت نفسه.

وفيما يلي استعراض لبعض الاضطرابات الشائعة للشخصية:

الشخصية الاضطهادية
PARANOID PERSONALITY DISORDER

ويظهر في الأفراد من الطبقات الفقيرة اقتصادياً وأجتماعياً أكثر من غيرهم. والصفة الأساسية لهذه الشخصية هي الشك وسوء الظن والحساسية المفرطة تجاه أفعال الآخرين؛ فالمصاب:

- يتوقع دائماً أن يكون مخدوعاً من الآخرين لذا فهو كتوم وحذر.
- لايتقبل عبارات اللوم حتى عندما يستحقها.
- لايقدر افعال الآخرين الايجابية نحوه حق قدرها.
- يهتم كثيراً بالدوافع الخفية لسلوك الآخرين.
- غيرته شديدة وقد تصل حد الذهان.
- سريع الغضب، غليظ القلب لايرحم، ضيق الصدر لايتقبل المزاح.
- ومع كل ذلك فهو يشعر بالزهو والغرور ويصف نفسه بأنه يمتاز بالموضوعية والعقلانية.

اذا أصيب بمرض بدني فمن المتوقع منه إسقاط مشاعر الغضب والعدوانية على الآخرين ومنهم الملاك الطبي؛ لذا يجب التعامل معه بصراحة ووضوح وصدق وإطلاعه على تفاصيل الاجراءات العلاجية، مع تجنب الاقتراب منه اكثر من اللزوم او اقامة علاقات حميمة معه.

الشخصية الفصامية SCHIZOID (P.D)

ويمتاز المصاب بما يلي:

- الانطواء والعزلة الاجتماعية المتمثلة في ندرة الأصدقاء.
- تحسس المزاج مع فتور المشاعر وانعدام العواطف الرقيقة.
- مثالي، نظري وغير عملي في التفكير ولا يكترث بمديح الآخرين أو نقدهم له.
- يميل الى الاعمال المنعزلة ومعدومة المنافسة ولايرغب بالزواج.

لاتعني الاصابة باضطراب الشخصية الفصامية استعداداً للاصابة بالفصام العقلي.

اذا أصيب المضطرب بمرض بدني فأنه يتأخر في استشارة الطبيب حتى تتفاقم الحالة، وقد يترك المريض المستشفى رغم نصائح الاطباء له بضرورة البقاء. وعلى الطبيب أن يدرك ان كسب ثقة المريض تحتاج الى الوقت والصبر الطويلين ويجب التعامل بلطف ومرونة مع المصاب وتجنب التدخل في شؤونه الشخصية.

الشخصية الرحامية HISTRIONIC (P.D)

تصيب النساء عادة اكثر من الرجال، وأهم خصائصها مايلي:

1) البحث الدائم عن عبارات الإطراء والمديح، وعند عدم الحصول على الانتباه يحس بالضجر ويتصف سلوكه بالعصبية.
2) بالرغم من المظهر الخارجي الجذاب والرقيق للمصاب فهو مغرور، وقادر على الكذب والمغالاة في اظهار المشاعر، كلامه مؤثر ويميل الى المبالغة والتمثيل ولكن عواطفه سطحية متغيرة.
3) حب الذات والإهتمام بها وعدم الاكتراث بمراعاة شعور الآخرين.
4) غير صبور ولايتحمل تأجيل رغباته ولكنه عادة اتكالي، غير مثابر ويبحث عن الطمأنينة من الآخرين لإزالة مخاوفه.

تحاول المرأة المصابة اثارة اهتمام الآخرين وجذبهم بمختلف طرق الإغواء كالاهتمام الشديد بالملبس والزينة والمظهر الجميل وهي في الوقت نفسه تعاني عادةً من البرود الجنسي بسبب عدم النضوج في النمو العاطفي الجنسي.

اذا راجع الطبيب لسبب ما فأنه يبدو جذاباً وفاتناً (خاصة اذا كان الطبيب من الجنس الاخر). وعلى الطبيب التمسك بأداب السلوك المهني، مع معاملة المريض بلطف وان يقدم له الدعم والاسناد النفسي ويتجنب العقاب والنقد واللوم.

الشخصية المتجنبة (القلقة) AVOIDANT (ANXIOUS) P. D

يتصف المصاب بما يلي:

- الخجل والخوف الذي لايتناسب مع الظروف التي يواجهها.
- يتحاشى تكوين علاقات انسانية بالرغم من وجود الرغبة لديه للاختلاط بالناس، وهذا التجنب ناشئ من شعور الفرد بالخوف من ان يكون مرفوضاً من الآخرين ومن خشيته انتقاد الناس لسلوكه لذلك تجده ينتقد نفسه ويلومها دائماً ويشعر بهبوط معنوياته.
- يتجنب المهن والفعاليات التي تتطلب الاختلاط بالآخرين ويميل الى اختيار الاعمال الثانوية ومن النادر ان يحقق اي تقدم وظيفي او مهني مهم.
- لايحاول أن يستخدم اي شكل من اشكال السلطة في تعامله مع الآخرين بل أنه اثناء حديثه مع الآخرين يتكلم بطريقة تدل على ضعف الثقة بالنفس وعدم اليقين.

- ❖ يخاف ويتوقع الخطر من مصدر غير واضح وعندما يكون المصدر واضحاً فأن ردود فعله تكون اكثر شدة وقلقا مما يقتضيه الموقف.

عندما يستشير الطبيب فأنه يكون متعاوناً وقادراً على رعاية نفسه وتنفيذ التعليمات الطبية، وتكون علاقاته بالكادر الطبي جيدة ولكن يجب الانتباه الى ان مريضاً من هذا النوع يكون حساساً جداً لأي نقد يوجه اليه او أية تصرفات تهدف الى السخرية منه أو تبدو كذلك.

الشخصية الوسواسية
OBSESSIVE- COMPULSIVE (P.D)

يتميز المصاب بهذا الاضطراب بما يلي:

- ✓ حبه للنظام وميله نحو الاتقان والكمال الى الحد الذي يؤخر انجاز العمل.
- ✓ العناد والبخل والتصلب في الآراء والمواقف.
- ✓ عدم القدرة على اظهار المشاعر الرقيقة والدافئة والودية تجاه الآخرين.
- ✓ اهتمامه بالنظافة ومظهره انيق في العادة.
- ✓ يكون وضع جسمه في حالة الوقوف او الجلوس متكلفاً او متخشباً.
- ✓ من ابرز اهتماماته هي الجدية في العمل والاهتمام بالوقت ودفاتر الملاحظات وعادات التغوط.
- ✓ يتميز حديثه بكثرة التفاصيل والتشعب في دقائق الموضوع قبل ان يصل الى النتيجة التي يريد وصولها.
- ✓ لايتخلص من الحاجات غير المفيدة او المستهلكة بالرغم من عدم وجود اية قيمة عاطفية او مادية لها.
- ✓ يستحوذ على تفكيره الانشغال بالقواعد والنظام والتفاصيل والتمسك بالقيم والاعراف الاجتماعية.
- ✓ يعطي الكثير من وقته وطاقته للعمل على حساب حياته الاجتماعية.

ان اصابة الفرد الوسواسي بأي مرض بدني يؤدي الى زيادة ظهور خصائص الوسواس لديه فيصبح اكثر عناداً وتصلبا عن ذي قبل؛ مما يؤدي الى الشكوى من نظام المستشفى والعناية الطبية بشكل عام. وعلى الطبيب المعالج ان يعطي المريض الفرصة الكافية للمشاركة في اتخاذ القرارات الطبية حول فحوصاته وعلاجه.

الشخصية المضادة للعرف الاجتماعي ANTISOCIAL P. D

تتصف هذه الشخصية عادة بما يلي:

- التاريخ الطويل والسلوك المستمر في الإضرار بحقوق الآخرين المادية والمعنوية.
- المصاب أناني يركز اهتمامه في ذاته فقط، ويقصر في حق زوجته واطفاله.
- فاقد للشعور بأحاسيس ومشاعر الآخرين.
- ملحاح ومطلبي.
- عدواني شديد الانفعال وكثير الشجار ويتصف سلوكه اليومي بألاخلال بقواعد السلوك المتعارف عليها في المجتمع وبالرغم من تصرفاته هذه وإضراره بالآخرين فهو لا يشعر بتأنيب الضمير ولا بالقلق او بالألم.
- لايتعلم من تجاربه في الحياة كيف يكبح نزواته وهفواته.
- لا يستطيع ان يخطط لمستقبله فهو طائش متهور.
- كذاب ومراوغ يستطيع ان يستميل الاخرين اليه عن طريق المكر والدهاء مستغلا ثقة الناس به لتحقيق مآربه ولايفي بألتزاماته المادية.
- يتعثر ويهرب من عمله ويغيره بأستمرار.
- يعتبر الادمان على العقاقير من الحالات الشائعة لدى هؤلاء المصابين وهم لايراجعون عيادات الطب النفسي الا مكرهين او لأن اللجوء الى مثل هذه الاستشارات هي محاولة منهم للتخلص من المسؤولية الجنائية؛ فهم يمثلون نسبة عالية من زبائن المحاكم ونزلاء السجون.

عندما يراجع المصاب المؤسسة الصحية يكون مراوغاً ولا يتعاون في المعالجة ويخالف التعليمات ويصعب على الكادر الصحي التعامل معه لأنه لا يؤتمن وقد يغادر المستشفى ويرفض العلاج رغم نصيحة الاطباء له. على الطبيب المعالج ان يكون صارماً معه مع عدم اللجوء الى الاساليب العقابية أوالتأديبية في التعامل معه.

الصرع
EPILEPSY

هو نوبات متكررة من إضطراب وظائف الدماغ, تحدث بصورة مفاجئة وتنتهي تلقائياً ويرافقها إضطراب كلي أو جزئي في الوعي والسلوك ويقدر بأن واحداً من كل (13) شخص معرض له.

الأسباب:

أولاً- ذاتي (أولي) Idiopathic: والمقصود به أنه مجهول السبب.

ثانياً- ثانوي Secondary: حيث يحدث الصرع جراء وجود أمراض أخرى مثل:

أ- أمراض الدماغ الموضعية (كالأورام) أو الشاملة والإلتهابات والشدة على الرأس.

ب- الإضطرابات الأيضية Metabolic والأمراض الأخرى التي تصيب باقي أعضاء الجسم وتؤثر أيضاً على وظائف الدماغ، كحالات التسمم ونقص الأوكسجين وهبوط السكر والكالسيوم والأملاح الأخرى وعجز الكبد والكليتين والقلب والحمى العالية، ... إلخ.

ت- الأعراض الأنسحابية للكحول والعقاقير أو التسمم بها

أنواع الصرع: يصنف الصرع إلى نوعين رئيسين وفيهما أنواع فرعية كثيرة وسنذكر الأهم منها، وكما يلي:

1. الصرع الشامل الأولي Generalized:

أ- الصرع الأكبر Grandmal

ب- الصرع الأصغر Petitmal or Abscence

ت- الصرع الرمعي (الارتعاشي) Myoclonus

2. جزئي Partial:

أ- بسيط Simple

ب- معقد Complex

ت- جزئي يتحول إلى شامل ثانوي

Partial evolving to Secondary generalized

1- الصرع الشامل الأولي

أ- الصرع الأكبر Grandmal

وهو أكثر الأنواع شيوعاً ويبدأ في الطفولة أو المراهقة وأحياناً بعد ذلك. تبدأ النوبة غالباً بصرخة عالية وتخشب عام وسقوط وفقدان وعي كامل وازرقاق تعقبه بعد حوالي ½ دقيقة إختلاجات عضلية شديدة في الجسد كله واحتكاك الأسنان وقضم اللسان وزبد من الفم وسلس البول والبراز، وتستمر لمدة دقيقة تقريباً يعقبها الخلود إلى النوم ليستيقظ بعدها المصاب متعباً وقد يعاني من الصداع والدوخة والغثيان ولايدري بما حصل له.

وقد يحس المصاب بقرب حدوث النوبة جراء مايسبقها من أنذار يسمى النسمة Aura.

ب- **الصرع الأصغر** Petitmal (Absence)

يبدأ في الطفولة عادة وينتهي عند البلوغ ويكون فقدان الوعي فيه غير ملحوظ ولثواني معدودة فقط ويكون مصحوباً بتحديق في الفراغ أو بسقوط جزئي أو برمح عضلي Myoclonus (حركة لا إرادية شديدة، سريعة وقصيرة الأمد). وتنتهي النوبة دون أن يتذكرالمريض شيئا منها في النهاية.

ولابد من الإنتباه لهذا النوع من الصرع في المدارس؛ فقد يحدث لأحد التلاميذ ويظهر بشكل شرود ذهني أو إنشغال الفكر بشيء آخر. و يسبب الكثير من المشاكل للعملية الدراسية وللطفل الذي يتدهور مستواه الدراسي ويتعرض لكثير من اللوم والعقوبات من المعلمين والأهل الذين لايعلمون بأن مايحصل للطفل هي أعراض مرضية تستوجب مساعدة الطفل ومعالجته.

ت- الصرع الرمعي Myoclonus

يحدث على شكل تقلص وحركة لا إرادية، قوية، جزئية أو شاملة في عضلات الجسم وبدون إضطراب في الوعي أو السلوك ولايستغرق سوى أجزاء من الثانية ويتكرر بنفس الشكل (بنمطية) وقد يعقبه حدوث الصرع الأكبر, أو يرافق الصرع الأصغر, أو يحدث لوحده عند المصابين بإعتلال الدماغ والأمراض الأيضية الوراثية.

2- الصرع الجزئي Partial

أ- **الصرع الجزئي البسيط Simple Partial**

ومثاله صرع جاكسون, وسببه عادة آفة موضعية في الدماغ كالأورام, ويحدث على شكل إضطراب في واحدة من وظائف الدماغ الحركية أو الحسية أو السمبثاوية أو النفسية ولفترة وجيزة يدركها المصاب لإنه يكون محتفظاً بوعيه. وتتصف بحدوثها المفاجيء وتكرارها بنمطية ثابتة وإنتهائها تلقائياً. وقد يتطور إلى الصرع الجزئي المعقد إذا رافقه اضطراب الوعي.

ب- **الصرع الجزئي المعقد Complex Partial**

ومثاله الصرع الصدغي, أو الصرع الحسي الحركي. وسببه عادة آفة موضعية في الفص الصدغي للدماغ. وهذا النوع يشبه الصرع الجزئي البسيط ولكن يرافقه (منذ البداية أو لاحقاً) إضطراب مستوى الوعي بدرجات متباينة وقد يتطور إلى صرع شامل.

ت- **الصرع الجزئي الذي يتحول إلى شامل ثانوي**

وهو يبدأ على شكل الصرع البسيط أوالمعقد إلا انه يتطور إلى صرع شامل كالصرع الأكبر، ولا يمكن التمييز بينهما إلا من النسمة التي تسبق هذا النوع عادةً وبصورة واضحة ووقت كاف قبل حدوث نوبة الصرع الأكبر الثانوي ويتذكرها المريض. وسببه عادةً أفة موضعية في الدماغ.

هذا وهناك أنواع عديدة أخرى من الصرع لا يسمح المجال ولاضرورة لذكرها هنا.

تشخيص الصرع:

لغرض الوصول لتشخيص الصرع يحتاج الطبيب إلى:

1. الوصف السريري التفصيلي للنوبة من قبل المريض أو مرافقيه وهل كانت مصحوبة بإضطراب الوعي أو الغيبوبة ام لا.
2. التخطيط الكهربائي للدماغ (Electro Encephalo Gram) حيث تحصل تغيرات فيه أثناء النوبة وبعدها ولفترة غير محددة. علماً بأن المخطط الطبيعي بين النوبات لا ينفي وجود المرض.
3. التصوير الشعاعي للجمجمة، مفراس الدماغ و الفحوص المختبرية للدم .

يعتمد التشخيص النهائي على تقدير الطبيب المستند للفحص السريري والتحريات الأخرى مع ضرورة الإنتباه إلى أن كل حالة صرع تبدأ بعد سن العشرين تعتبر ثانوية ويجب إجراء التحريات كلها بحثاً عن السبب العضوي الأساس وعلاجه أما الحالات قبل هذه السن فمعظمها أولية وبدون سبب معروف وقد نكتفي بتحريات قليلة لها.

التشخيص التفريقي:

لابد من تمييز الصرع عن الحالات التالية والتي تشابه نوبات الصرع:

1. نوبات السقوط التحويلية (المسماة بالهستيريا سابقاً).
2. حالات الإغماء البسيطة بسبب هبوط ضغط الدم Syncope
3. حالات الإغماء الوعائي بسبب الخوف Vasovagal syncope
4. نوبات الذعر Panic attacks
5. الإضطرابات الأيضية كهبوط نسبة السكر أو الكالسيوم في الدم.

العلاج:

1. **علاج النوبة:** تنتهي النوبة تلقائياً عادة ولاتستوجب أية مداخلة عدا المحافظة على تنفس المريض بثني الرقبة للخلف قليلاً وللجانب مع فتح الأربطة والأزرار عن الصدر والعنق مع التأكد من عدم وجود شيء في الفم تجنباً للإختناق ويفضل وضع عازل في الفم عندما يحصل ويفتح المصاب فمه، *وينبغي تجنب إستعمال القوة لذلك.*

2. **العلاج الوقائي:** ويهدف إلى تجنب حصول نوبات لاحقة ويتم بوصف مضادات الصرع وأهمها مايلي مع ملاحظة إن الجرع المذكورة أدناه عمومية وللبالغين ويترك تحديد نوع العلاج وجرعته للطبيب الاختصاصي:

1. Carbamazepine (Tegretol): 200 mg tid daily
2. Sodium Valproate (Depakine): 200- 400 mg bid or tid .
3. Phenobarbiton (Gardenal): 30 mg tid .
4. Phenytoine (Epanutin): 100 mg tid .
5. Clonazepam (Rivotril): 0.5 - 2 mg bid - tid .
6. Ethosuxemide (Zarontin): 250 mg tid .

- بالنسبة للصرع الأكبر والصرع الجزئي بأنواعه يمكن إستعمال أحد العقاقير الأربعة الأولى أعلاه.
- أما الصرع الأصغر فيستعمل له الثاني أو السادس.
- أماالصرع الرمعي (الارتعاشي) فتستعمل له عقاقير الصرع الاصغر إضافة إلى الخامس.

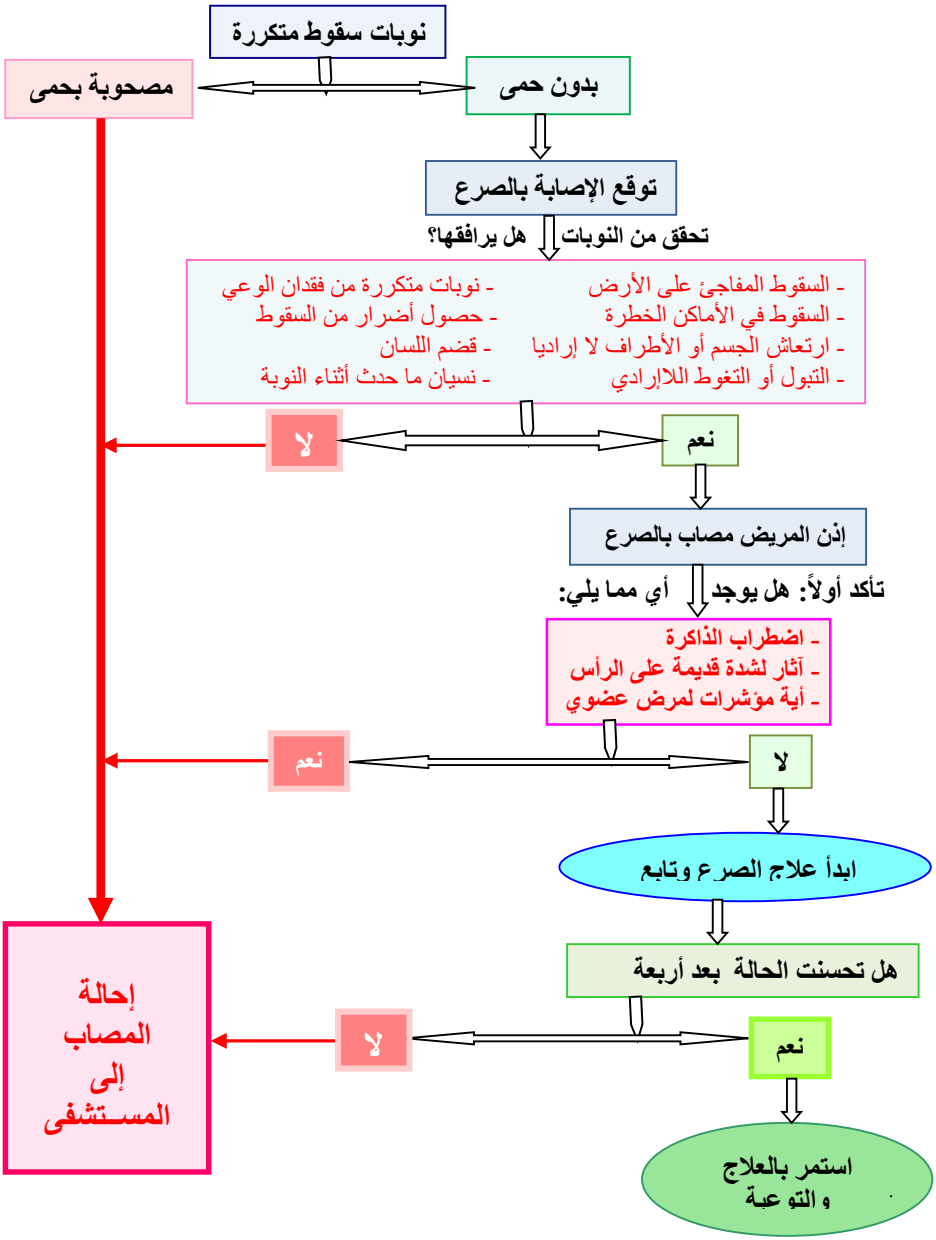
ملاحظات مهمة في المعالجة:

- الفينوباربيتون يجعل حالة المصاب بالصرع الأصغر أكثر سوءاً.
- ينبغي تفادي الفينتوين للبنات لانه يسبب حب الشباب ويغير معالم الوجه كالأنف والحواجب.
- يفضل تفادي الريفوتريل قدر المستطاع لأنه يسبب الأدمان.
- على المريض إستخدام علاج الصرع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد آخر نوبة ثم يقلله تدريجياً وببطء وعلى مدى عدة أشهر.
- يجب ملاحظة التأثيرات الجانبية لهذه العقاقير وتغيير العقار عند الضرورة والإبتعاد عن وصف أكثر من عقار في وقت واحد. وعند التغيير يعطى العقار الجديد أولاً ويسحب العقار السابق تدريجياً تفادياً لحدوث الصرع المستمر (أي نوبات صرعية متكررة وبدون توقف) status epilepticus الذي يسببه التوقف المفاجيء عن أخذ الدواء ويعتبر حالة طارئة وقد تؤدي إلى الوفاة إذا أهملت, ويكون العلاج بأعطاء أمبول فاليوم (10 mg) بالوريد ببطء ويعقبه فاليوم وريدي مستمر (توضع 60 ملغم فاليوم في 250 كلوكوز سلاين ويغذى المريض به ببطء وتكيف سرعة التغذية الوريدية بجهاز الإعطاء حسب تجاوب حالة المصاب).

نصائح عامة للمريض ولأهله:

1. يجب الانتظام بأخذ الدواء ومراجعة الطبيب بصورة دورية أوعند حدوث أي شيء جديد ويجب عدم الإنتباه إلى توجيهات غير الأطباء بهذا الخصوص أو التصرف كيفياً.
2. يجب عدم التمييز بين المريض وأقرانه في المعاملة وعدم إشعاره وتذكيره بحالته وينبغي أن يمارس حياته بصورة اعتيادية, فلا يتوقف عن دوامه وعمله مثلاً.
3. يمكن للمصاب أن يتزوج ولكن من عائلة ليس فيها مصاب بالصرع .
4. يمكن للمرأة المتزوجة أن تنجب كالأخريات بعد المداولة مع الطبيب المعالج, وينبغي الإنتظام في العلاج أثناء الحمل وبعد الولادة.
5. يستطيع المصاب ممارسة هواياته كاملة, ولكن ينبغي الإبتعاد عن المؤثرات الضوئية والضوضاء والجوع والصوم والأرهاق. وتجوز مشاهدة التلفزيون باعتدال مع عدم الجلوس قرب الشاشة أو بمواجهتها. ويستطيع ممارسة الرياضة والعمل, ولكن عليه أن يتجنب الأماكن المرتفعة والألات والمكائن الدوارة والأسلاك الكهربائية. ويمكنه ممارسة السباحة في الأحواض غير العميقة وتحت إشراف المنقذ، وبامكانه ركوب الدراجة الهوائية بوجود أحد ذويه أو أصدقائه وبعيداً عن الشوارع والطرق الرئيسة التي تكثر فيها المركبات.
6. يمنع المصاب من السياقة لحين مرور ثمان سنوات على الأقل على إكتسابه الشفاء التام (أي بعد أخر نوبة) وخمس سنوات على ايقاف العلاج من قبل الطبيب المعالج وعليه أن يستشير طبيبه في ذلك.

مخطط التدبير السريري للصرع



مضادات الصرع: (تحدد الجرعة من قبل الطبيب الأختصاصي)

- كاربامازبين (تكريتول)/ (200) ملغم/ 3 مرات يومياً
- فينوباريتون (لومينال)/ (15- 30) ملغم/ 3مرات يومياً
- صوديوم فالبروات (ديباكين)/ (200- 400) ملغم/ 2- 3 مرات يومياً

العلاقة بين الطبيب والمريض و الاتصال

DOCTOR-PATIENT INTERACTION & COMMUNICATION

من العوامل المهمة التي تعين الطبيب على النجاح في عمله في ممارسته الطبية عموماً هي قدرته على إقامة علاقة جيدة ناجحة مع المريض، فمثل هذه العلاقة:

- تساعد الطبيب في الوصول الى التشخيص الصحيح ووضع خطة العلاج المناسبة.
- تزيد من ثقة المريض بالطبيب وقناعته والتزامه بالعلاج.
- تزيد من ثقة الطبيب بنفسه واحترامه لذاته.
- خفض كلفة العلاج ورفع الجدوى الاقتصادية.
- تقلل بشكل كبير من المشاكل واحتمالات المقاضاة القانونية والمالية.

وتختلف قدرات الأطباء في بناء هذه العلاقة باختلاف معارفهم بعلم الاتصال COMMUNICETION ومهاراتهم في التطبيق0

والاتصال بكل بساطة يعني عملية التفاهم من خلال نقل المعلومات او الأفكار (الرسائل) من ذهن الفرد الأول (المرسل) الى ذهن الفرد الثاني (المستقبل) وبالعكس حيث يتم تبادل هذه الرسائل بينهما للوصول الى فهم مشترك للموضوع المبحوث0

والاتصال عموماً نوعان:

1- الاتصال اللفظي: أي المعلومات التي يتم تبادلها باستعمال الكلمات (المنطوقة أو المكتوبة). ويشكل هذا النوع حوالي 35% من مجموع الاتصال الناجح0

2- الاتصال غير اللفظي: ويشمل كل المعلومات المتبادلة باستعمال الإيماءات والحركات وتعابير الوجه وما شابه0 وهذا النوع مهم جداً فهو يشكل 65% من مجموع الاتصال. ويعتمد على نوعين من التعابير او المؤشرات التي تعطينا المعلومات عن الشخص المقابل:

ا - المظاهر او المؤشرات الثابتة: والمقصود بها الشكل او المظهر كالطول او القصر ،الملابس، ارتداء الحلي او المجوهرات، المكياج0

ب- المظاهر او المؤشرات المتغيرة (الحركية): مثل وضعية الجسم وحركاته، النظر في العينين، تعابير الوجه، طريقة الكلام، نبرة التحدث، درجة الصوت ونغمته0 الخ

ولتحقيق الاتصال الجيد لابد للطبيب ان يعتني بترتيب مظهره الخارجي مع ارتداء الصدرية النظيفة، وان يستقبل المريض بهدوء ورزانة وابتسامة تدل على الود والاحترام ويستحسن ان يجلس المريض بجانب الطبيب وليس مواجهاً له وبينهما منضدة؛ لكي لا تبدو المقابلة وكأنها تحقيق واستجواب. مع السعي لتأمين مكان ووقت مناسبين لتحقيق الأتصال الفعال (بيئة اتصال مناسبة).

سنذكر هنا الأساليب الصحيحة التي يتبعها العامل الصحي الناجح الجيد في ممارسته العملية:

1- ينظر في عيني المريض منذ البداية بشكل ودي تعبيراً عن احترامه واهتمامه به.
2- يبدأ بأسئلة مفتوحة عن شكوى المريض وليس بأسئلة مغلقة جوابها (نعم) أو (لا).
3- يستعمل مفردات لغوية بسيطة ومفهومة للمريض ويتجنب المصطلحات العلمية المعقدة.
4- يستوضح شكوى المريض بصورة جيدة.
5- يظهر تعاطفه (ولكن ليس الشفقة) مع المريض. أي يبين تفهمه وتقديره لما يشعر به المراجع.
6- يبين للمريض منذ البداية بأنه مستعد وحريص على مساعدته (وهذا مهم لتطمين المراجع وتعاونه).
7- يجيد الإصغاء.
8- ينتبه ويلاحظ اللمحات العاطفية التي تبدو على المريض ولكل ما يدلل على حالته النفسية (مثلاً الحزن او الخوف أو الغضب) ويتصرف بطريقة مناسبة للحالة.
9- لا يتصرف بطريقة سلطوية متعالية.
10- قادر على المداخلة الساندة عند تحدث المريض ويستطيع إيقافه بصورة دبلوماسية إذا استدعى الأمر.
11- يتجنب إعطاء الآراء والمعلومات منذ الدقائق الاولى للمقابلة.
12- يتصرف بودية وباسترخاء مع المُستفيد و لا يتحرك بسرعة ولا يتحدث بعصبية.
13- ينحني قليلاً باتجاه المُستفيد من وقت لآخر لإشعاره بالأمان والألفة والمشاركة.
14- يستخدم الإيماءات والاستجابات التي تظهر الاهتمام وتشجع التواصل.
15- يتجنب استخدام الكلمات التي تبدو وكأنها تصدر أحكاماً بحق المراجع.
16- يسجل الملاحظات المهمة للعودة لها عند الحاجة.
17- يخرج المراجع من عنده وهو يشعر بان الطبيب (أو العامل الصحي) قد فعل كل ما يستطيع لمساعدته في حل مشكلته.

قد يتبادر الى ذهن القارئ في الوهلة الأولى أن هذا الكلام مثالي ونظري ولايمكن تطبيقه عملياً، ولكن لو تمعنا فيه لوجدناه لايتعدى اخلاقيات وقواعد التعامل الاجتماعي المتمدن وأننا نطبق كثيراً منه فعلياً. كما انه مهارة تتطور باستمرار التطبيق وتصبح بمرور الوقت سلوكاً مهنياً معتاداً وروتينياً.

ولابد ان نؤكد في نهاية هذا الفصل ان هذه العلاقة الجيدة مطلوبة وواجبة في الممارسة الطبية عموماً لكل الفروع الطبية وليست خاصة بممارسة الطب النفسي فقط، لا بل انها مهمة وضرورية لكل الممارسات الحياتية.

المشاورة والارشاد النفسي

هي عملية علمية، هادفة، ومرتبة تتضمن محادثة سرية بين المشاور(المرشد) النفسي وبين المراجع (المستفيد) (سواء كان فرداً، أو زوجين، أو غير ذلك) . و تهدف الى مساعدة المراجع على استيعاب وفهم الصعوبات التي يمر بها واختيار أفضل أسلوب ممكن لتجاوزها. والمشاورة عملية فعالة يقوم خلالها المشاور النفسي وبالتعاون مع المراجع، بالعمل على استكشاف وتحليل مشاكل، أفكار، وعواطف، وامكانيات المُراجع وتحديد موارد الدعم والإسناد والمساعدة المتيسرة له والتي يمكن أن يستفيد منها لتجاوز الصعوبات التي يمر بها وليعيش في أحسن حال ممكن بالنسبة له.

المشاورة تدعم وتساعد المراجع على التعامل مع الظروف الصعبة بشكل مقبول؛ إذ يقوم المشاور بمساعدة المُراجع على إعادة ترتيب أفكاره لتحديد أبعاد مشكلته بوضوح واستبيان ودراسة الحلول أو أساليب التعامل الممكنة معها واختيار الأسلوب الأفضل له. كما يقوم المشاور بإعطاء المعلومات والإرشادات الصحية اللازمة وذات الصلة بمشكلة المراجع. ومن المهم جداً في المشاورة المتابعة وتحديد موعد الزيارة التالية وعادة يحتاج المستفيد 6 الى 8 جلسات للوصول للنتيجة المتوخاة.

عند بحث مشكلة المراجع، لا يجوز التقليل من قيمة وأهمية أي شكوى له مهما كان رأينا الشخصي بها. ولايجوز أن نطلب منه كبت مشاعره (مثلاً: لاتبكِ، استرخِ قليلاً، أو إهدأ لنتفاهم) وعلى عكس ذلك نبين له تفهمنا وتقديرنا لمشاعره وله الحرية في التعبير عنها.

على المشاور استكشاف مصادر الدعم المتيسرة للمستفيد (مثل العائلة، الأصدقاء، العمل، الدراسة، المواهب، المساعدات القانونية، المساعدات الاجتماعية) ثم يتدارس معه امكانية الاستفادة العملية منها. ومن المهم ان نتذكر بأننا لا نقدم الحل لمشكلة المراجع بل نساعده لاختيار الحل الأنسب له (ليس المشاور الذي يقرر الحل الأنسب بل المراجع نفسه).

إن أهم الأدوات التي يستعملها المشاور هي: الاستماع الفعَّال، طرح الأسئلة المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، الإنتباه الجيد لحالة المراجع النفسية وإبداء الاحترام الفعلي له ولمشاعره وتشجيعه عند قيامه بأي شيئ ايجابي مهما كان صغيراً.

إن تطبيق مهارات المشاورة والاتصال بشكل جيد تُمكِّن المُراجع غالباً من اتخاذ القرار المناسب بشأن التغييرات التي يمكنه إجراؤها في حياته والتقدم نحو اتباع أنماط حياتية أكثر نفعاً وراحة له.

إن حل المشاكل يكون أسهل:

- بتجزئة المشاكل إلى مشاكل أصغر.
- بالاهتمام بالمشكلة الأهم بالنسبة للمستفيد.
- بالبحث عن الحلول والبدائل الممكنة.

انظر ملحق رقم (6) رجاءاً (موجز أسس المقابلة للمشاورة والارشاد النفسي)

العنف

العنف: هو عدوان غير مشروع موجود منذ قديم الزمان. وهو سلوك غير محبب وخطير أحياناً. وعدم التصدي لمشكلة العنف يؤدي الى تاثيرات سلبية كثيرة في المجتمع ويعطل طاقاته ويعيق تقدمه[1]؛ لذلك يتوجب العمل على مكافحة العنف والسيطرة عليه[2] وتقديم أفضل الخدمات لضحاياه.

ان السيطرة على العنف هي مسؤولية وواجب المجتمع بمؤسساته وأفراده كافة، أما بالنسبة لنا فنحن معنيون بتقديم الخدمات الصحية للناجين منه مع العمل لمعالجة الجاني قدر ما أمكن ذلك. ولا يجوز لنا أن نضع انفسنا بموقع القضاء والحكم على هذا أو ذاك وننسى دورنا الأساس في تقديم الخدمات الصحية. ولكن نؤكد أن من واجبنا الأساسي، أن نعمل كل ما بوسعنا لتثبيت الحقائق والمشاهدات الطبية لمساعدة القضاء وحفظ الحقوق. كما ونتعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية ذات الصلة لتوفير الخدمات القانونية والاجتماعية والأمنية وغيرها للضحية.

العنف كما عرفته منظمة الصحة العالمية هو الاستعمال المتعمد[3] للقوة الفيزيائية (المادية) او القدرة سواء بالتهديد او الاستعمال الفعلي لها من قبل الشخص ضد نفسه او ضد شخص آخر او ضد مجموعة أو مجتمع بحيث يؤدي الى حدوث (او رجحان احتمال حدوث) اصابة أو موت أو اصابة نفسية أو سوء النمو او الحرمان.

على من يقع العنف؟: قد يكون العنف موجهاً للذات أو للآخرين وكما يلي:

1- **العنف نحو الذات** ويظهر بشكل:

أ – سلوك انتحاري

ب- انتهاك ذاتي (إيذاء النفس)

2- بين الاشخاص

أ- عائلي: يحصل من أحد افراد العائلة تجاه فرد آخر فيها (طفل، مُسِن، أو قرين) وغالباً ما يكون داخل المنزل

[1] للعنف عواقب وخيمة ذات أبعاد صحية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وحضارية.

[2] السيطرة عليه تعني تقليل حدوثه وانتشاره لأدنى مايمكن.

[3] غير القانوني

ب- مجتمعي: يحصل عادة خارج المنزل ويكون تجاه معارف او أغراب.
ت- جماعي: يحصل من مجموعة أو أكثر تجاه مجموعة أخرى أو اكثر.

العنف المبني على النوع الاجتماعي (الجندر): ويقصد به العنف الممارس على الآخر بسبب جنسه او باعتباره أدنى قيمة. **و***ما يعنينا هنا بشكل خاص هو العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة*، وهو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر، وينتج عنه او يحتمل ان ينتج عنه ضرر او معاناة بدنية او جنسية او نفسية للمرأة، ويشمل ذلك التهديد بمثل تلك الأعمال او الاكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حصل ذلك في الحياة الخاصة او العامة. (قد يحصل العنف تجاه الرجل ولكن نسبة ذلك قليلة جداً ولا تذكر مقارنة بالعنف الحاصل على النساء في العالم)

اشكال (انواع) العنف:

1- **نفسي (لفظي أو عاطفي): ومن أمثلته،** الاهانة العلنية والنبز بألقاب مكروهة، التهديد والضغط، العزل (المنع من الاختلاط والزيارات بسبب الغيرة أو غيرها)، إهمال الطفل أو سوء الأستغلال، الحرمان، الخ.

2- **جسدي:** ومن أمثلته، الضرب، اللكم، الركل، والخ.

3- جنسي: إتباع ممارسات جنسية قسرية أو مؤلمة ويشمل ذلك ايضاً كل أنواع التحرش الجنسي بالقول أو الفعل المباشر وغير المباشر.

ملاحظة: من الناحية العملية فأن المعاناة والمضاعفات النفسية تصاحب انواع العنف كلها.

العنف المنزلي

- هو العنف الموجه من قبل شخص إلى شخص آخر يعيش معه وذي علاقة وثيقة به (قرابة، زواج، علاقة عاطفية أو رفقة)
- قد يصيب الرجل أو المرأة (ولكنه قي الأعم الأغلب يصيب النساء)
- المسيئ في العادة يتحكم بالضحية الذي غالباً يخاف المسيئ أو يحبه.

العوامل المرتبطة بالعنف المنزلي:

- تأريخ عائلي بالعنف
- سوء استعمال الكحول من المسيئ، الضحية أو الاثنين
- تأريخ مرض نفسي
- الإساءة أثناء الطفولة

دورة العنف المنزلي: تتكون الدورة من ثلاث مكونات:

أولاً: طور تصاعد التوتر:

- الضحية يكون مطاوعاً وعطوفاً محاولاً تجنب التعنيف.
- نوبات غضب المسيئ تزداد شدة وتكراراً.

ثانياً: طور التعنيف الحاد: ويحدث اثناءه التعنيف بأي شكل من أشكاله.

ثالثاً: طور المصالحة أو شهر العسل: يظهر المسيئ تصرفات المحبة والاعتذار والتأكيد أن ذلك لن يتكرر. (*احتمالية طلب الضحية للمساعدة تقل كثيراً بهذا الطور*)

لماذا تستمر العلاقة رغم العنف؟!

- بيئة العنف المنزلي معقدة وتتضمن اسباب متعددة للصبر والتحمل، ومنها:
  - الحب.
  - الأمل بأن هناك إمكانية للتغيير.
  - الاعتمادية:
    - اعتماد عاطفي
    - اعتماد اقتصادي وخاصة عند وجود الأطفال
  - الخوف من زيادة التعنيف.
  - الخوف من فقدان الأطفال أو المسكن.

- الاستسلام والشعور بالعجز ويظهر ذلك في:
  - لوم النفس
  - القلق المزمن
  - عكس اتجاه الغضب نحو الداخل (الذات)

بأي أعراض تراجعنا الضحايا؟

- إصابات جسدية مختلفة تشمل: كدمات، أنزفة، خدوش، أورام إلخ.
- شكاوى طبية غامضة.
- آلام حادة بدون إصابات منظورة.
- آلام مزمنة.
- أعراض ضغوط نفسية أو اكتئابية.
- ضعف التواصل بالنظر.

(ملاحظة: المسيئ قد يرافق الضحية ويرفض عادة ترك الضحية لوحدها ويصر على إجابة الأسئلة بدل الضحية)

المؤشرات السريرية الدالة على التعرض للعنف:

1- المشاكل الجسدية الناتجة مباشرة من التعرض للعنف، كالجروح، الكسور وماشابه ذلك.

1- المشاكل النفسية الناتجة من المعاناة ومن العيش بالخوف وتكرار التعرض للعنف.

2- المشاكل الجنسية مثل الاجهاض، الحمل، أو الامراض المنقولة عن طريق الجنس.

العوامل التي تمنع العامل الصحي من التدخل:

- عوامل اجتماعية: أي التحمل المجتمعي (نظرة المجتمع)

- عوامل شخصية:
  - التحيز نحو الجنس (النوع)
  - تأريخ شخصي بالإساءة
  - الاهتمام بالخصوصية وعدم التدخل بشؤون الآخرين.
  - الشعور بالعجز وبعدم القدرة والسلطة

- عوامل مهنية:
  - ضيق الوقت.
  - عدم كفاية المهارات.
  - عدم الاهتمام والقناعة بالمهنة أو بدوره في مكافحة العنف المنزلي.
  - وجود علاقة شخصية مع المسيئ أو غيره من أطراف المشكلة.
  - تأنيب ولوم الضحية وعدم إقرار ظروفها أو قراراتها

التدبير

- أمِن بيئة آمنة للضحية.
- إسأل عن التعنيف المنزلي أو إعرف بالإساءة من المعلومات المأخوذة.
- شخص حالة تعنيف منزلي، أقر بوجود الإساءة وطمِئن المعنفة بأنك ستساعدها.
- حدد الإصابات البدنية وقم بالأجراءات الطبية اللازمة والاحالة للمستشفى إن لزم الأمر.
- قيِم الحالة النفسية وعالج المشاكل النفسية.
- قدر الخطر المحتمل للضحية والأطفال وقيم الأمان والخيارات الممكنة.
- قدم خدمة المشاورة والارشاد النفسي واتفق على خطة المتابعة.
- احالة الضحية الى المؤسسات الأسرية أو المنظمات المجتمعية لتلقي الرعاية الاجتماعية أو القانونية اللازمة إن أرادت ذلك.
- وثق الحالة والعلامات المادية والمداخلات بوضوح كامل.

الرعاية النفسية للناجين من الكوارث

الكارثة: هي حدث مفاجئ غير متوقع، خارج عن سيطرة المتأثرين به، وينطوي على تهديد كبير للحياة والممتلكات.

وتخلف الحوادث عادة اضراراً نفسية واجتماعية شديدة اضافة الى الوفيات والاصابات والعوق والخسائر المادية الجسيمة.

انواع الكوارث:

1- طبيعية مثل البراكين والفيضانات والزلازل وإلخ..
2- بشرية من صنع الأنسان مثل الحروب والنزاعات والتهجير وحوادث النقل وإلخ..

ومن التبعات الشائعة للكوارث هي النزوح والهجرة طلباً للأمان وللحصول على ضروريات الحياة الأخرى للانسان.

النازحون: ويقصد بهم الذين فروا من محل السكن والعيش الأصلي المعتاد لهم ورحلوا الى منطقة أخرى، ولكنهم بقوا ضمن الحدود الدولية لبلدهم الأصلي ولم يجتازوها. وتقع مسؤولية رعاية النازحين بالدرجة الأولى على حكومتهم ويمكن لها ان تستعين بمساعدات اقليمية او دولية.

اللاجئون: وهم الذين فروا من بلدهم الأصلي ولجأوا الى دولة أخرى. ورعاية اللاجئين مسؤولية عالمية مع ضرورة تحمل حكوماتهم الأصلية قسطاً من تكاليف ومستلزمات رعايتهم.

الأضرار النفسية للكوارث: قد تسبب الكوارث صدمات نفسية تفوق تحمل كثير من الناس، وقد تؤثر سلباً ولفترات طويلة في الأداء الوظيفي النفسي/الاجتماعي لهم.

قد تحصل الصدمة النفسية نتيجة التعرض المباشر للموت او العنف او تعرض المقربين والأحبة للموت، وقد تحصل من رؤية المناظر المرعبة مثل:

- مشاهد القتل والتعذيب.
- مناظر الدماء و الجرحى وتناثر ألاشلاء.
- استغاثات و صراخ الجرحى والمصابين.
- العنف الجنسي و الاغتصاب.

- الحراثق والأدخنة.

العوامل المؤثرة في حصول الصدمة النفسية: ان الضرر النفسي الذي يصيب الناجين يعتمد على عوامل كثيرة ومنها:

- العمر فالاطفال أكثر تأثراً.
- الجنس فالنساء أكثر تاثراً.
- المسافة من مكان حصول الأزمة، فالقريب منها أكثر تأثراً.
- نوع الأزمة وشدتها.

الأمراض النفسية المحتملة لدى الناجين من الكارثة:

أن التعرض للظروف الصادمة قد يسبب مختلف أنواع الامراض النفسية، ولكننا نذكر هنا الشائع منها:

1. القلق.
2. الاكتئاب.
3. التدخين، الادمان على الكحول او على المخدرات.
4. الانتحار.
5. اضطراب الكرب مابعد الصدمة.
6. قد يرسب الأمراض الذهانية عند من لديهم الاستعداد لذلك.

الاسعاف النفسي الاولي: ويشمل كل الخدمات وكل مداخلات الدعم والرعاية النفسية والاجراءات العلاجية المقدمة للناجين من الكوارث او الحوادث المروعة، بهدف التخفيف من الآثار والمضاعفات النفسية للصدمات الناجمة عن تلك الحوادث. ويجب تقديمها بشكل يحفظ كرامة واحترام المستفيدين وموافقتهم ومراعاة حقوق الأنسان.

تنظيم الرعاية النفسية للناجين من الكوارث: ويكون ذلك من خلال:

1- **الاستعداد المسبق:** ويعني ذلك اتخاذ التدابير وتحوطات الأمان اللازمة لتجنب حدوث الكوارث قدر المستطاع. كما ويعني ايضاً التهيوء وبناء فرق كفوءة و مؤهلة للتدخل العلمي والعملي السريع فيما لو حصلت الكارثة. ويتم التهيوء بالتدريب المسبق وبناء القدرات البشرية والمادية للاستعداد لمواجهة الكوارث والتقليل من آثارها للحد الأدنى.

2- **الأسعاف والدعم النفسي للناجين من الكوارث:** وضعت المنظمات العالمية الرصينة هرماً قياسياً للمداخلة وتقديم الرعاية والاسعاف والدعم النفسي للناجين من الكوارث. يتكون الهرم من اربعة مستويات محددة هي:

- المستوى الأول: ويتضمن توفير المأوى والأمن ومستلزمات العيش من ماء وغذاء وغير ذلك، **وهذا هو المستوى الأهم** و يحتاجه 100% من الضحايا المنكوبين.

- المستوى الثاني: وهو اعادة انتماءات الفرد اليه مثل لم شمل العائلة، توفير اماكن للدراسة، للعب الاطفال، مكان للعبادة، الاستفادة من ذوي الخبرات والقادرين على العمل من الناجين. وهذا قد يحتاجه حوالي 80% من الناجين.

- المستوى الثالث: وهو توفير خدمات المشاورة والعلاج والدعم النفسي والذي يمكن ان يقدمه عاملون صحيون غير متخصصين بالطب النفسي بعد ان يتم تدريبهم جيدا على تقديم خدمات المشاورة والدعم النفسي واكتشاف معالجة الحالات البسيطة والاحالة الرصينة للاختصاصيين. وقد يحتاج حوالي 20% من الناجين لهذه الخدمات.

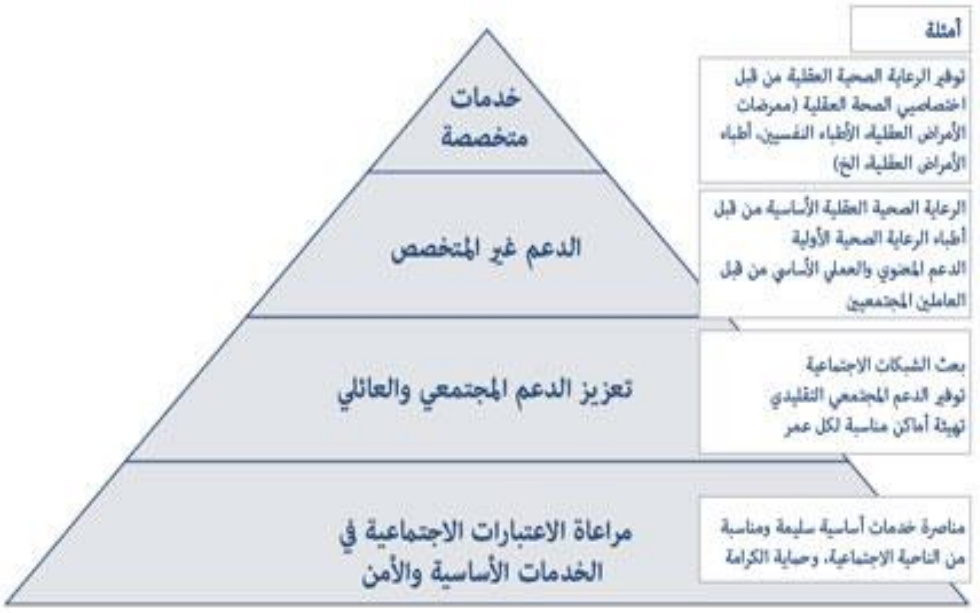
- المستوى الرابع: وهو تشخيص ومعالجة الاشخاص المصابين بالاضطرابات النفسية التي تحتاج لخدمات اختصاصي بالطب النفسي وتبلغ نسبتهم 2- 4% عادة.

دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية: نلاحظ في هرم الدعم النفسي ان الحاجة للطبيب الاختصاصي النفسي هي 4% فقط، مما يعني أن 96% من خدمات الدعم النفسي للناجين يمكن تقديمها من قبل الرعاية الصحية الأولية. ويكون تنظيم العمل كما يلي:

- ✓ التعاون والتنسيق والتوجيه والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى (الحكومية وغير الحكومية) لتقديم الخدمات المذكورة في المستويين الأول والثاني. وهذا واجب ادارة المركز الصحي والعاملين فيه جميعاً.
- ✓ تدريب و زيادة قدرات العاملين في وحدات الصحة النفس-اجتماعية في المركز الصحي وتوفير مستلزمات العمل لهم؛ لتمكينهم من تقديم الخدمات النفسية المطلوبة في المستوى الثالث. ويتضمن ذلك بالخصوص خدمات المشاورة والارشاد والدعم النفسي.
- ✓ اكتشاف وتسجيل المرضى المحتاجين لخدمات طبية متخصصة وتأمين

عرضهم على اختصاصي الطب النفسي لمعالجتهم. وهذا واجب العاملين في وحدة الصحة النفس-اجتماعية في المركز الصحي.

هرم خدمات الدعم النفسي



المصدر: الفريق المرجعي للجنة المراقبة المشتركة بين الوكالات المعني بالصحة العقلية والدعم النفسي، عام ٢٠١٠

الملاحق

(يمكن الأستفادة منها كمحاضرات موجزة جاهزة)

ملحق (1)

موجبات دمج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية

(محاضرة موجزة)

1. لأنها عنصر من عناصر الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية. وهي العنصر الأهم لأن توفرها يتيح للفرد الوصول إلى أحسن مستوى ممكن من المعافاة البدنية والأجتماعية، والعكس صحيح.

2. قلة الوعي العام بعلامات الصحة النفسية وأساليب تحقيقها وتطويرها واكتشاف اضطراباتها.

3. كثرة الأفكار الخاطئة حول أسباب الاضطرابات االنفسية وطرق علاجها.

4. أسباب طبية:

أ- انتشار الأضطرابات النفسية بشكل كبير جداً في المجتمع.

ب- ضعف قدرات العاملين الصحيين بأساليب تدبير المشاكل المرتبطة بالصحة النفسية.

ت- أكثر من 30% من مراجعي العيادات الخارجية يعانون من مشاكل نفسية ولكنهم يعاملون كمرضى بدنيين فقط؛ مما يؤدي إلى فشل المعالجة وبالتالي انعدام ثقة الناس بالخدمات الصحية وبمقدميها.

ث- الأعداد الكبيرة للمعوقين لأسباب نفسية وعصبية.

ج- ميل شخصيات معينة نحو بعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم.

ح- أهمية الضغوط النفسية في ترسيب بعض الأمراض كمرض السكر.

خ- دور الحالة النفسية في تعجيل بعض الأمراض ومضاعفاتها كالسرطان.

د- زيادة العرضة للحوادث.

ذ- وجود امكانية حقيقية لتطوير الًصحة النفسسية وللسيطرة على كثير من الأضطرابات النفسية ومعالجتها.

5. أسباب إقتصادية:

- تقليل الكُلَف العلاجية على الفرد والأسرة والدولة.
- تقليل الخسائر.
- زيادة الأنتاجية.

6. أسباب إجتماعية.

أ- يتطور المجتمع طردياً مع تحسن الصحة النفسية لأفراده وأسره.

ب- الوصمة، العزل، و الرفض الذي يتكبده المرضى بدون داع.

ت- احتمالية الزيادة في معدلات الأنحراف و العنف والجريمة.

7. موجبات قانونية، أخلاقية، و شرعية.

ملحق (2)

عناصر الرعاية الصحية النفسية الأولية

الرعاية الصحية النفسية المناسبة تتضمن: تطوير الصحة النفسية، الوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية، الاكتشاف المبكر والعلاج السريع للمرضى، المتابعة والتأهيل. ويتم ذلك من خلال واجبات (عناصر) معينة نذكرها بايجاز فيما يلي:

1) **خدمات صحية سريرية مباشرة:** وتشمل

ب. التأكد من تنفيذ المركز للفعاليات الصحية الأخرى والتي تقي من الاضطرابات النفسية. (ومنها مثلاً/ تلقيح النساء في سن الانجاب، فحص المقبلين على الزواج، رعاية الحوامل، تلقيح الاطفال، معالجة أمراض الطفولة وخاصة تلك التي قد تسبب مضاعفات خطيرة بالدماغ كالفينل كيتون يوريا)

ت. الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية.

ث. معالجة الاضطرابات النفسية البسيطة، الشائعة.

ج. الاحالة العلمية الرصينة للمصابين الى الاختصاصيين عند الحاجة.

ح. متابعة علاج الحالات المرضية المزمنة.

2) **تقديم خدمات الصحة النفسية المدرسية** بالتعاون مع التربويين وذوى الطلبة في مدارس المنطقة، وبالاستفادة من مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.

3) **التدريب:** بأقامة الدورات والندوات والمحاضرات المتخصصة للملاكات الصحية العاملة في المركز لزيادة معارفهم ومهاراتهم في هذا الحقل (*وخاصة فيما يتعلق بالوقاية من الاضطرابات النفسية والعصبية)*. كما يشمل التدريب قطاعات المجتمع الأخرى كالمدرسين والقابلات الأهليات ومتطوعي المنظمات الجماهيرية وغيرهم.

4) **مكافحة التدخين وسوء استخدام المواد.**

5) **مكافحة العنف** ويشمل ذلك تقديم الرعاية النفسية المناسبة لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

6) **رعاية المعرضين للخطورة** (المرأة، المراهقون، كبارالسن).
7) **الرعاية النفسية الأولية الناجين من الكوارث.** ومنهم النازحون والمهجرون.
8) تقديم خدمات المشاورة والإرشاد النفسي للمراجعين المحتاجين.
9) **التوعية:** بأمور الصحة النفسية وسبل تحقيقها، الوقاية من اضطراباتها وأسلوب التعامل الصحيح مع المصابين.
ويُسْتَهدَفُ بالتوعية المراجعون، المعلمون، طلبة المدارس، المقبلون على الزواج، الحوامل والأمهات، العوائل عامة وعوائل المرضى بصورة خاصة.
10) التوثيق والاخبار: بتسجيل المعلومات المتحصلة من الفعاليات السابقة كلها وجدولتها وتحليلها وارسال التقارير الشهرية بذلك الى القطاع ليرسلها بدوره الى دائرة الصحة ثم الى وزارة الصحة. وهذا الواجب من اهم الواجبات وأشدها تأثيراً في نجاح تحقيق الصحة عموماً، فان الاهتمام الجدي بهذه التقارير هو الذي يوفر المعلومات الصحيحة الكافية التي نعلم منها واقع الحال، نوعية المشاكل والمعوقات وسبل تجاوزها، فاعلية الاجراءات المتخذة، اضافة الى اخبارنا عن كفاءة العاملين ومدى التزامهم بتنفيذ الخطط والمهام المطلوبة منهم ويساعدنا في التخطيط السليم للمستقبل القريب والبعيد.
11) أي مهام أخرى ذات طبيعة نفسية قد تستجد مستقبلاً.

ملحق (3)

الوصايا الأساسية للتربية النفسية السليمة

(رسائل صحية للتوعية)

- لنعمل على تأمين أحسن صحة نفسية ممكنة لأطفالنا *(بإذن الله)* من خلال: الالتزام بإجراء فحوص ما قبل الزواج، التهيئة الجيدة للحمل، الرعاية المناسبة للحامل، الولادة بمساعدة أيد مدربة وأمينة، رعاية الطفل بالتغذية السليمة وإكمال تلقيحاته، والتنشئة المعتدلة، ثم التعليم المناسب.
- عزيزتي الام: لتشعري بسعادة الامومة ارضعي طفلك من ثديك .. انظري في عينيه .. ابتسمي له وحدثيه بلطف .. فهو انسان يحتاج منك الغذاء والطمأنينة ويتفاعل ايجابياً ويتبادل معك الحب والسعادة.
- الاكتشاف المبكر لأي خلل في سمع الطفل أو بصره يساعد في نجاح علاجه ويؤمن نمواً نفسياً واجتماعياً مقبولاً له.
- الضرب والعقاب الجسدي لايصلح سلوك الطفل بل يعلمه العدوانية وايذاء الاخرين عند الكبر.
- احترام الطفل وخاصة أمام أقرانه يعطيه الثقة بنفسه ويعلمه احترام الآخرين.
- العائلة المستقرة + الجسم السليم + التعليم والتربية الصحيحين تؤمن بيئة النمو النفسي المناسب للطفل0
- انشغال الابوين المستمر وابتعادهما عن طفلهما يزرع قي نفسه الالم ويعرضه للعقد والاضطرابات النفسية وقد يسبب المعاناة له ولعائلته وللمجتمع.
- الابتعاد عن الخلافات العائلية امام الاطفال .. يبعدهم عن العقد والاضطرابات النفسية.
- الأبوان والمعلمون هم القدوة والمثل الاعلى للأطفال، فهم يقلدونهم في حسناتهم وسيئاتهم عادة. والتصرف الصحيح أمام الطفل يعلمه الأخلاق الحميدة ويهذب شخصيته.
- ان تقويم السلوك المخطوء للطفل يعتمد على قدرة الأبوين والمعلمين في بناء وتعزيز جسور الثقة المتبادلة بينه وبين الطفل.

- ان الاسلوب الأمثل والأسهل لبناء الثقة المتبادلة بين المربي والطفل هو ابداء الحب والاحترام الحقيقي للطفل والإصغاء له لفهم معاناته ومشاكله ومساعدته على حلها0
- لنتذكر دائماً ان معاناة الطفل واضطراباته النفسية، غالباً ما تظهر على شكل أعراض أخرى مثل تأخر المستوى الدراسي، الغياب، المشاكسة، الهروب من المدرسة أو مخالفة النظام المدرسي. أو قد تظهر بشكل أعراض بدنية فقط .
- المرض النفسي هو كالمرض البدني، وهو ليس عيباً أو نقصاً فلا يجوز التقليل من شأن المريض النفسي أو وصمه أو السخرية منه، و قد يصيب أي فرد منا أو من عائلتنا فلنعامل الناس كما نود أن يعاملوننا به.
- يجب معالجة المريض النفسي على يد الطبيب المختص فقط وبتعاون العائلة والمدرسة والمجتمع.

ملحق (4)

معلومات عامة عن الصحة النفسية

- ✓ الصحة هي حالة المعافاة التامة بدنياً ونفسياً واجتماعياً *(وروحياً)* وليست خلو الانسان من المرض او العوق فقط، فالصحة النفسية اذن جزء رئيس لكمال الصحة وليست ترفاً طبياً.

- ✓ ان تمتع الفرد بالصحة النفسية ضرورة أساسية له ليكون فرداً مقبولاً في المجتمع، ناجحاً في عمله، علاقاته سليمة مع الآخرين، قادراً على التعامل مع ضغوط الحياة المعتادة بشكل صحيح ويسعى لتطوير نفسه وبيئته ومجتمعه. وهذا ينطبق على الرجال والنساء ولكافة الأعمار.

- ✓ المرض النفسي لايعني الجنون ابداً فالغالبية العظمى من المرضى النفسيين لايفقدون بصيرتهم، وهناك نسبة ضئيلة فقط من الامراض النفسية يكون المصاب فيها فاقد البصيرة فتدعونا انسانيتنا لمساعدته اكثر.

- ✓ الامراض النفسية ليست وصمة عار أو عيباً.. فكل انسان "لاسمح الله" قد يصاب بها يوماً ولابد له من معالجة ليعيش حياة هادئة له ولعائلته وللمجتمع0 وبعض هذه الامراض طارئ "حاد" يعالج في فترة وجيزة، وبعضها مزمن يحتاج لعلاج طويل أو مستمر ويشبه في ذلك مرض السكر او ارتفاع ضغط الدم مثلاً.

- ✓ الأطفال كثيراً مايصابون باضطرابات نفسية ولا ينتبه الأهل لها، وقد تكون علاماتهم بعيدة جداً عما نعتقده مرضاً نفسياً، فقد يشكو الطفل مثلاً من قلة الأكل أو التقيؤ أو الإسهال أو رفض الذهاب للمدرسة، أو الهروب منها والحقيقة انه يعاني من القلق.

✓ يمكن الوقاية من كثير من الأمراض في مختلف المراحل:

- قبل الزواج: بالفحص الطبي وتجنب زواج الأقارب عند وجود تاريخ مرضي في العائلة الا بعد استشارة الطبيب.
- أثناء الحمل: بالمراجعة الدورية لمراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
- اثناء الولادة: بأن تتم الولادة بأيد متدربة علمية امينة00
- اثناء تنشئة الطفل: بالرعاية السليمة والرضاعة الطبيعية وابداء الحب والحنان للطفل والتصرف كقدوة حسنة أمامه 00 اذ تبين الدراسات أن علاقة الطفل بمجتمعه هي مرآة تعكس علاقة أمه به في طفولته وأن الخلافات العائلية المستمرة هي من أهم الاسباب التي قد تؤدي الى الانحراف النفسي للطفل.
- اثناء تربية وتعليم الطفل في المدرسة: وهي فترة بالغة الأهمية لأنها الفرصة الأخيرة التي تمكننا من اكتشاف ومعالجة أي خطأ في تنشئة الطفل أو أي انحراف في صحته قد يؤثر على تعلمه وعلى نموه ونضجه النفسي وعلى أدائه مستقبلاً كفرد في المجتمع. ويبرز هنا الدور المهم للمعلمين وللمدرسين بصفاتهم الثقافية والعلمية ولما يمكن أن يكون لهم من تأثير ايجابي في نفوس الأطفال.

ملحق (5 أ)

الصحة النفسية المدرسية

(من قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983)
قانون مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية

الباب الثالث
الوقاية
الفصل الاول
الاكتشاف المبكر

المادة 16
الاكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية الاجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خلال توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية والاجتماعية الواقية من الجنوح.

المادة 17
اولا – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية، في مركز كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية، يعنى بدراسة ومعالجة الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.

ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية بقرار من وزير الصحة من :
ا – طبيب مختص او ممارس في الامراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند الاقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ - عدد من الباحثين الاجتماعيين.

المادة 18
اولا – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث الاجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة وفق ما ياتي :
ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص الامراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه الانفعالي.
ب – دراسة حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى علاقتهما بمشكلته.

ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصلا عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية واسباب تعرضه للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.

المادة 19

اولا – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.

ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق الاحداث او الادعاء العام اتخاذ الاجراء بحق الولي وفق احكام هذا القانون.

المادة 20

اولا – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.

ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة لا تزيد على ستة اشهر يرفع خلالها تقارير شهرية الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.

المادة 21

اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.

ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.

ملحق (5 ب)

الصحة النفسية المدرسية

التعليمات التنفيذية لمكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية

1- يؤلف المكتب في كل دائرة صحة في المحافظات من كل من:
- طبيب اختصاصي بالطب النفسي (أو ممارس نفسية إن لم يتوفر اختصاصي في دائرة الصحة)
- مدير وحدة الصحة المدرسية في الدائرة
- مدير وحدة الصحة النفسية في الدائرة.
- باحث نفسي أو اجتماعي

2- يجتمع المكتب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل لاستقبال الأطفال المحالين له. ويمكن زيادة عدد ايام الاجتماع بحسب الحاجة.

3- يكون مكان المكتب في أحد المراكز الصحية التي يمكن الوصول لها بسهولة من مراكز المحافظة الأخرى. ولا يكون المكتب في مستشفى نفسي ولا في وحدة الأمراض النفسية او الطب النفسي في المستشفى العام.

4- يتم اخبار المراكز الصحية كافة بمكان وموعد دوام المكتب؛ وذلك ليتسنى للمراكز الصحية إحالة الأطفال المُشكلين له بسهولة وبيسر.

ملحق (5 ج)

الصحة النفسية المدرسية

الرعاية الصحية النفسية المدرسية

الهدف: هوتقديم الخدمات الصحية النفسية الجيدة التي تساعد في تأمين الظروف المناسبة للنمو النفسي والاجتماعي السليم للتلاميذ والطلبة. كما وتؤمن الاكتشاف المبكر ومعالجة المصابين منهم بالاضطرابات النفسية.

يتم تقديم الرعاية النفسية المدرسية بالتعاون والتكامل بين وحدة الصحة النفسية ومسؤول الصحة المدرسية في المركز الصحي وبالتنسيق مع المدراء والمرشدين التربويين او من يقوم مقامهم في المدارس الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للمركز.

وتتضمن الخدمات مايلي:

1- فحص الطلبة الجدد للتاكد من سلامة حالتهم النفسية والعصبية وسلامتهم الجسدية اللازمة للنمو النفسي السليم (حجم الجسم والراس، تناسق حركات الراس والاطراف، البصر، السمع، الكلام، التواصل بالنظر، الاستجابات وتعابير الوجه).

2- فحص التلاميذ والطلبة المحالين من ادارات المدارس بسبب أعراض المشاكل النفسية او السلوكية والعمل على معالجتها بقدر الامكان.

3- إحالة التلاميذ والطلبة المُشكلين إلى مكتب الخدمات النفسية والاجتماعية (عند الحاجة) لغرض الفحص والتشخيص والمعالجة.

4- متابعة المدارس والتاكد من توفر الظروف المناسبة للتربية والنمو النفسي السليم للتلاميذ والطلبة، بما يؤمن وصولهم إلى أعلى مستوى ممكن من الذكاء لكل منهم واكتساب المهارات النفس اجتماعية وتنميتها ليصبحوا اعضاء نافعين في المجتمع والظروف المناسبة تعني:

- بيئة مناسبة صحياً،
- وجود الأنشطة اللاصفية {*الرياضية والفنية والأدبية والمهارية والاجتماعية*}.
- التزام المعلمين والادارات المدرسية بالسلوك الحسن كونهم القدوة للتلاميذ والطلبة.
- عدم اتباع أساليب العنف والعقوبات المهينة أو الاستهزاء او التمييز مع

التلاميذ والطلبة.

- وجود علاقة تواصل ودية بين الهيئات التعليمية والطلبة واولياء الأمور.
- تفعيل دور المرشد التربوي في المدارس كونه المحطة الأولى والأهم في التعامل مع التلاميذ والطلبة المشكلين لحل مشاكلهم بالتعاون مع ذويهم والادارة واحالة من يحتاج منهم الى المركز الصحي لغرض التشخيص والمعالجة.

5- التعاون مع مسؤول الصحة المدرسية في مركز الرعاية الصحية الأولية للقيام بفعاليات التوعية والتدريب للهيئات التعليمية ولذوي التلاميذ والطلبة بمعدل ندوة واحدة شهرياً للهيئات التعليمية ولذوي التلاميذ والطلبة.

ملحق (5 د)

الصحة النفسية المدرسية

الأعراض الشائعة للاضطرابات النفسية بين التلاميذ والطلبة

للمدرسة دور كبير في تقديم الرعاية النفسية لابنائنا 000 اذ ان الاكتشاف المبكر للحالات المرضية يساعد في نجاح معالجتها ويسهم في توفير الصحة والطمأنينة للطالب ولعائلته ولضمان مجتمع آمن في المستقبل 00 وفيما يلي ندرج بعض العلامات الشائعة التي تستوجب دراسة حالة الطالب واحالته الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية 00 اذا اصبحت ظاهرة متكررة وعلامة مميزة على التلميذ أو الطالب المعني.

- تراجع مستوى الأداء الدراسي أو الاجتماعي.
- المشاكسة المتكررة، الاعتداء، الحركة الزائدة، مخالفة النظام المدرسي، الغياب، الهروب من المدرسة، الانحراف الجنسي.
- حالات التلعثم والتلكؤ في النطق، الخجل والتردد الشديدين، الخوف والفزع، الاعراض الاكتئابية كالبكاء غير المبرر، نوبات السقوط المتكرر عند الازمات، سلس البول، قضم الاظافر، مص الاصابع، قلع الشعر، اضطراب النوم.
- التدهور والتغير الحديث في الشخصية والسلوك، الاهتمام غير المعقول في امور الحياة النفسية والجديدة والغريبة على شخصية الطالب المعروفة والاهتمامات الفكرية والفلسفية والعلمية المتطرفة او أي اتجاهات اخرى مشابهة.
- الأعراض السايكوسوماتية (النفس/ جسدية) مثل التقيؤ، الإسهال، رفض او شراهة الاكل، التعرق، حركات لاإرادية في الوجه أو الأجفان او الرأس او الأطراف.

ملحق (6)

موجز أسس المقابلة والمشاورة

1. عرف المستفيد بنفسك وطَمئِنهُ بأنك ستعمل لمساعدته.
2. أظهر احترامك الحقيقي للمستفيد.
3. لا تنشغل بأي شيئ عندما يتكلم.
4. احرص على التواصل الودي المريح بالنظر.
5. التزم الهدوء والأسترخاء وبكل ما يطمئن المستفيد.
6. إبدأ بموضوع عام عن حالة المستفيد وبسؤال مفتوح.
7. كن متعاطفاً مع المستفيد أي تفهم وتصور كيف يشعر المرء بهذا الموقف وأظهر تشاعرك (تعاطفك) له، ولكن لا تكن عطوفاً ولا تنجرف بمشاعرك نحوه فتحزن معه أو تغضب او تكره معه.
8. استخدم الايحاءات والإيماءات والاستجابات التي تظهر للمستفيد إهتمامك به وبأنك مصغ له وتمنحه الوقت اللازم.
9. وفر للمستفيد فرصة التحدث بدون وجود أحد من أهله، كما حاول أيضاً أن تتحدث مع الأقارب.
10. أعد التفكير بما يقوله المستفيد وأوجزه للمستفيد لتتأكد من صحة فهمك لما يعنيه.
11. تجنب استخدام الكلمات التي تبدو وكأنها تعني أحكاماً.
12. سجل الملاحظات المهمة للعودة لها عند الحاجة.
13. حين تقدم خدمة المشاورة والأرشاد النفسي فتذكر:

أ- انك لا تقرر الحل لمشكلة المراجع وانما تساعده لإعادة ترتيب أفكاره بشكل منتظم ليختار الحل الأنسب له هو بنفسه.

ب- ساعده على اكتشاف مصادر الدعم المتيسرة والتي يمكنه الاستفادة منها لتجاوز مشكلته.

ت- ان تجزئة المشكلة لعدة مشاكل أصغر يساعد في تيسير حلها، ويفضل البدء بحل المشكلة الجزئية الأهم.

ملحق (7)

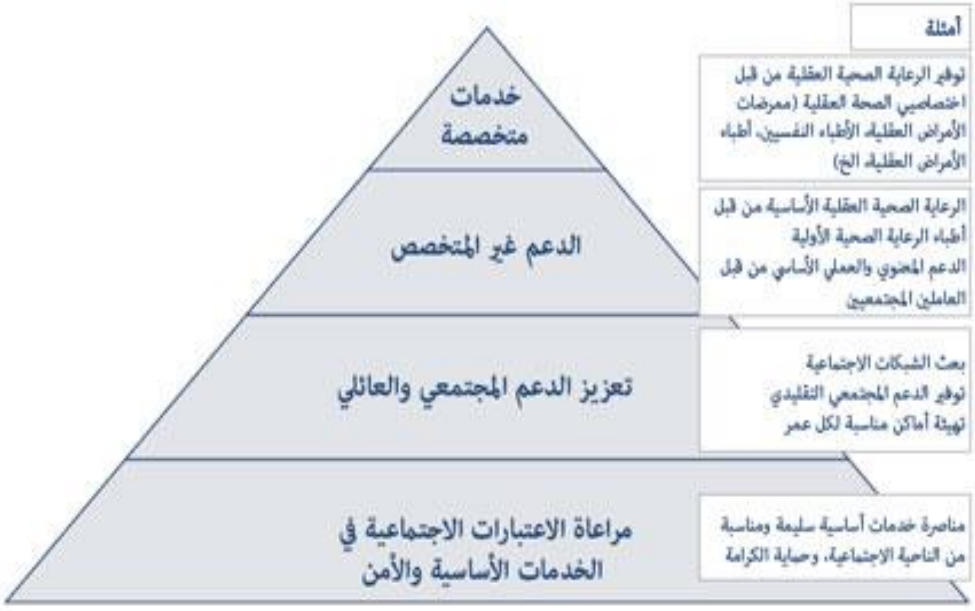
العقاقير النفسية التي يجوز وصفها في مراكز الرعاية الصحية الأولية

- يوصى الطبيب العام *(الذي سبق تدريبه نظرياً وسريرياً لتقديم خدمات الصحة النفسية)* بوصف هذه الأدوية لمدة أسبوعين فقط ويجب إحالة المريض لاختصاصي النفسية قبل إعادة وصفها. *(انتباه رجاءاً: قد يتغير هذا الجدول تبعاً للمستجدات العلمية وللموارد المتاحة)*
- يجب إعادة الاستشارة دورياً *(خلال ثلاثة اشهر كحد أعلى)* .
- في حال حصول اعراض جانبية من مجموعة الادوية المضادة للذهان (فينوثايازين) ومنها التشنجات العضلية يتوجب اضافة مادة البروسايكلدين (كيمادرين) الى العلاج.

الاضطرابات	العقاقير	قوة الدواء	الجرعة
الانفعالية كالقلق، الوسواس وغيرها	حبوب: - دايزيبام (فاليوم) - كلوردايزيبوكسايد(لبريوم) - ترايفلوبيرازين (ستيلازين) - كلوربرومازين(لارجكتيل) - كلوميبرامين (انافرانيل)	 - (2) و (5) ملغم - (5) و (10) ملغم - (1) ملغم - (10) و(25) ملغم - (10) و(25) ملغم	 - 3×1 - 3×1 - 2×1 او 3×1 - 2×1 او 3×1 - 2×1 او 3×1
الكآبة	- حب امبرامين (توفرانيل) - حب امتربتلين (تربتزول) - كبسول فلو كستين (بروزاك)	- (1) و(25) ملغم - (10)و(25) ملغم - (20) ملغم	- مرة واحدة ليلاً وتزاد الجرعة تدريجياً - مرة واحدة ليلاً - 1×1 أو2×1
الذهانية	- حب أولانزابين (زايبركسا) - حب هالوبيريدول (سرنيز)	- (5) ملغم - (1,5) و (5) ملغم	- 2×1 - 2×1 أو3×1
الأعراض الجانبية للعلاج	- حب بروسكايكلدين (كيمادرين) - ابر بروسايكلدين	- (5) ملغم - (10) مغم	- 2×1 أو3×1 - Im& iv (slowly) (حسب الأبر المتوفرة)
الصرع	- كارباماز بين (تكريتول) - فينوباريتون (لومينال) - صوديوم فالبروات (ديباكين)	- (200) ملغم - (15 - 30) ملغم - (200) ملغم	تحدد الجرعة حسب وصف الطبيب الاختصاصي.
الطوارئ النفسية (الهلع، التهيج، الهوس، إلخ..)	أبر (امبول): - دايزيبام (فاليوم) - كلوربرومازين(لارجكتيل) - هالوبريدول (سرنيز) - ابر بروسايكلدين	- (10) ملغم - (50) ملغم - (5) ملغم - (10) مغم	- im& iv (slowly) - im - im& iv (slowly) - im& iv (slowly) (حسب الأبر المتوفرة)

ملحق (8)

هرم خدمات الدعم النفسي



المصدر: الفريق المرجعي للجنة المراقبة المشتركة بين الوكالات المعني بالصحة العقلية والدعم النفسي، عام ٢٠١٠

الفهرس

الموضوع	الكاتب	الصفحة
قبل أن نبدأ		5
المقدمة		7
الرعاية النفسية الأولية	د. اياد نوري فتاح	9
الصحة النفسية والاضطراب النفسي	د. اياد نوري فتاح	15
مفاهيم عامة في الطب النفسي:	د. عبد المناف الجادري	21
• تصنيف الاضطرابات النفسية		21
• أسباب الاضطرابات النفسية		24
• الأعراض النفسية الشائعة		26
• تشخيص الاضطرابات النفسية		29
طرق العلاج في الطب النفسي	د. محمد السامرائي	30
النمو النفسي	د. اياد نوري فتاح د. عبد المناف الجادري	34
الطوارئ الطبية النفسية	د. عبد المناف الجادري	41
الأضطرابات النفسية العضوية	د. طارق صادق خماس	45
الاضطرابات الذهانية	د. طارق صادق خماس	47
الاضطرابات الوجدانية (المزاجية)	د. علي الربيعي	51
الاضطرابات الانفعالية	د. عبد المناف الجادري	57
الاضطرابات النفسية الخاصة بالمرأة	د. رعد الخياط	68
اضطرابات الأطفال النفسية	د. نصيف الحميري	72
عسر التعلم	د. سوسن الجلبي	81
بطء التعلم	د. باسم داؤود صادق	84

اضطرابات الشخصية	د. علي الربيعي	87
الصرع	د. عبد المناف الجادري	92
العلاقة بين الطبيب والمريض والاتصال	د. اياد نوري فتاح	99
المشاورة والارشاد النفسي	د. اياد نوري فتاح	102
العنف	د. اياد نوري فتاح	104
الرعاية النفسية للناجين من الكوارث	د. اياد نوري فتاح	109
الملاحق		113
االفهرس		131

فهرس الملاحق

رقم الملحق	اسم الملحق	الصفحة
1	موجبات دمج الخدمات النفسية في الرعاية الأولية	114
2	عناصر الرعاية الصحية النفسية الأولية	116
3	الوصايا الأساسية للتربية النفسية السليمة	118
4	معلومات عامة عن الصحة النفسية	120
5 أ	مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية	122
5 ب	التعليمات التنفيذية لمكتب الخدمات المدرسية	124
5 ج	الرعاية الصحية النفسية المدرسية	125
5 د	الأعراض النفسية الشائعة للتلاميذ والطلبة	127
6	موجز أسس المقابلة والمشاورة	128
7	العقاقير النفسية التي تستعمل في الرعاية الأولية	129
8	هرم خدمات الدعم النفسي	130

شرح صورة الغلاف الخلفي

من العناصر الاساسية اللازمة لتحقيق الصحة النفسية للانسان:

- الجسم السليم (بسلامة أعضائه كافة وخاصة الدماغ).
- الدفء العائلي الذي يوفر السكينة وأجواء المودة والرحمة.
- التربية والتعليم المناسبين للعلم ولقيم ومعتقدات المجتمع.

أبعاد الصحة النفسية:

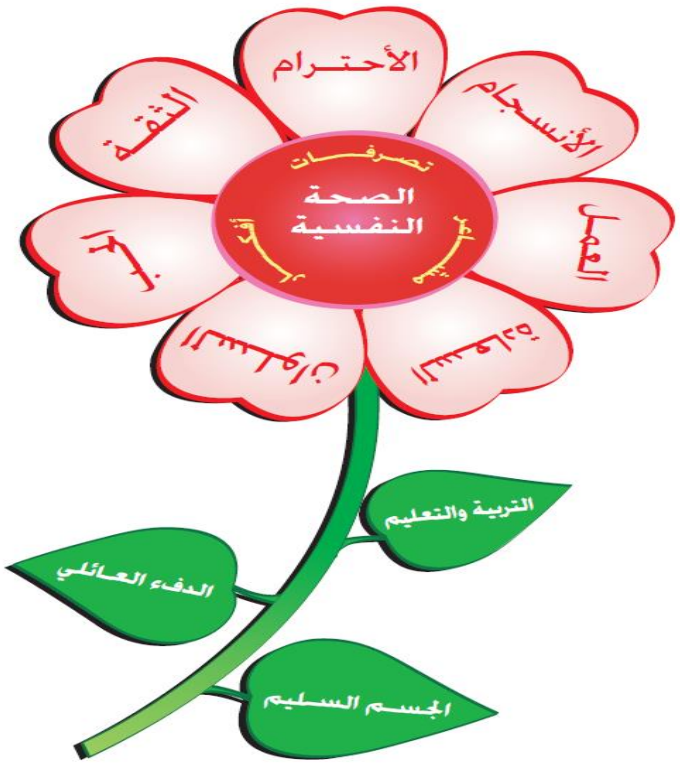
- أفكار
- مشاعر
- تصرفات (سلوك)

ومن علامات الصحة النفسية للفرد:

- انسجام افكار ومشاعر المرء وسلوكه، وانسجامها مع قيم المجتمع السائدة.
- احترام الانسان لنفسه وللآخرين والقدرة على كسب احترامهم.
- الثقة بالنفس والثقة المناسبة بالآخرين والقدرة على أن يكون موضع ثقتهم.
- حب الآخرين والحصول على حبهم والتعاون المشروع معهم.
- القدرة على الاحساس بالسعادة والرغبة في إسعاد عائلته والآخرين.
- القدرة على العمل والانتاج المثمر لتطوير نفسه ومحيطه.
- السلوان، ونعني به هنا: القدرة على الثبات وتحمل ضغوط الحياة ومداواة الذات وتجاوز الأزمات النفسية.

تصميم الغلاف: د. اياد نوري فتاح

الصحة النفسية
سر تألق الفرد
ومفتاح رقي المجتمع



NO HEALTH
WITHOUT MENTAL HEALTH